

ASAHI Gaia Next

PCI Guide Wire

SYMBOLS	1
English [EN]	4
Dansk [DA]	7
Nederlands [NL]	10
Suomi [FI]	13
Français [FR]	16
Deutsch [DE]	19
Ελληνικά [EL]	22
Magyar [HU]	25
Italiano [IT]	28
Polski [PL]	31
Português [PT]	34
Español [ES]	37
Svenska [SV]	40
Česky [CS]	43
Norsk [NO]	46
Slovenský [SK]	49
Eesti keel [ET]	52
Latviešu [LV]	55
Lietuvių kalba [LT]	58
Türkçe [TR]	61
Русский [RU]	64
Български [BG]	67
Hrvatski [HR]	70
Română [RO]	73
Slovenščina [SL]	76
Malti [MT]	79

SYMBOLS

English	Dansk	Nederlands	Suomi	Français	Deutsch	Ελληνικά	Magyar	Italiano
 Legal manufacturer	Autoriseret producent	Wettelijke fabrikant	Laillinen valmistaja	Fabricant légal	Juristischer Hersteller	Νόμιμος κατασκευαστής	Hivatalos gyártó	Produttore legale
 Do not use if package is damaged	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Nicht verwenden, falls Packung beschädigt ist	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	Ne alkalmazza az cszközt, ha a csomagolás sérült.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
 Do not reuse	Må ikke genbruges	Niet opnieuw gebruiken	Älä käyttää uudelleen	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	Μην επαναχρησιμοποιήσετε	Ne használja újból.	Non riutilizzare
 Do not resterilize	Må ikke resteriliseres	Niet opnieuw steriliseren	Älä steriloi uudelleen	Ne pas restériliser	Nicht erneut sterilisieren	Μην επανααστεριώσετε	Ne fertőtlenítsé újbóli használathoz.	Non risterilizzare
 Caution, consult accompanying documents	Forsigtig, se de medfølgende dokumenter	Let op, zie bijgevoegde documentatie	Varoituis, katso mukana toimitetut asiakirjat	Avertissement, consulter la documentation d'accompagnement	Vorsicht, beiliegende Dokumente beachten	Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα	Figyelem, olvassa el a mellékelt dokumentumokat	Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento
 Use by	Anvendes inden	Uiterste gebruiksdatum	Viimeinen käyttöpäivä	Expiration	Verwenden bis	Χρήση από	Lejártat	Utilizzare entro
 Keep dry	Opbevares tørt	Droog bewaren	Pidä kuivana	À conserver au sec	Vor Nässe schützen	Διατηρήστε το στεγνό	Száraz helyen tárolja	Conservare in luogo asciutto
 Keep away from sunlight	Undgå direkte sol	Niet aan zonlicht blootstellen	Pidä poissa auringonvalosta	À conserver à l'abri de la lumière	Vor Sonneneinstrahlung schützen	Κρατήστε το μακριά από το φως του ήλιου	Tartsa távol napfénytől	Tenere lontano dai raggi solari
 Authorized Representative in the European Community	Autoriseret representant i EU	Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella	Représentant habilité dans la Communauté européenne	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségekben	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
 LOT number	Lotnummer	Partijnummer	Eränumero	Numéro de LOT	Losnummer	Αριθμός παρτίδας	Helyrajzi szám	Numero di LOTTO
 Catalogue number	Katalognummer	Catalogusnummer	Tuotenumero	Numéro de référence	Katalognummer	Αριθμός καταλόγου	Katalógusszám	Numero di catalogo
 Sterilized using ethylene oxide	Steriliseret med ethylenoxid	Gesteriliseerd met ethylenoxide	Steriloitu etyleenioksidilla	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Αποστειρώνεται με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου	Etílen-oxidálal fertőtlenítenve	Sterilizzato mediante ossido di etilene
 Unit	Produkt	Eenheid	Määrä	Unité	Einheit	Μονάδα	Egység	Unità
 Consult instructions for use or consult electronic instructions for use	Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning	Zie de (elektronische) gebruiksaanwijzing	Katso käyttöohjeet tai sähköiset käyttöohjeet	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi en format électronique	Bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung oder die elektronische Gebrauchsanweisung lesen	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης.	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót	Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche
 Pre-shaped	Præformet	Voorgevormd	Valmiiksi muotoiltu	Préformé	Vorgeformt	Προδιαμορφωμένο	Előre kialakított	Presagomato
 Pre-shaped	Præformet	Voorgevormd	Valmiiksi muotoiltu	Préformé	Vorgeformt	Προδιαμορφωμένο	Előre kialakított	Presagomato
 Medical device	Medicinsk udstyr	Medisch instrument	Lääkinnällinen laite	Dispositif médical	Medizingerät	Ιατρική συσκευή	Orvostechikai eszköz	Dispositivo medico
 Single sterile barrier system	Enkelt sterilt barriersystem	Enkelvoudig steriel barriersysteem	Yksinkertainen steriili estejärjestelmä	Système de barrière stérile unique	Individuelles Sterilbarriersystem	Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού	Egyszeres steril gátrendszer	Sistema a barriera sterile singola
 Contains hazardous substances	Indeholder farlige stoffer	Bevat gevaarlijke stoffen	Sisältää haitallisia aineita	Contient des substances dangereuses	Enthält gefährliche Inhaltsstoffe	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες	Veszélyes anyagot tartalmaz	Contiene sostanze pericolose
 Importer	Importør	Importeur	Maahantuoja	Importateur	Importeur	Εισαγωγέας	Importőr	Importatore

	Polski	Português	Español	Svenska	Česky	Norsk	Slovenský	Eesti keel	Latviešu
	Legalny producent	Fabricante legal	Fabricante legal	Juridisk tillverkare	Výrobce	Produsent	Legálny výrobca	Juridiline tootja	Likumīgs ražotājs
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	No lo utilice si el envase está dañado	Använd inte om förpackningen är skadad	V případě, že je obal poškozený, výrobek nepoužívejte	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Nepoužívajte, ak je poškodený obal.	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud	Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts
	Nie używać ponownie	Não reutilizar	No lo reutilice	Får inte återanvändas	Nepoužívejte opakovaně	Må ikke gjenbrukes	Nepoužívajte opakovane.	Mitte korduvalt kasutada	Nelietojiet atkārtoti
	Nie sterylizować ponownie	Não reesterilizar	No lo reesterilice	Får inte omsteriliseras	Nesterilizujte opakovaně	Må ikke resteriliseres	Znovu nesterilizujte.	Mitte uuesti steriliseerida	Nesterilizējiet atkārtoti
	Uwaga, zapoznać się z dołączonymi dokumentami	Cuidado, consulte os documentos anexos	Precaución, consulte los documentos que se incluyen	Varning, läs medföljande dokument	Upozornění – přečtěte si přívodní dokumentaci	Forsiktig, se vedlagte dokumenter	Upozornenie, pozrite si spríevodné dokumenty.	Ettevaatust! Lugege seadmega kaasasolevaid juhendeid.	Ievērojiet piesardzību, skatiet komplektācijā iekļauto dokumentāciju
	Data ważności	Utilizar até	Fecha de caducidad	Använd före	Spotřebujte do	Brukes innen	Dátum expirácie	Aegumiskupaäev	Izmantot līdz
	Chronić przed wilgocią	Manter seco	Manténgalo seco	Förvaras torrt	Uchovávejte v suchu	Må oppbevares tørt	Udržiavajte v suchu.	Hoida kuivas	Uzturiet sausu
	Chronić przed światłem słonecznym	Manter distante da luz do sol	Manténgalo alejado de la luz del sol	Håll undan från solljus	Chraňte před slunečním světlem	Må ikke oppbevares i sollys	Nevystavujte slnečnému svetlu.	Hoida eemal päikesevalgusest	Sargāt no saules gaismas
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Auktoriserad representant i EU	Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii	Autorisert representant i Det Europeiske Fellesskapet	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Numer partii	Número de LOTE	Número del lote	LOT-nummer	Číslo šarže	Parti/Batchnummer	Číslo šarže	Partii number	Partijas numurs
	Numer katalogowy	Número de catálogo	Número del catálogo	Katalognummer	Katalogové číslo	Katalognummer	Katalógové číslo	Kataloogi number	Kataloga numurs
	Sterylny z tworzywa sztucznego	Esterilizado com óxido de etileno	Esterilizado con óxido de etileno	Steriliserad med etylenoxid	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu	Sterilisert med etylenoksid	Sterilizované pomocou etylénoxidu.	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	Sterilizēts, izmantot etilēnoksīdu
	Jednostka	Unidade	Unidad	Enhet	Jednotka	Enhet	Jednotka	Üksus	Vienība
	Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub z elektroniczną instrukcją użytkowania	Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónicas	Consulte las instrucciones de uso en papel o en formato electrónico.	Se bruksanvisningen eller elektronisk bruksanvisning	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití	Se bruksanvisningen eller se elektroniske instruksjoner for bruk	Prečítajte si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie	Lugege kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit	Skatiet lietošanas norādījumus vai elektroniskos lietošanas norādījumus
	Wstępnie formowany	Pré-moldado	Preconformado	Förhandsformad	Tvarovaný	Forhåndsformet	Predtvarovaný	Eelvormitud	Iepriekš izveidota forma
	Wstępnie formowany	Pré-moldado	Preconformado	Förhandsformad	Tvarovaný	Forhåndsformet	Predtvarovaný	Eelvormitud	Iepriekš izveidota forma
	Wyrób medyczny	Dispositivo médico	Dispositivo médico	Medicinteknisk produkt	Zdravotnický prostředek	Medisinsk enhet	Zdravotnícka pomôcka	Meditsiiniseade	Medicīnas ierīce
	System pojedynczej sterylnej bariery	Sistema de barreira estéril único	Sistema de barrera estéril único	Enkelt sterilt barriärsystem	Jednoduchý sterilní bariérový systém	Enkelt sterilt barrieresystem	Systém jednej sterilnej bariéry	Ühekordne steriilse barjääri süsteem	Vienas sterilās barjeras sistēma
	Zawiera substancje niebezpieczne	Contém substâncias perigosas	Contiene sustancias peligrosas	Innehåller farliga ämnen	Obsahuje nebezpečné látky	Inneholder farlige stoffer	Obsahuje nebezpečné látky	Sisaldab ohtlikke aineid	Satur bīstamas vielas
	Importer	Importador	Importador	Importör	Dovozce	Importør	Dovozca	Importija	Importētājs

	Lietuvių kalba	Türkçe	Русский	Български	Hrvatski	Română	Slovenščina	Malti
	Teisėtas gamintojas	Yasal üretici	Официальный производитель	Легален производител	Proizvodač	Producător legal	Legalni proizvajalec	Manifattur legali
	Jeigu pažeista pakuotė, naudoti negalima	Ambalajı hasar görmüşse ürünü kullanmayın	Не использовать, если упаковка повреждена	Не използвайте, ако опаковката е повредена	Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno	A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana	Tużax jekk hemm hsara fil-pakkett
	Nenaudoti pakartotinai	Tekrar kullanmayın	Повторное использование запрещено	Да не се използва повторно	Nemojte ponovno koristiti	A nu se refolosi	Ne uporabljajte ponovno	Tużax iktar minn darba
	Nesterilizuoti pakartotinai	Tekrar sterilize etmeyin	Повторная стерилизация запрещена	Да не се стерилизира повторно	Nemojte ponovo sterilizirati	A nu se resteriliza	Ne sterilizirajte ponovno	Tisterilizax mill-ġdid
	Dėmesio, žr. kartu pateikiamus dokumentus	Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın	Внимание! См. сопроводительные документы	Внимание, консултирайте се с придружаващите документи	Oprez, pogledati prateće dokumente	Atenție, a se consulta documentele de însoțire	Pozor, glejte spremlne dokumente	Attenzjoni, ikkonsulta d-dokumenti ta' akkumpanjament
	Tinka iki	Son kullanma tarihi	Срок годности	Използвайте до	Upotrijebiti do	A se utiliza de către	Uporabno do	Uża sa
	Laikyti sausai	Kuru tutun	Не допускать попадания влаги	Пазете сухо	Čuvati na suhom	A se păstra uscat	Hraniti na suhem	Żommx niexef
	Saugoti nuo saulės šviesos	Güneş ışığından uzak tutun	Не допускать попадания солнечного света	Пазете от слънчева светлина	Čuvati dalje od sunčevog svjetla	A se păstra departe de lumina soarelui	Hranite stran od sončne svetlobe	Żommx 'il boghod mid-dawl tax-xemx
	Igaliotasi atstovas Europos Bendrijoje	Avrupa Topluluğu'nda Yetkili Temsilci	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	Оторизиран представител в Европската общност	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti	Rappreżentant Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea
	Serijos numeris	LOT numarası	Номер партии	Партиден номер	LOT broj	Număr LOT	LOT številka	Numru tal-LOTT
	Katalogo numeris	Katalog numarası	Номер по каталогу	Каталожен номер	Kataloški broj	Număr de catalog	Kataloška številka	Numru tal-katalogu
	Sterilizuota etileno oksidu	Etilen oksitle sterilize edilmiştir	Стерилизовано этиленоксидом	Стерилизиран чрез этиленов оксид	Sterilizirano etilen oksidom	S-a sterilizat folosind oxid de etilenă	Sterilizirano z etilen oksidom	Sterilizat bl-ossidu tal-etilen
	Elementas	Birim	Упаковка	Изделие	Jedinica pakiranja	Unitate	Enota	Unità
	Žr. naudojimo instrukciją arba elektroninę naudojimo instrukciją	Kullanım talimatlarına bakın veya elektronik kullanım talimatlarına bakın	Ознакомьтесь с инструкцией по применению или ознакомьтесь с электронной инструкцией по применению	Консултирайте се с инструкциите за употреба или вижте електронните инструкции за употреба	Pogledajte upute za uporabu ili pogledajte elektroničke upute za uporabu	A se consulta instrucțiunile de utilizare sau a se consulta instrucțiunile electronice de utilizare	Preberite navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu jew ikkonsulta l-istruzzjonijiet elettronici għall-użu
	Iš anksto suformuotas	Önceden şekillendirilmiş	С предварительно приданной формой	Предварительно оформено	Unaprijed oblikovano	Preformat	Predhodno oblikovano	Preformat
	Iš anksto suformuotas	Önceden şekillendirilmiş	С предварительно приданной формой	Предварительно оформено	Unaprijed oblikovano	Preformat	Predhodno oblikovano	Preformat
	Medicinos priemonė	Tıbbi cihaz	Медицинское изделие	Медицинско изделие	Medicinski proizvod	Dispozitiv medical	Medicinski pripomoček	Apparat mediku
	Vientisa steriliaus barjero sistema	Tekli steril bariyer sistemi	Однaarная стерильная барьерная система	Система с единична стерилна барьерна	Sustav jednostruke sterilne barijere	Sistem unic de bariere sterile	Enojni sterilni sistem pregrad	Sistema ta' barriera sterili unika
	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų	Tehlikeli maddeler içerir	Содержит опасные вещества	Съдържа опасни вещества	Sadrži opasne tvari	Conține substanțe periculoase	Vsebuje nevarne snovi	Fih sustanzji perikolużi
	Importuotojas	İthalatçı	Импортер	Вносител	Uvoznik	Importator	Uvoznik	Importatur

ASAHI Gaia Next PCI Guide Wire

INSTRUCTIONS FOR USE

Read these instructions carefully before using this guide wire and observe the Indications for Use, Contraindications, Warnings, Precautions, and How to Use sections in these Instructions for Use. Failure to do so may result in complications, including serious injury to the patient or death.

If a user or a patient comes to know a serious incident that has occurred in relation to the guide wire, report the fact to the manufacturer and the competent authority.

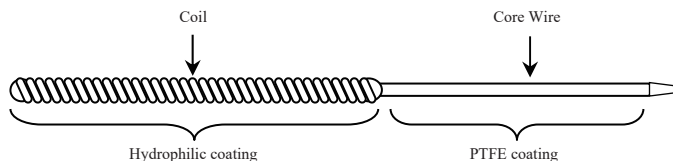
These Instructions for Use apply to the ASAHI Gaia Next. For details (length of the guide wire, length of radiopaque section, etc.), refer to the product label.

Descriptions

This guide wire is a steerable guide wire with a shapeable tip and is available in pre-shaped variants. The outside diameter of the guide wire is 0.36 mm (0.014 inch). This guide wire is compatible with existing balloon dilatation catheters and other interventional devices used in common percutaneous coronary intervention (PCI). The distal portion of the guide wire tip is radiopaque.

For lubricity, the distal portion of the device is coated with a hydrophilic polymer and the proximal portion of the guide wire is coated with polytetrafluoroethylene (PTFE).

At the proximal end of the device, which is less than 300 cm, there is a connection for an extension wire, which is used to replace the combined device; ASAHI INTECC's Extension Wire can be connected, and the total length after connection is 355-400 cm.



Indications for Use

This guide wire is intended for general percutaneous coronary intervention (PCI). It can be used to introduce and position balloon dilatation catheters and other interventional devices within cardiovascular system.

This guide wire is not intended for use in the neurovasculature and peripheral vasculature.

Contraindications

- Confirm the compatibility of guide wire diameter with other interventional device before actual use.
- Do not use the guide wire in patients who have an allergic reaction to contrast media or who have impaired renal dysfunction.
- This guide wire contains PEG400 in its hydrophilic coating. Do not use the guide wire in patients who have allergic reactions to polyethylene glycol (PEG).

- Do not use the guide wire for pregnant patients or patients who may be pregnant (X-ray may affect the fetus).
- This guide wire must be used in an institution where emergency surgical operation can be performed immediately. If an emergency surgical operation is unavailable, in the worst case, life-threatening events may occur.

- This guide wire is presterilized with ethylene oxide gas (EOG) and is intended for single use only. Do not reuse or resterilize. If reused or resterilized, the performance or quality of this guide wire may be compromised and there is a risk of complications, including infection.

Warnings

- This guide wire must be used only by a physician who is fully trained in PCI treatment.
- Never use this guide wire in combination with catheters having metal parts that may directly contact the surface of this guide wire (e.g. atherectomy catheters, metal dilators), metal needles or metal sheath inserters.
- During use of the guide wire, check and monitor the movement of its tip under fluoroscopy. Do

not use in areas of vessel that are not or cannot be visualized.

- Do not connect this guide wire with detachable extension wires produced by manufacturers other than ASAHI INTECC. Do not manipulate this guide wire while the detachable extension wire is connected. Otherwise, the guide wire may be damaged, or the detachable extension wire may be unintentionally detached.
- Do not modify this guide wire for any reason.

Precautions

- Do not use the guide wire after the expiration date indicated on the label. Discard any guide wire that exceeds the expiration date.
- Guide wires are delicate instruments and should be handled carefully.
- If the package is opened or damaged, do not use the guide wire. Do not open the package until just prior to use. Use aseptic technique in handling and using the guide wire.
- Always keep the guide wire in a wet state to prevent damage to its hydrophilic coating.
- Do not wipe this guide wire using an organic solution such as alcohol.
- Take preventive measures against infection after use. Discard this guide wire and package as medical waste.
- Never push, auger, withdraw, or torque this guide wire that meets resistance. Torquing or pushing this guide wire against resistance may cause damage and/or tip separation of this guide wire or direct damage to a vessel. Failure to do so may cause damage to this guide wire. Determine the cause of resistance under fluoroscopy and take any necessary remedial action.
- Always advance or withdraw the guidewires slowly and carefully.
- When torquing this guide wire inside the blood vessel, do not torque continuously in the same direction. When torquing the guide wire, rotate it

clockwise and counterclockwise alternately. Do not rotate more than two rotations (720°) in the same direction.

- Flush the guide wire with heparinized and sterilized saline or other suitable solution while removing and reinserting it to prevent air from entering the interventional device. Perform exchange of this guide wire carefully to prevent air entry and/or trauma. When reintroducing the guide wire, confirm that the interventional device tip is free within the vessel lumen and is not against the vessel wall. Failure to do so may result in trauma. Use the radiopaque marker of the interventional device to confirm position.
- Free movement of the guide wire within the interventional device is an important feature of a steerable guide wire system because it gives the user valuable tactile information. Test the system for any resistance prior to use. Adjust or replace the hemostasis valve with an adjustable valve if it is found to inhibit the guide wire movement.
- Do not perform stent placement using more than one guide wire or wire operation through stent strut. Otherwise, the stent may be damaged or the guide wire may break or break apart.
- Before use, confirm that this guide wire is appropriate in size and shape for the procedure and is compatible with the device to be used in combination.

- Refer to the Instruction for Use attached to the medical device (e.g. balloon dilatation catheters or other interventional devices) to be used in combination with this guide wire.
- When connecting the detachable extension wire with this guide wire, it should be securely inserted to the boundary line between non PTFE coating and PTFE coating at the proximal end of the guide wire. If any abnormality is found in the connection, stop using the guide wire immediately.
- Inspect the guide wire carefully for bends, kinks, or other damage prior to use and whenever

- possible during the procedure. Do not use the guide wire if it is damaged.
- When shaping the tip, be careful not to damage the coil.
- Before inserting the guide wire, check which end is the distal end and make sure to insert it from the distal end.
- Maintain a continuous saline flush between the guiding catheter and the interventional device and between the interventional device and the guide wire during the procedure. Flushing prevents contrast media formation and/or clotting on the guide wire and in the catheter lumen.

Malfunctions and Adverse effects

Possible malfunctions and adverse effects through usage of this guide wire include, but are not limited to the following:

1. Malfunctions

Failure to cross a lesion	Breakage or bending of the guide wire	Damage such as separation
Difficulty in removal	Coming off of coating	

2. Adverse effects

Death	Infection	Vessel dissection
Vessel perforation	Bleeding complications	Embolism
Thrombus	Infarction	Ischemia
Arrhythmia	Vasospasm	Vascular occlusion
Blood pressure reduction	Allergic reaction	Residual

How to Use

1. Inspection prior to use

- Before use, inspect carefully and confirm the guide wire and package are undamaged.
- Before use, confirm that the guide wire is compatible with the interventional devices to be used.

2. Preparation

- Select the most suitable guide wire for the affected area and remove the holder tube containing the guide wire from the sterile pack.
- Fill up the holder tube with heparinized and sterilized saline using a syringe to soak the entire device. Take note that heparinized and sterilized saline may spill out of the holder

tube during at this time.

- Fill the lumen of the interventional device with the heparinized and sterilized saline before inserting the guide wire.
- Release the guide wire from the tail clip and slide the guide wire slowly, push distal end of the guide wire through the holder tube(B).(Figure 1)

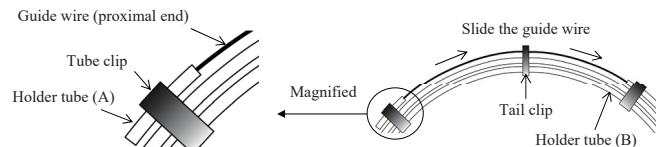


Figure 1

- When the distal end of the guide wire is extended more than 4cm beyond the other end of the holder tube, if necessary, shape the tip in accordance with standard practice.
- Gently grasp the guide wire which came out from the distal end of the holder tube, at the point as close to the holder tube as possible and pull the guide wire out slowly and carefully.
- If resistance is felt when removing the guide wire from the holder tube, inject heparinized and sterilized saline into the holder tube again. Continue removing the guide wire after the resistance is not felt anymore. Be sure to inject enough heparinized and sterilized saline to the holder tube because hydrophilic coating may be damaged when removing the coated guide wire forcefully.
- After pulling the guide wire out of the holder tube, inspect it to make sure that it is not damaged.

3. Procedures for insertion

■ Over-the-wire system

- Insert the distal end of the guide wire carefully into the guide wire lumen of the interventional device.
- Advance this guide wire carefully until its tip is just proximal to the interventional device tip.
- Engage the guiding catheter and insert the interventional device system (with guide wire) into the Y connector.
- Advance the interventional device system through the guiding catheter until the tip of the guide wire system is just proximal to the tip of the guiding catheter.
- Tighten the hemostasis valve of Yd connector to create a seal around the interventional device. Ensure the guide wire

movement is still permitted.

- Check to make sure the guide wire moves smoothly.
- Attach the torque device to the guide wire if necessary.
- Advance this guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.
- Observe the guide wire movement in the vessels.
- Advance the interventional device until the lesion is reached while preventing the guide wire from moving. Ensure that guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

■ Rapid exchange system

- Engage the guiding catheter.
- Insert the guide wire introducer into the Y connector of the guiding catheter.
- Carefully insert the guide wire tip into the introducer.
- Advance the guide wire through the guiding catheter under fluoroscopy until the guide wire tip is just proximal to the tip of the guiding catheter.
- Attach the torque device to the guide wire if necessary.
- Advance the guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.
- Observe the guide wire movement in the vessels.
- Remove the guide wire torque device and the guide wire introducer.
- Track the interventional device over the guide wire while preventing the guide wire

from moving, and advance until the lesion is reached. Ensure that the guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

- a) Remove this guide wire slowly while monitoring the movement of this guide wire under fluoroscopy.
- b) Insert the next guide wire in accordance with the directions in this “How to Use” section.

4. Procedures to exchange the guide wire

■ Over-the-wire system

Storage method

Do not keep the guide wire and package in a bent and/or heavily-loaded condition. This guide wire and package must be kept out of water. Store in a cool, dark, and dry place.

Expiration date

The expiration date is indicated on the label of the guide wire package.

Contents

5 pieces / box

Liability Disclaimer

By no means shall “ASAHI INTECC CO., LTD. and its affiliated companies” (hereinafter referred to as the “Company”) be liable for accidents, personal injuries, adverse effects due to any improper use of the product(s) or any other use inconsistent with these instructions. In no event shall the Company be liable for any damages either (i) arising out of storage of the product(s) after the shipment from the Company or (ii) due to selection of patients, surgery techniques, or any other medical activities by the medical institution that uses the product(s).

“ASAHI Gaia Next” is a trademark or a registered trademark of ASAHI INTECC CO.,LTD. in Japan and other countries.

ASAHI Gaia Next PCI-guidewire

Brugsanvisning

Læs omhyggeligt disse anvisninger for brug af denne guidewire, og overhold indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og afsnittet "Anbefalet procedure" i denne brugsanvisning. Hvis dette undlades, kan det medføre komplikationer, herunder alvorlig kvæstelse af patienten eller dødsfald.

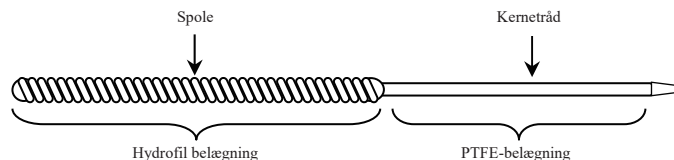
Når en bruger eller en patient bliver bekendt med en alvorlig hændelse, der er sket på grund af guidewiren, skal dette indberettes til producenten og myndighederne.

Disse brugsanvisninger vedrører ASAHI Gaia Next. Nærmere specifikationer (længden af guidewiren, længden af den røntgenfaste del mv.) fremgår af mærkaten på produktpakken.

Beskrivelser

Denne guidewire er en kontrollerbar guidewire med en formbar spids og fås i præformede varianter. Guidewirens udvendige diameter er 0,36 mm (0,014 tommer). Denne guidewire er kompatibel med nuværende kateter til ballonudvidelse og andet interventionelt udstyr, der anvendes ved almindelig perkutan koronar intervention (PCI). Den distale del af spidsen af guidewiren er røntgen nuanceret.

For at opnå smidighed er den distale del af anordningen belagt med en hydrofil polymer, og den proximale del af guidewiren er belagt med polytetrafluoroethylen (PTFE). Ved den proximale ende af enheden, som er mindre end 300 cm, er der en forbindelse til en forlængerledning, som anvendes til at erstatte den samlede enhed; ASAHI INTECCs forlængerledning kan tilsluttes, og den samlede længde efter tilslutning er 355-400 cm.



Indikationer for brug

Denne guidewire er beregnet til generel perkutan koronar intervention (PCI). Den kan bruges til at indføre og placere kateter til ballonudvidelse og andet interventionelt udstyr i kardiiovaskulær.

Denne guidewire er ikke beregnet til brug i neurovaskulær og den perifere vaskulær.

Kontraindikationer

- Bekræft, at diametren af guidewiren er kompatibel med andet interventionelt udstyr, før den anvendes.
- Brug ikke guidewiren til patienter, der har en allergisk reaktion over for kontrastmidler eller har nedsat nyrefunktion.
- Denne guidewire indeholder PEG400 i sin hydrofile belægning. Brug ikke guidewiren på patienter, der har allergiske reaktioner over for polyethylenglycol (PEG).

- Brug ikke guidewiren til gravide patienter eller patienter, der kan være gravide (røntgenstråler kan påvirke fosteret).
- Guidewiren skal bruges på institutioner, hvor det er muligt øjeblikkeligt at udføre akutte kirurgiske indgreb. Hvis det ikke er muligt at udføre akutte kirurgiske indgreb, kan der i værste fald forekomme livstruende situationer.
- Guidewiren er præsteriliseret med ethylenoxidgas (EOG) og er udelukkende beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges eller resteriliseres. Genbrug eller resterilisering af guidewiren kan have en negativ indvirkning på guidewiren og/eller emballagen og dermed på funktionen og kvaliteten, og der vil være risiko for komplikationer, herunder infektioner.

Advarsler

- Guidewiren må kun bruges af en læge, der er fuldt uddannet i PCI-behandling.
- Brug aldrig denne guidewire i kombination med kateter med metaldele, der kan berøre overfladen af denne guidewire direkte (f.eks. kateter til atharektomi, dilatatorer af metal), metalnåle eller indsatser af metalskeder.
- Under brug af guidewiren skal spidsens bevægelse kontrolleres og overvåges under fluoroskopi. Må ikke anvendes i dele af kar, der ikke er iagttaget eller anjagttages.
- Guidewiren må ikke sammenkøbes med aftagelige forlænger-wire, der er fremstillet af andre producenter end ASAHI INTECC. Guidewiren må ikke manipuleres, mens den aftagelige forlænger-wire er koblet til. I modsat fald kan guidewiren blive beskadiget, eller den aftagelige forlænger-wire kan løsnes utilsigtet.
- Guidewiren må ikke ændres uanset grunden.

Forholdsregler

- Guidewiren må ikke anvendes efter udløbsdatoen på mærkaten. Kassér alle guidewires, der har overskredet udløbsdatoen.
- Guidewires er skrøbelige instrumenter, der skal behandles forsigtigt.
- Guidewiren må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget. Emballagen må først åbnes lige inden brug. Guidewiren skal håndteres og anvendes aseptisk.
- Hold altid guidewiren våd for at undgå beskadigelse af den hydrofile belægning.
- Undlad at aftørre guidewiren med en organisk opløsning, som f.eks. sprit.
- Træf forebyggende foranstaltninger mod infektion efter anvendelse. Kassér guidewiren og emballagen som medicinsk affald.
- Guidewiren må aldrig skubbes, drejes, trækkes ud eller vrides rundt, hvis der mærkes modstand. Hvis guidewiren vrides rundt eller skubbes til på trods af modstand, kan det beskadige spidsen af guidewiren, og/eller få spidsen til at gå af, eller det kan direkte medføre skade på karret. Hvis du ikke gør det, kan det beskadige denne guidewire. Find årsagen til modstanden under gennemlysning, og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.
- For eller træf altid guidewiren langsomt og forsigtigt frem eller tilbage.
- Når guidewiren vrides rundt inde i blodkarret, må den ikke konstant vrides i samme retning. Guidewiren skal skiftevis vrides med og mod uret. Guidewiren må ikke drejes mere end to gange (op til 720°) rundt i samme retning.
- Skyl guidewiren med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning eller anden velegnet opløsning, samtidig med at den tages ud og føres ind igen for at hindre luft i at komme ind i interventionsudstyret. Udvis forsigtighed under udskiftning af guidewiren, så der ikke kommer luft ind og/eller forårsages skade. Under genindføring af guidewiren skal det sikres, at spidsen, der bruges til indgrebet, ligger frit inde i karrets lumen, og at den ikke ligger op mod karvæggen. I modsat fald kan der opstå traumer. Brug den røntgenfaste markør på interventionsudstyret til at fastslå positionen.
- Det er en vigtig del af det styrbare guidewiresystem, at guidewiren kan bevæge sig frit inde i interventionsudstyret, da brugeren derved kan føle sig frem til væsentlige informationer. Afprøv systemet for brug for at se, om der er modstand. Regulér, eller udskift hæmostaseventilen med en regulær ventil, hvis den viser sig at begrænse guidewirens bevægelsesmuligheder.
- Anlæg ikke nogen stent ved hjælp af flere end én guidewire, og for ikke guidewiren gennem

stentens stivere. Ellers kan stenten blive beskadiget eller guidewiren kan lide skade eller gå i stykker.

- Før brug skal det bekræftes, at denne guidewire har en hensigtsmæssig størrelse og form til proceduren og er kompatibel med den enhed, den skal bruges sammen med.
- Se brugsanvisningen, der er vedlagt det medicinske udstyr (f.eks. kateter til ballonudvidelse eller andet interventionelt udstyr), der skal bruges sammen med denne guidewire.
- Når den aftagelige forlænger-wire kobles til denne guidewire, skal den sættes godt fast til grænsefladen mellem den belægning, der ikke er PTFE, og den belægning, der er PTFE, ved guidewirens proximale ende. der konstateres en

afvigelse i forbindelsen, skal du straks stoppe med at bruge guidewiren.

- Se omhyggeligt efter, om guidewiren er bøjet, knækket eller på anden vis beskadiget før brug, og når det kan lade sig gøre under indgrebet. Brug ikke guidewiren, hvis den er beskadiget.
- Når du former spidsen, skal du være forsigtig med ikke at beskadige spolen.
- Før du indsætter guidewiren, skal du kontrollere, hvilken ende der er den distale ende, og sikre dig, at du indsætter den fra den distale ende.
- Der skal opretholdes en kontinuerlig saltvandsskyllning mellem kateteret til indføring og interventionskateteret og mellem interventionskateteret og guidewiren under proceduren. Skyllning forhindrer, at der dannes kontraststoffer og/eller koaguleringer på guidewiren og i lumen i kateteret.

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser, der kan forekomme ved brugen af denne guidewire omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

1. Fejlfunktioner

Mislykket krydsning af læsion	Brud eller bøjning af guidewiren	Skader såsom adskillelse
Vanskeligheder med at fjerne	Belægning forsvinder	

2. Uønskede virkninger

Død	Infektion	Kardissektion
Karperforation	Komplikationer ved blødning	Emboli
Trombe	Infarkt	Ischemia
Arrhythmia	Vasospasme	Vaskulær okklusion
Reduktion af blodtrykket	Allergisk reaktion	Resterende

Anbefalet procedure

1. Undersøg for brug

- Kontrollér omhyggeligt før brug, at guidewiren og emballagen er ubeskadigede.
- Kontrollér for brug, at guidewiren er kompatibel med det interventionsudstyr, der skal anvendes.

2. Klargøring

- Vælg den mest velegnede guidewire til det berørte område, og tag opbevaringsrøret med guidewiren ud af den sterile emballage.

- Fyld opbevaringsrøret med hepariniseret og steriliseret saltvandspølse ved hjælp af en sprøjte for at lægge hele enheden i blod. Vær opmærksom på, at hepariniseret og steriliseret saltvandspølse kan spildes fra opbevaringsrøret på dette tidspunkt.
- Fyld interventionsudstyrets lumen med hepariniseret og steriliseret saltvandspølse, før guidewiren indføres.
- Løsn guidewiren fra endeklipsen, og lad den glide langsomt, idet den distale ende af

guidewiren skubbes gennem opbevaringsrøret

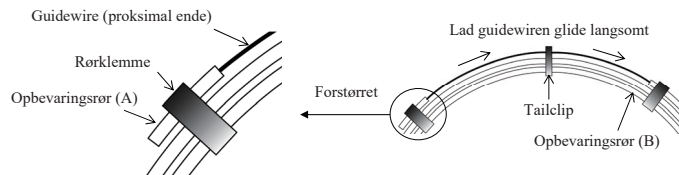


Figure 1

- Når den distale ende af guidewiren rækker mere end 4 cm ud over den anden ende af opbevaringsrøret, formes spidsen eventuelt i henhold til standardpraksis. i henhold til standardpraksis.
- Hold forsigtigt om guidewiren, der kommer ud af den distale ende af opbevaringsrøret. Hold så tæt ved røret som muligt, og træk langsomt og forsigtigt guidewiren ud.
- Hvis der mærkes modstand, når guidewiren tages ud af opbevaringsrøret, injiceres der igen hepariniseret og steriliseret saltvandspølse i opbevaringsrøret. Forsæt med at tage guidewiren ud, når der ikke længere mærkes modstand. Sørg for at injicere tilstrækkelig hepariniseret og steriliseret saltvandspølse i opbevaringsrøret, fordi den hydrofile belægning kan blive beskadiget, når den belagte guidewire tages ud ved anvendelse af for meget kraft.
- Når guidewiren er trukket ud af opbevaringsrøret, skal den undersøges for at sikre, den ikke har lidt skade.

3. Indføringsmetoder

■ Over the wire-metoden

- Før forsigtigt den distale ende af guidewiren ind i guidewire-lumen på interventionsudstyret.
- Fremfør forsigtigt guidewiren, til dens spids er lige netop proksimalt for spidsen af interventionsudstyret.
- Hold i indføringskateteret, og før interventionsudstyret (med guidewire) ind i Y-konnektor.
- Før interventionsudstyret ind gennem indføringskateteret, til spidsen af guidewiren er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskateteret.

(B) (figur 1).

- Spænd hæmostaseventilen på Y-konnektor, så der dannes en forsejling rundt om interventionsudstyret. Sørg for, at guidewiren fortsat kan bevæges.
- Se efter, om guidewiren kan bevæges uhindret.
- Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- Før denne guidewire frem, under gennemlysning, og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mællæsion.
- Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- Før interventionsudstyret frem, til læsionen er nået, samtidig med at guidewires hindres i at bevæge sig. Sørg for, at guidewires distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

■ Hurtig udskiftning

- Hold fast i indføringskateteret.
- Før guidewirens indføringsinstrumentet ind i Y-konnektor på indføringskateteret.
- Før forsigtigt guidewirens spids ind i indføringsinstrumentet.
- Før guidewiren ind gennem indføringskateteret under gennemlysning, til guidewirens spids er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskateteret.
- Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- Før under gennemlysning guidewiren frem og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mællæsion.
- Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- Fjern vrideren til guidewiren og indføringsinstrumentet.

- i) Før interventionsudstyret hen over guidewiren, samtidig med at guidewiren hindres i at bevæge sig, og før det frem, til læsionen er nået. Sørg for, at guidewirens distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

4. Metoder til udskiftning af guidewire

■ Over the wire-metoden

- a) Tag langsomt guidewiren ud, samtidig med at der holdes øje med dens bevægelse under gennemlysning.
- b) Før den næste guidewire ind i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Anbefalet procedure".

Opbevaringsmetode

Opbevar ikke guidewiren og emballagen bøjet eller således, at guidewiren og emballagen udsættes for stor belastning. Denne guidewire og emballagen skal holdes væk fra vand. Opbevares på et køligt, mørkt og tørt sted.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er angivet på etiketten af guidewirens emballage.

Indhold

5 stk. / æske

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder kan “ASAHI INTECC CO., LTD. og dens tilknyttede selskaber” (herefter kaldet “Virksomheden”) gøres ansvarlig for uheld, persontilskadekomst eller bivirkninger der skyldes ukorrekt brug af produktet/produkterne eller enhver anden brug, der ikke følger disse anvisninger. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der enten (i) opstår som følge af opbevaring af produktet efter forsendelse fra Firmaet eller (ii) på grund af valg af patienter, kirurgisk teknik eller andre medicinske aktiviteter, der udføres af den medicinske institution, der bruger produktet.

“ASAHI Gaia Next” er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende ASAHI INTECC CO.,LTD. i Japan og andre lande.

ASAHI Gaia Next Geleidedraad voor PCI

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze geleidedraad gebruikt en neem de hoofdstukken Gebruiksindicaties, Contra-indicaties, Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Aanbevolen procedure in deze Gebruiksaanwijzing in acht. Als u dat niet doet, kunnen er bij de patiënt complicaties optreden, waaronder ernstig letsel, en kan deze zelfs komen te overlijden.

Als een gebruiker of patiënt een ernstig incident waarneemt in verband met de geleidedraad, meld dit dan aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

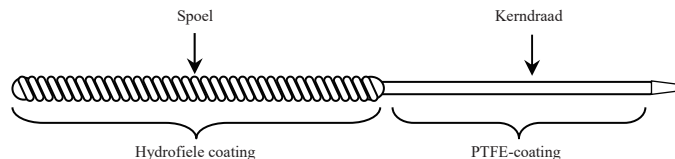
Deze Gebruiksaanwijzing geldt voor de ASahi Gaia Next. Voor de details (lengte van de geleidedraad, lengte van het radiopake gedeelte enz.) verwijzen we naar het productlabel.

Beschrijving

Deze geleidedraad is een stuurbare geleidedraad met een vormbare uiteinde en is verkrijgbaar in voorgevormde varianten. De buitendiameter van de geleidedraad is 0,36 mm (0,014 inch). Deze geleidedraad is compatibel met bestaande ballondilatatiekatheters en andere interventie-instrumenten die gebruikt worden bij gewone percutane coronaire interventie (PCI). Het distale deel van het uiteinde van de geleidedraad is radiopaak.

Ten behoeve van de smering heeft het distale deel van het hulpmiddel een coating met een hydrofiele polymer en het proximale deel van de geleidedraad met polytetrafluorethyleen (PTFE).

Aan het proximale uiteinde van het instrument, op minder dan 300 cm, bevindt zich een aansluiting voor een verlengdraad om het gecombineerde instrument te vervangen. Na aansluiting van de verlengdraad van ASahi INTECC, is de totale lengte 355-400 cm.



Gebruiksindicaties

Deze geleidedraad is bedoeld voor algemene percutane coronaire interventie (PCI). Deze draad kan worden gebruikt om ballondilatatiekatheters en andere interventie-instrumenten in het hartvaatstelsel in te brengen en te positioneren.

Deze geleidedraad is niet bedoeld voor gebruik in het vaatstelsel van het zenuwstelsel en het perifere vaatstelsel.

Contra-indicaties

- Controleer vóór gebruik de compatibiliteit van de diameter van de geleidedraad met andere interventie-instrumenten.
- Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddelen of die een verstoorde nierfunctie hebben.

- Deze geleidedraad bevat PEG400 in zijn hydrofiele coating. Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor polyethyleenglycol (PEG).
- Gebruik de geleidedraad niet bij zwangere patiënten of patiënten die zwanger kunnen zijn (röntgenstraling kan de foetus aantasten).
- Deze geleidedraad moet worden gebruikt in instellingen waar dringende chirurgische ingrepen kunnen worden verricht. Als er geen chirurgische noodingrepen kunnen worden

verricht, kunnen in het ernstigste geval levensbedreigende situaties ontstaan.

- Deze geleidedraad is vooraf gesteriliseerd met ethyleenoxidegas (EOG) en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik of hernieuwde sterilisatie kunnen de prestaties of kwaliteit van deze geleidedraad in het gedrang komen en bestaat het risico op complicaties, waaronder infecties.

Waarschuwingen

- Deze geleidedraad mag uitsluitend worden gebruikt door een arts die volledig bevoegd is PCI-behandelingen uit te voeren.
- Gebruik deze geleidedraad nooit in combinatie met katheters met metalen onderdelen die direct in contact kunnen komen met het oppervlak van deze geleidedraad (bijv. atherectomiekateters of metalen dilatoren), metalen naalden of metalen hulsinbrengers.
- Controleer en bewaak tijdens het gebruik van de geleidedraad de beweging van het uiteinde ervan met behulp van fluoroscopie. Niet gebruiken in

vaatgedeelten die niet zichtbaar zijn of niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.

- Sluit deze geleidedraad niet aan op loskoppelbare verlengdraden die zijn vervaardigd door andere producenten dan ASahi INTECC. Bewerk deze geleidedraad niet las de loskoppelbare verlengdraad is aangesloten. Anders kan de geleidedraad beschadigd raken of kan de loskoppelbare verlengdraad ongewild losraken.
- Breng om geen enkele reden aanpassingen aan deze geleidedraad aan.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de geleidedraad niet na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket. Gooi een geleidedraad waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, weg.
- Geleidedraden zijn delicate instrumenten en er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
- Gebruik de geleidedraad niet wanneer de verpakking open of beschadigd is. Open de verpakking altijd vlak voor gebruik. Gebruik een aseptische techniek bij het werken met en gebruiken van de geleidedraad.
- Houd de geleidedraad altijd nat om beschadiging van de hydrofiele coating te voorkomen.
- Veeg deze geleidedraad niet schoon met een organisch oplosmiddel zoals alcohol.
- Neem na gebruik maatregelen om infecties te voorkomen. Gooi deze geleidedraad en de verpakking weg bij het medisch afval.
- Duw, druk of draai deze geleidedraad niet verder of trek deze niet terug wanneer u op weerstand stuit. Wanneer u deze geleidedraad tegen weerstand in duwt of tordeert, kan dit schade en/of losraken van het uiteinde ervan of directe beschadiging van het bloedvat tot gevolg hebben.

Bovendien kan de geleidedraad beschadigd raken. Stel middels fluoroscopie de oorzaak van de weerstand vast en ondernem de actie die nodig is om deze te verhelpen.

- Geleidedraden moeten altijd langzaam worden ingebracht en teruggetrokken.
- Wanneer u de geleidedraad in het bloedvat tordeert, moet u dat niet voortdurend in dezelfde richting doen. Wanneer u de geleidedraad draait, roter dan afwisselend rechtsom en linksom. Draai nooit meer dan twee volledige omwentelingen (720°) in dezelfde richting.
- Spoel de geleidedraad met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine of een andere geschikte oplossing tijdens het verwijderen en weer invoeren, zodat wordt voorkomen dat er lucht in het interventie-instrument terecht komt. Vervang deze geleidedraad op een zorgvuldige manier zodat binnendringen van lucht en/of trauma's worden voorkomen. Controleer bij het opnieuw invoeren van de geleidedraad of het uiteinde van het interventie-instrument vrij in het vaatlumen kan bewegen en niet tegen de vaatwand zit. Wanneer u dit nalaat, kan dit

leiden tot een trauma. Controleer de positie met behulp van de radiopake markering van het interventie-instrument.

- Vrije verplaatsing van de geleidedraad in het interventie-instrument is een belangrijke eigenschap van een stuurbaar geleidedraadsysteem, omdat het de gebruiker waardevolle tactiele informatie verschaft. Test voorafgaand aan gebruik het systeem op eventuele weerstand. Pas de hemostaseklep aan of vervang deze door een verstelbare klep als blijkt dat deze de beweging van de geleidedraad hindert.
- Plaats geen stent met meer dan één geleidedraad en gebruik de geleidedraad niet door een stentsteun. Zo niet dan kan de stent beschadigd worden of kan de geleidedraad breken of uit elkaar vallen.
- Controleer vóór gebruik of deze geleidedraad qua grootte en vorm geschikt is voor de procedure en compatibel is om samen met het te gebruiken instrument te worden gebruikt.
- Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het medische instrument (bijv. ballondilatatiekatheters of andere interventie-instrumenten) dat samen met deze geleidedraad wordt gebruikt.

- Wanneer u de loskoppelbare verlengdraad op deze geleidedraad aansluit, moet u deze stevig aansluiten op de grenslijn tussen de non- PTFE-coating en de PTFE-coating aan het proximale uiteinde van de geleidedraad. Als er een afwijking in de aansluiting wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de geleidedraad.
- Inspecteer de geleidedraad vóór gebruik en, voor zover mogelijk, ook tijdens de procedure zorgvuldig op buigingen, knikken of andere beschadigingen. Gebruik de geleidedraad niet als deze beschadigd is.
- Let er bij het vormen van het uiteinde op dat u de spoel niet beschadigt.
- Voordat u de geleidedraad inbrengt, moet u controleren welk uiteinde het distale uiteinde is en ervoor zorgen dat u de draad vanaf het distale uiteinde inbrengt.
- Zorg tijdens de procedure voor een continue zoutspoeling tussen de geleidekatheter en het interventie-instrument en tussen het interventie-instrument en de geleidedraad. Spoelen voorkomt contrastmiddelvorming en/of stolling op de geleidedraad en in het katheterlumen.

geleidedraad en de verpakking niet beschadigd zijn.

- Stel voor gebruik vast dat de geleidedraad geschikt is voor de te gebruiken interventie-instrumenten.

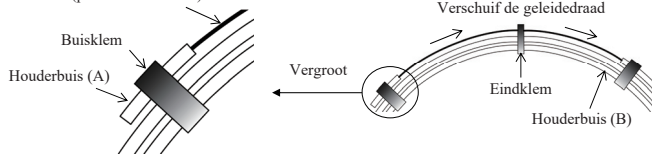
2. Preparatie

- Selecteer de meest geschikte geleidedraad voor het aangedane gebied en neem de houderbuis waarin de geleidedraad zit uit de steriele verpakking.
- Vul de houderbuis met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine met behulp van

een injectienaald om het hele instrument mee nat te maken. Houd er rekening mee dat de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine tijdens het vullen uit de houderbuis kan morsen.

- Vul het lumen van het interventie-instrument met de gesteriliseerde oplossing met heparine voordat u de geleidedraad invoert.
- Maak de geleidedraad los uit de eindklem en schuif de geleidedraad langzaam, duw het distale uiteinde van de geleidedraad door de houderbuis (B). (Afbeelding 1)

Geleidedraad (proximale uiteinde)



Afbeelding 1

- Wanneer het distale uiteinde van de geleidedraad meer dan 4 cm voorbij het andere uiteinde van de houderbuis is geschoven, moet u, indien nodig, het uiteinde volgens de standaardpraktijk vormen.
- Pak de geleidedraad die uit het distale uiteinde van de houderbuis naar buiten is gekomen, voorzichtig zo dicht mogelijk bij de houderbuis vast, en trek de geleidedraad langzaam en voorzichtig naar buiten.
- Als u weerstand voelt bij het uit de houderbuis verwijderen van de geleidedraad, moet u de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine wederom in de houderbuis injecteren. Zet de verwijdering van de geleidedraad voort wanneer u geen weerstand meer voelt. Zorg ervoor dat u voldoende gesteriliseerde zoutoplossing met heparine in de houderbuis injecteert omdat de hydrofiele coating beschadigd kan raken bij een krachtige verwijdering van de gecoatete geleidedraad.
- Wanneer u de geleidedraad uit de houderbuis hebt getrokken, inspecteert u de geleidedraad zodat u zeker weet dat deze niet beschadigd is.

- Voer het distale uiteinde van de geleidedraad voorzichtig in de geleidedraad-lumen van het interventie-instrument in.
- Geleid deze geleidedraad voorzichtig door totdat de tip ervan net proximale is aan het uiteinde van het interventie-instrument.
- Maak de geleidekatheter vast en voer het systeem van het interventie-instrument (met geleidedraad) in de Y-aansluiting.
- Voer het systeem van het interventie-instrument door de geleidekatheter totdat het uiteinde van het systeem van de geleidedraad net proximale is aan de tip van de geleidekatheter.
- Draai de hemostaseklep van de Y-aansluiting dicht zodat een afdichting ontstaat rond het interventie-instrument. Controleer dat verplaatsing van de geleidedraad nog mogelijk is.
- Controleer nogmaals dat de geleidedraad gemakkelijk kan bewegen.
- Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.
- Voer deze geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft

Storingen en negatieve effecten

Mogelijke storingen en negatieve effecten als gevolg van het gebruik van deze geleidedraad zijn onder meer (maar niet uitsluitend) de volgende:

1. Storingen

Onmogelijkheid een laesie te passeren	Brek of buiging van de geleidedraad	Schade zoals scheiding
Moeilijke verwijdering	Loskomen van coating	

2. Negatieve effecten

Overlijden	Infectie	Vaatdissectie
Vaatperforatie	Complicaties in de vorm van bloedingen	Embolie
Trombus	Infarct	Ischemia
Hartritmeestoornis	Vasospasm	Vasculaire occlusie
Verlaagde bloeddruk	Allergische reactie	Residueel

Aanbevolen procedure

1. Inspectie voorafgaand aan gebruik

- Controleer vóór gebruik zorgvuldig of de

3. Procedures voor inbrengen

- Over-de-draad-systeem

gepasseerd.

- i) Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- j) Voer het interventie-instrument in tot de laesie wordt bereikt, terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de locatie ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u het interventie-instrument manipuleert.

■ Systeem voor snelle verwisseling

- a) Bevestig de geleidekatheter.
- b) Voer de geleidedraad-introducer in de Y-aansluiting van de geleidekatheter in.
- c) Voer voorzichtig het uiteinde van de geleidedraad in de introducer in.
- d) Voer de geleidedraad onder fluoroscopie door de geleidekatheter tot het uiteinde van de geleidedraad net proximaal is aan het uiteinde van de geleidekatheter.
- e) Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.
- f) Voer de geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig

door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.

- g) Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- h) Verwijder het torsie-instrument en de introducer van de geleidedraad.
- i) Leid het interventie-instrument over de geleidedraad terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst en ga door tot de laesie is bereikt. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de plaatsing ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u met het interventie-instrument werkt.

4. Procedures voor het verwisselen van de geleidedraad

■ Over-de-draad-systeem

- a) Verwijder deze geleidedraad langzaam terwijl u onder fluoroscopie de verplaatsing van deze geleidedraad in de gaten houdt.
- b) Breng de volgende geleidedraad in volgens de aanwijzingen in dit hoofdstuk "Aanbevolen procedure".

Opslagmethode

Bewaar de geleidedraad en toebehoren niet in een gebogen en/of zwaar belaste toestand. Deze geleidedraad en toebehoren mogen niet nat worden. Bewaren op een koele, donkere en droge plek.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum van de geleidedraad staat vermeld op het etiket van de verpakking.

Inhoud

5 stuks/doos

Aansprakelijkheidsverklaring

Op geen enkele manier zal "ASAHI INTECC CO., LTD." en aan haar gelieerde bedrijven (hierna "Bedrijf" genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, persoonlijke verwondingen, negatieve effecten als het gevolg van een foutief gebruik van het(de) product(en) of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies. Het Bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade (i) voortvloeiend uit de opslag van het product en/of de producten na verzending vanuit het Bedrijf of (ii) als gevolg van de keuze van patiënten, operatietechnieken of enige andere medische activiteiten door de medische instelling die het product en/of de producten gebruikt.

"ASAHI Gaia Next" is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ASAHI INTECC CO.,LTD. in Japan en andere landen.

ASAHI Gaia Next PCI-ohjainvaijeri

Käyttöohjeet

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän ohjainvaijerin käyttöä ja noudata niiden kohtia "Käyttötarkoitukset", "Vasta-aiheet", "Varoitukset", "Varotoimet ennen käyttöä" ja "Käyttö". Muutoin seurauksena voi olla komplikaatioita, mukaan lukien potilaan vakava vammautuminen tai kuolema.

Jos käyttäjä tai potilas havaitsee vakavan vaaratilanteen, joka liittyy ohjainvaijeriin, ilmoita siitä valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

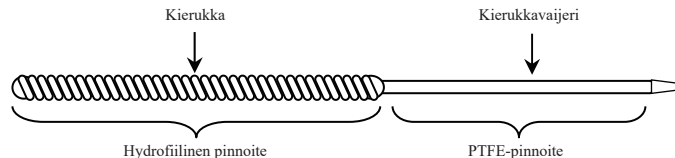
Nämä käyttöohjeet koskevat ASAHI Gaia Next -ohjainvajiereita. Katso lisätiedot (ohjainvaijerin pituus, röntgenpositiivisen osan pituus, jne.) tuotteen etiketistä.

Kuvaus

Tämä ohjainvaijeri on ohjattava ohjainvaijeri, jossa on muotoiltava kärki ja josta on saatavana valmiiksi muotoiltuja vaihtoehtoja. Ohjainvaijerin ulkohalkaisija on 0,36 mm (0,014 tuumaa). Tätä ohjainvaijeria voidaan käyttää yhdessä nykyisten pallolaajennuskatetriin ja muiden tyyppisissä perkutaanisissa sepelvaltimotoimenpiteissä (PCI) käytettävien toimenpidevälineiden kanssa. Ohjainvaijerin kärjen distaalinen osa on röntgenpositiivinen.

Voitelun helpottamiseksi ohjainvaijerin distaalinen osa on pinnoitettu hydrofiilisella polymeerillä ja proksimaalinen osa polyetrafluorieteenillä (PTFE).

Laitteen proksimaalinen pää on alle 300 cm pitkä ja siinä on liitäntä jatkovaijerille, jolla korvataan yhdistetty laite. Ohjainvaijeriin voidaan liittää ASAHI INTECCin valmistama jatkovaijeri ja liittämisen jälkeen laitteen kokonaispituus on 355–400 cm.



Käyttötarkoitukset

Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu tyyppisiin perkutaanisiin sepelvaltimotoimenpiteisiin (PCI). Sillä voidaan viedä sisään ja sijoittaa paikalleen pallolaajennuskatetreja ja muita sydän- ja verisuonitoimenpiteissä käytettäviä toimenpidevälineitä.

Tätä ohjainvaijeria ei ole tarkoitettu käytettäväksi neurovaskulaarisissa eikä ääreisverisuoniston toimenpiteissä.

Vasta-aiheet

- Varmista, että ohjainvaijerin halkaisija sopii yhteen muiden toimenpidevälineiden kanssa, ennen kuin alat käyttää sitä.
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia varjoaineelle tai joilla on munuaisten vajaatoiminta.

- Tämän ohjainvaijerin hydrofiilisessa pinnoitteessa on PEG400:aa. Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia polyeteeniglykolille (PEG).
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat raskaana tai saattavat olla raskaana (röntgenkuvaus voi vaikuttaa sikiöön).
- Tätä ohjainvaijeria saa käyttää vain hoitolaitoksessa, jossa voidaan tarvittaessa tehdä

Varoitukset

- Ohjainvaijeria saa käyttää vain lääkäri, joka hallitsee PCI-toimenpiteen.
- Älä koskaan käytä tätä ohjainvaijeria yhdessä katetriin, joissa on metalliosia, jotka voivat olla suoraan kosketuksessa ohjainvaijerin pinnan kanssa (esim. aterektomiakatrit, metalliset laajentimet), metallineulujen tai metallisten sisäänvientiholkkien kanssa.
- Tarkkaile ohjainvaijerin kärjen liikettä fluoroskopian avulla, kun käytät laitetta. Älä
- käytä ohjainvaijeria verisuonen kohdissa, jotka eivät näy tai joita ei voi kuvantaa.
- Älä kytke tätä ohjainvaijeria muiden kuin ASAHI INTECCin valmistamiin irrotettaviin jatkovaijeriinhin. Älä käsittele ohjainvaijeria, kun siihen on lytketty irrotettava jatkovaijeri. Muutoin ohjainvaijeri voi vaurioitua tai irrotettava jatkovaijeri voi vahingossa irrota.
- Älä muuntele ohjainvaijeria mistään syystä.

Varotoimet ennen käyttöä

- Älä käytä ohjainvaijeria etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivän umpeuduttua. Hävitä ohjainvaijerit, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut.
- Ohjainvaijerit ovat helposti vaurioituvia instrumentteja, minkä vuoksi niitä on käsiteltävä varoen.
- Jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, älä käytä ohjainvaijeria. Avaa pakkaus vasta juuri ennen käyttöä. Käsittele ja käytä ohjainvaijeria aseptisesti.
- Pidä ohjainvaijeri aina märkänä, jotta sen hydrofiilinen pinnoite ei vaurioitu.
- Älä pyyhi ohjainvaijeria orgaanisella liuoksella, kuten alkoholilla.
- Huolehdi infektiotorjunnasta käytön jälkeen. Hävitä ohjainvaijeri ja sen pakkaus sairaalajätteeseen.
- Älä koskaan työnnä, kairaa, vedä tai pyöritä ohjainvaijeria, jos siinä tuntuu vastusta. Ohjainvaijerin pyörittäminen tai työntäminen vastusta vastaan voi aiheuttaa vaurioita ja/tai kärjen irtoamisen ohjainvaijerista tai verisuonen suoran vaurioitumisen. Ohjeen noudattamisen laiminlyönti voi vaurioittaa ohjainvaijeria. Selvitä vastuksen syy fluoroskopian avulla ja poista se tarvittavilla korjaustoimenpiteillä.
- Työnnä ja vedä ohjainvajiereita aina hitaasti ja varovasti.
- Kun pyörität ohjainvaijeria verisuonessa, älä pyöritä sitä jatkuvasti samaan suuntaan. Kun pyörität ohjainvaijeria, pyöritä sitä vuoroin myötä- ja vastapäivään. Pyöritä enintään kaksi täyttä kierosta (720°) samaan suuntaan.
- Huuhtelee ohjainvaijeria heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella tai muulla soveltuvalla liuoksella sen poiston ja sisäänviennin aikana, jotta toimenpidevälineeseen ei pääse ilmaa. Vaihda ohjainvaijeri erityisen varovasti, jotta suoneen ei pääse ilmaa ja/tai se ei vaurioitu. Kun viet ohjainvaijerin uudelleen sisään, varmista, että toimenpidevälineen kärki on vapaana verisuonen lumenissa eikä kosketa verisuonen seinämää. Muutoin se saattaa aiheuttaa vamman. Varmista sijainti toimenpidevälineen röntgenpositiivisiin merkitseminen avulla.
- Ohjainvaijerin vapaa liikkuvuus toimenpidevälineen sisällä on ohjattavan ohjainvaijerin keskeinen ominaisuus, koska se antaa käyttäjälle arvokasta tunteen perustuvaa tietoa. Tarkista järjestelmä vastuksen varalta ennen käyttöä. Jos havaitset hemostaasivienttiilin häiritsevän ohjainvaijerin liikkumista, säädä

hemostaasiventtiiliä tai korvaa se säädettävällä venttiilillä.

- Älä asenna stenttiä käyttäen useampaa kuin yhtä ohjainvaijeria äläkä käytä ohjainvaijeria stentin tuen läpi. Muutoin stentti saattaa vaurioitua ja ohjainvaijeri murtua tai katketa.
- Varmista ennen käyttöä, että tämä ohjainvaijeri on toimenpiteen kannalta sopivan kokoinen ja muotoinen ja että se sopii yhteen sen kanssa käytettävän laitteen kanssa.
- Katso yhdessä ohjainvaijerin kanssa käytettävän lääkinnällisen laitteen (esim. pallolaajennuskatetrin tai muun toimenpidevälineen) käyttöohjeet.
- Kun kytket ohjainvaijeriin irrotettavan jatkovaijerin, työnnä se kunnolla ei-PTFE-pinnoitteeseen ja PTFE-pinnoitteen rajaviivan asti ohjainvaijerin proksimaalisessa päässä. Jos

havaitset kytkennässä jotakin epätavallista, lopeta ohjainvaijerin käyttö välittömästi.

- Tarkista ohjainvaijeri huolellisesti ennen käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen aikana mutkien, taantumisen tai muiden vaurioiden varalta. Älä käytä ohjainvaijeria, jos se on vaurioitunut.
- Varo vahingoittamasta kierukkaa, kun muotoilet kärkeä.
- Tarkista ennen ohjainvaijerin sisäänvientiiä, kumpi pää on distaalinen pää, ja varmista, että viet ohjainvaijerin sisään distaalisesta päästä.
- Pidä yllä toimenpiteen ajan jatkuvaa keittosuolaliuoshuuhdeltua ohjainkatetrin ja toimenpidevälineen sekä toimenpidevälineen ja ohjainvaijerin välillä. Huuhtelu estää varjoaineen kertymisen ja/tai hyuhtymisen ohjainvaijeriin ja katetrin luumeniin.

Toimintahäiriöt ja haittavaikutukset

Ohjainvaijerin käyttöön liittyy muun muassa seuraavia mahdollisia toimintahäiriöitä ja haittavaikutuksia, rajoittumatta kuitenkaan näihin:

1. Toimintahäiriöt

leesion ohittamisen epäonnistuminen	ohjainvaijerin rikkoutuminen tai taipuminen	vaurioituminen, kuten katkeaminen
poistamiseen liittyvät vaikeudet	pinnoitteen irtoaminen	

2. Haittavaikutukset

kuolema	infektio	verisuonen dissekoituma
verisuonen perforaatio	verenvuotokomplikaatit	embolia
trombi	infarkti	iskemia
eteisvärinä	vasospasmi	verisuonen okklusio
verenpainan lasku	allerginen reaktio	jäännös

Käyttö

1. Tarkistus ennen käyttöä

- Tarkista ohjainvaijeri ja sen pakkaus huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia.
- Varmista ennen käyttöä, että ohjainvaijeri on yhteensopiva käytettävien toimenpidevälineiden kanssa.

2. Valmistelu

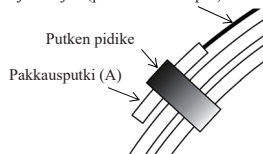
- Valitse hoidettavalle alueelle sopivin

- ohjainvaijeri ja poista ohjainvaijerin sisältävä pakkausputki sterilistä pakkauksesta.
- Täytä pakkausputki ruiskun avulla heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella, jotta koko laite huuhdoutuu. Huomaa, että pakkausputkesta voi tässä vaiheessa vuotaa ulos heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta.
- Täytä toimenpidevälineen luumen heparinoidulla ja steriloidulla

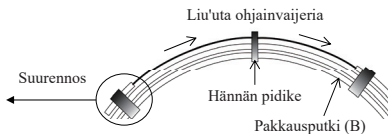
keittosuolaliuoksella ennen ohjainvaijerin sisäänvientiä.

- Irrota ohjainvaijerin pää hännän pidikkeestä ja

Ohjainvaijeri (proksimaalinen pää)



liu'uta ohjainvaijeria hitaasti painamalla sen distaalista päätä pakkausputken (B) läpi (kuva 1).



Kuva 1

- Kun ohjainvaijerin distaalinen pää on tullut yli 4 cm ulos pakkausputken toisesta päästä, muotoile kärkeä tarvittaessa vakioimenetelmän mukaisesti.
- Ota varovasti kiinni pakkausputken distaalisesta päästä ulos tulleesta ohjainvaijerista mahdollisimman läheltä pakkausputkea ja vedä ohjainvaijeri ulos hitaasti ja varovasti.
- Jos tunnet vastusta ottaessasi ohjainvaijeria pois pakkausputkesta, ruiskuta pakkausputkeen lisää heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta. Jatka ohjainvaijerin poistamista putkesta vasta sitten, kun vastusta ei enää tunnu. Varmista, että ruiskutat pakkausputkeen riittävästi heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta, sillä hydrofiilinen pinnoite saattaa vaurioitua, jos pinnoitettua ohjainvaijeri otetaan putkesta väkisin.
- Kun olet vetänyt ohjainvaijerin pakkausputkesta, tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

3. Sisäänvienti

■ Over-the-wire-järjestelmä

- Vie ohjainvaijerin distaalinen pää varovasti toimenpidevälineen ohjainvaijeriluumeniin.
- Työnnä ohjainvaijeria varovasti eteenpäin, kunnes sen kärki on aivan toimenpidevälineen kärjen proksimaalisella puolella.
- Kiinnitä ohjainkatetri ja vie toimenpidevälinejärjestelmää (ohjainvaijerin kanssa) Y-liitoskappaleeseen.
- Työnnä toimenpidevälinejärjestelmää ohjainkatetrin läpi, kunnes

ohjainvaijerijärjestelmän kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.

- Kiristä Y-liitoskappaleen hemostaasiventtiiliä niin, että se tiivistyy toimenpidevälineen ympärille. Varmista, että ohjainvaijeria voi vielä liikuttaa.
- Varmista, että ohjainvaijeri liikkuu tasaisesti.
- Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.
- Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtaatuneen kohdeleesion.
- Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.
- Työnnä toimenpidevälinettä eteenpäin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

■ Rapid exchange -järjestelmä

- Kiinnitä ohjainkatetri.
- Työnnä ohjainvaijerin sisäänviejiä ohjainkatetrin Y-liitoskappaleeseen.
- Vie ohjainvaijerin kärki varovasti sisäänviejiään.
- Työnnä ohjainvaijeria ohjainkatetrin läpi fluoroskopiassa, kunnes ohjainvaijerin kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.
- Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.
- Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtaatuneen

- kohdeleesion.

g) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.

h) Irrota ohjainvaijerin pyörin ja ohjainvaijerin sisäänviejä.

i) Kuljeta toimenpideväline ohjainvaijeria pitkin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen

sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.
4. Ohjainvaijerin vaihto

 - Over-the-wire-järjestelmä
 - a) Poista ohjainvaijeri varovasti ja seuraa samalla sen liikettä fluoroskopian avulla.
 - b) Vie seuraava ohjainvaijeri paikalleen kohdan "Käyttö" ohjeiden mukaisesti.

Säilytys

Älä säilytä ohjainvaijeria ja pakkausta taivutettuna ja/tai raskaasti kuormitettuna. Tämä ohjainvaijeri ja sen pakkaus on pidettävä poissa vedestä. Säilytettävä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Viimeinen käyttöpäivä

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty ohjainvaijerin pakkauksen etikettiin.

Sisältö

5 kpl / laatikko

Vastuuvapauslauseke

"ASAHI INTECC CO., LTD. ja sen konserniyhtiöt" (jäljempänä "yritys") eivät vastaa millään tavoin vahinkotapahtumista, henkilövammoista tai haittavaikutuksista, jotka johtuvat tuotteen (tuotteiden) epäasianmukaisesta käytöstä tai mistä tahansa muusta näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä. Yritys ei missään tapauksessa vastaa vahingoista, jotka johtuvat joko (i) tuotteen (tuotteiden) säilytyksestä sen jälkeen kun yritys on ne lähettänyt tai (ii) potilaiden valinnasta, leikkaustekniikoista tai mistä tahansa muista tuotetta (tuotteita) käyttävän hoitolaitoksen lääkinnällisistä toimenpiteistä.

"ASAHI Gaia Next" on ASAHI INTECC CO., LTD.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

ASAHI Gaia Next Fil guide pour ICP

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce fil guide et respecter les rubriques Indications d'utilisation, Contre-indications, Avertissements, Précautions, et Méthode d'utilisation de ce mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des complications, notamment des blessures graves ou le décès du patient.

Si un utilisateur ou un patient a connaissance d'un incident grave lié au fil guide, il doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente.

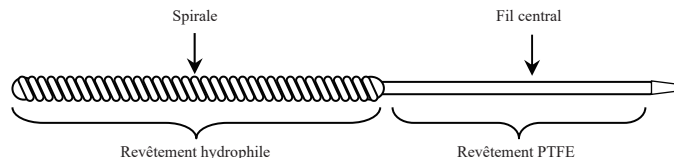
Ce mode d'emploi s'applique à ASAHI Gaia Next. Pour plus de détails (longueur du fil guide, longueur de la partie radio-opaque, etc.), consulter l'étiquette du produit.

Descriptions

Ce fil guide est un fil guide orientable doté d'une pointe modelable et est disponible dans des variantes préformées. Le diamètre extérieur du fil guide est de 0,36 mm (0,014 po). Ce fil guide est compatible avec les cathéters de dilatation à ballonnet existants et d'autres dispositifs d'intervention utilisés dans les interventions coronariennes percutanées (ICP) courantes. La partie distale de la pointe du fil guide est radio-opaque.

Pour assurer la lubrification, la partie distale du dispositif est recouverte d'un polymère hydrophile et la partie proximale du fil guide est recouverte de polytétrafluoroéthylène (PTFE).

À l'extrémité proximale du dispositif, qui est inférieure à 300 cm, se trouve une connexion pour un prolongateur, utilisé pour remplacer le dispositif combiné ; le prolongateur d'ASAHI INTECC peut être connecté, et la longueur totale après connexion est de 355 à 400 cm.



Indications d'utilisation

Ce fil guide est conçu pour les interventions coronariennes percutanées (ICP) courantes. Il peut être utilisé pour introduire et positionner des cathéters de dilatation à ballonnet et d'autres dispositifs d'intervention dans le système cardiovasculaire.

Ce fil guide n'est pas destiné à être utilisé dans le système neurovasculaire ni dans le système vasculaire périphérique.

Contre-indications

- Vérifier la compatibilité du diamètre du fil guide avec d'autres dispositifs d'intervention avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont une réaction allergique aux produits de l'utiliser.

contraste ou qui présentent un dysfonctionnement rénal.

- Ce fil guide contient du PEG400 dans son revêtement hydrophile. Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont des réactions allergiques au polyéthylène glycol (PEG).
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patientes enceintes ou susceptibles de l'être (les rayons X peuvent affecter le fœtus).
- Ce fil guide doit être utilisé dans un établissement médical en mesure de réaliser immédiatement une intervention chirurgicale

d'urgence. S'il n'est pas possible de réaliser d'intervention chirurgicale d'urgence, dans le pire des cas, des événements potentiellement mortels peuvent survenir.

- Ce fil guide est pré-stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène et il est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser. En cas de réutilisation ou de restérilisation, les performances ou la qualité de ce fil guide peuvent être affectées et il existe un risque de complications, voire d'infection.

Avertissements

- Ce fil guide doit être utilisé uniquement par un médecin ayant reçu une formation complète sur le traitement par ICP.
- Ne jamais utiliser ce fil guide en association avec des cathéters comportant des parties métalliques susceptibles d'entrer directement en contact avec la surface du fil guide (p. ex., cathéters d'athérectomie, dilateurs métalliques), des aiguilles métalliques ou des insérateurs de gaines métalliques.
- Vérifier et surveiller le mouvement de la pointe du fil guide sous radioscopie pendant son

utilisation. Ne pas utiliser dans des zones du vaisseau qui ne sont pas visibles ou ne peuvent être visualisées.

- Ne pas relier ce fil guide à des prolongateurs détachables de fabricants autres que ASAHI INTECC. Ne pas manipuler ce fil guide lorsque le prolongateur détachable est connecté. Autrement, le fil guide pourrait s'endommager, ou le prolongateur détachable pourrait se détacher involontairement.
- Ne pas modifier ce fil guide pour quelque raison que soit.

Précautions

- Ne pas utiliser le fil guide au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Jeter tout fil guide ayant dépassé la date de péremption.
- Les fils guides sont des instruments fragiles et doivent être manipulés avec soin.
- Si l'emballage est ouvert ou endommagé, ne pas utiliser le fil guide. Ne pas ouvrir l'emballage avant l'emploi. Prendre des mesures aseptiques au cours de la manipulation et de l'utilisation du fil guide.
- Maintenir en permanence le fil guide à l'état humide afin de ne pas endommager son revêtement hydrophile.
- Ne pas essayer ce fil guide à l'aide d'une solution organique telle que l'alcool.
- Après utilisation, prendre des mesures préventives contre les infections. Mettre au rebut ce fil guide et l'emballage en tant que déchets médicaux.
- Ne jamais pousser, vriller, rétracter le fil guide ou lui appliquer une torsion lorsqu'il rencontre une résistance. Le fait d'appliquer une torsion ou de pousser ce fil guide alors qu'il rencontre une

résistance risque de l'endommager et/ou d'entraîner la séparation de la pointe du fil guide ou de léser directement un vaisseau. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le fil guide. Déterminer la cause de la résistance sous radioscopie et prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème.

- Toujours faire avancer ou retirer les fils guides lentement et avec précaution.
- Lorsque ce fil guide est soumis à une torsion dans le vaisseau sanguin, ne pas appliquer de torsion continue dans la même direction. Lors de la torsion du fil guide, le faire tourner alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Ne pas effectuer plus de deux rotations (720°) dans la même direction.
- Rincer le fil guide avec une solution saline héparinisée et stérilisée ou toute autre solution adéquate lors du retrait ou de la réinsertion afin d'éviter toute pénétration d'air dans le dispositif d'intervention. Changer ce fil guide avec précautions afin d'éviter l'entrée de l'air et/ou un traumatisme. Au moment de réintroduire le fil

guide, vérifier que la pointe du dispositif d'intervention n'est pas coincée dans la lumière du vaisseau et ne se trouve pas contre la paroi du vaisseau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un traumatisme. Utiliser le marqueur radio-opaque du dispositif d'intervention pour vérifier la position.

- Le libre mouvement du fil guide dans le dispositif d'intervention est une caractéristique importante d'un système de fil guide orientable puisqu'il donne à l'utilisateur de précieuses informations tactiles. Tester la résistance du système avant toute utilisation. Régler la valve hémostatique ou la remplacer par une valve réglable s'il s'avère qu'elle empêche le mouvement du fil guide.
- Ne pas pratiquer la pose de stent en utilisant plus d'un fil guide, ne pas manipuler le fil guide à travers les entretours du stent. Sinon, le stent peut être endommagé ou le fil guide peut se rompre ou se disloquer.
- Avant utilisation, s'assurer que ce fil guide est de taille et de forme appropriées pour la procédure et qu'il est compatible avec le dispositif à utiliser en association.
- Consulter le mode d'emploi joint au dispositif médical (p. ex., cathéters de dilatation à ballonnet

ou autres dispositifs d'intervention) qui sera utilisé en association avec ce fil guide.

- Lors de la connexion du prolongateur détachable à ce fil guide, celui-ci doit être inséré en toute sécurité à la ligne de démarcation entre le revêtement non PTFE et le revêtement PTFE à l'extrémité proximale de ce fil guide. Si une anomalie est constatée au niveau de la connexion, cesser immédiatement d'utiliser le fil guide.
- Inspecter soigneusement le fil guide à la recherche de plis, torsions ou autres dommages avant toute utilisation et à chaque fois que cela est possible au cours de la procédure. Ne pas utiliser le fil guide s'il est endommagé.
- Faire attention à ne pas endommager la spirale lors de la mise en forme de la pointe.
- Avant d'insérer le fil guide, vérifier quelle est l'extrémité distale et veiller à l'insérer à partir de l'extrémité distale.
- Maintenir un rinçage à la solution saline continu entre le cathéter de guidage et le dispositif d'intervention et entre le dispositif d'intervention et le fil guide pendant la procédure. Le rinçage empêche la formation de produit de contraste et/ou la coagulation sur le fil guide et dans la lumière du cathéter.

- Avant utilisation, s'assurer que le fil guide est compatible avec les dispositifs d'intervention qui seront utilisés.

2. Préparation

- Sélectionner le fil guide le plus adapté pour la zone concernée et retirer le support tubulaire contenant le fil guide de l'emballage stérile.
- Remplir le support tubulaire avec une solution saline héparinisée et stérilisée en utilisant une seringue de manière à faire tremper l'ensemble

Fil guide (extrémité proximale)

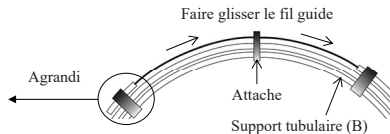
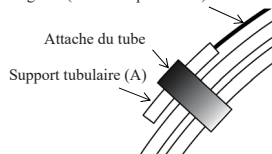


Figure 1

- Quand l'extrémité distale du fil guide s'étend de plus de 4 cm de l'autre extrémité du support tubulaire, si nécessaire, former la pointe conformément aux pratiques courantes.
- Saisir doucement le fil guide qui sort de l'extrémité distale du support tubulaire, à un point aussi proche que possible du support tubulaire, et sortir le fil guide lentement et avec précautions.
- En cas de résistance lors du retrait du fil guide du support tubulaire, injecter de nouveau de la solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Une fois que la résistance a disparu, continuer à retirer le fil guide. S'assurer d'injecter suffisamment de solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Le retrait forcé du fil guide revêtu peut en effet endommager le revêtement hydrophile.
- Après avoir retiré le fil guide du support tubulaire, l'examiner pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

3. Procédures d'insertion

■ Système sur fil

- Insérer soigneusement l'extrémité distale du fil guide dans la lumière du fil guide du dispositif d'intervention.
- Faire progresser doucement ce fil guide

du dispositif. Il est à noter que la solution saline héparinisée et stérilisée peut s'écouler du support tubulaire à ce moment-là.

- Remplir la lumière du dispositif d'intervention avec la solution saline héparinisée et stérilisée avant d'insérer le fil guide.
- Libérer le fil guide de l'attache et faire glisser lentement le fil guide, pousser l'extrémité distale du fil guide à travers le support tubulaire (B). (Figure 1)

jusqu'à ce que sa pointe soit toute proche de la pointe du dispositif d'intervention.

- Engager le cathéter-guide et insérer le dispositif d'intervention (avec le fil guide) dans le connecteur en Y.
- Faire progresser le dispositif d'intervention dans le cathéter-guide jusqu'à ce que la pointe du système de fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
- Serrer la valve hémostatique du connecteur en Y pour sceller le tout autour du dispositif d'intervention. S'assurer que le fil guide peut encore bouger.
- Vérifier que le fil guide se déplace sans difficulté.
- Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
- Faire progresser ce fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
- Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
- Faire progresser le dispositif d'intervention jusqu'à ce qu'il atteigne la lésion tout en évitant que le fil guide ne bouge. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du

Dysfonctionnements et effets indésirables

Les dysfonctionnements et effets indésirables dérivés de l'utilisation de ce fil guide comprennent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

1. Dysfonctionnements

Non-franchissement d'une lésion	Rupture ou déformation du fil guide	Dommages tels que la séparation
Difficulté de retrait	Décollement du revêtement	

2. Effets indésirables

Mort	Infection	Dissection de vaisseau
Perforation de vaisseau	Complications hémorragiques	Embolie
Thrombose	Infarctus	Ischémie
Arythmie	Vasospasme	Occlusion vasculaire
Baisse de la tension artérielle	Réaction allergique	Résiduel

Méthode d'utilisation

1. Examen préalable à l'utilisation

- Avant utilisation, effectuer un examen attentif

et s'assurer que le fil guide et l'emballage ne sont pas endommagés.

dispositif d'intervention.

■ Système d'échange rapide

- a) Engager le cathéter-guide.
- b) Insérer l'introducteur de fil guide dans le connecteur en Y du cathéter-guide.
- c) Insérer soigneusement la pointe du fil guide dans l'introducteur.
- d) Faire avancer le fil guide dans le cathéter-guide sous radioscopie jusqu'à ce que la pointe du fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
- e) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
- f) Faire progresser le fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
- g) Observer le mouvement du fil guide dans les

vaisseaux.

- h) Retirer le dispositif de couple de fil guide et l'introducteur de fil guide.
- i) Suivre le dispositif d'intervention sur le fil guide tout en empêchant le fil guide de bouger, et le faire avancer jusqu'à atteindre la lésion. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

4. Procédures de changement du fil guide

■ Système sur fil

- a) Retirer lentement ce fil guide en surveillant ses mouvements sous radioscopie.
- b) Insérer le fil guide suivant conformément aux instructions de la section « Méthode d'utilisation ».

Méthode d'entreposage

Ne pas plier le fil guide et l'emballage et/ou ne pas mettre de poids dessus. Le fil guide et l'emballage ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Conserver dans un lieu frais, sombre et sec.

Date de péremption

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette de l'emballage du fil guide.

Contenu

5 pièces/coffret

Clause de non-responsabilité

En aucun cas « ASahi INTECC CO., LTD. et ses filiales » (ci-après appelées l'« Entreprise ») ne seront tenues responsables des accidents, des blessures corporelles, des effets indésirables causés par un mauvais usage du ou des produit(s) ou par un usage ne respectant pas les présentes instructions.

En aucun cas, l'Entreprise ne sera tenue pour responsable de tout dommage (i) résultant du mode d'entreposage du ou des produits suite à leur expédition depuis les locaux de l'Entreprise ou (ii) dû à la sélection des patients, des techniques chirurgicales ou de toute autre procédure médicale effectuée par l'établissement de santé utilisant le ou les produits en question.

« ASahi Gaia Next » est une marque de commerce ou une marque déposée de ASahi INTECC CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

ASAHI Gaia Next PCI-Führungsdraht

Gebrauchsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Führungsdraht verwenden, und beachten Sie die Indikation, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die Hinweise im Abschnitt „Anwendung“ in der Gebrauchsanweisung. Andernfalls kann es zu Komplikationen einschließlich schwerer Verletzungen und zum Tod des Patienten kommen.

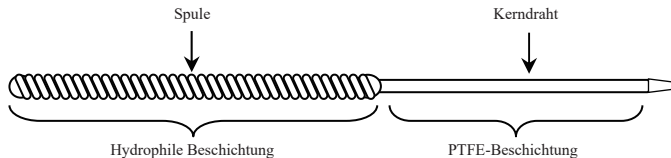
Bitte informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde, wenn sie als Anwender oder Patient von einem schweren Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Führungsdraht Kenntnis erhalten.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für ASAHI Gaia Next. Details (Länge des Führungsdrahtes, Länge des röntgendichten Abschnitts usw.) finden Sie auf dem Etikett des Produkts.

Beschreibungen

Dieser Führungsdraht ist lenkbar, hat eine formbare Spitze und ist in vorgeformten Varianten erhältlich. Der Außendurchmesser des Führungsdrahtes beträgt 0,36 mm (0,014 Zoll). Dieser Führungsdraht ist mit vorhandenen Ballonkathetern und anderen Interventionsinstrumenten kompatibel, die bei gängigen perkutanen Koronarinterventionen (PCI) verwendet werden. Der distale Teil der Führungsdrahtspitze ist röntgendicht.

Der distale Teil des Instruments ist zur Gewährleistung der Gleitfähigkeit mit einem hydrophilen Polymer und der proximale Teil des Führungsdrahtes mit Polytetrafluorethylen (PTFE) beschichtet. Am proximalen Ende des weniger als 300 cm langen Instruments befindet sich ein Anschluss für einen Verlängerungsdraht, der das Kombiinstrument ersetzt; es kann ein Verlängerungsdraht von ASAHI INTECC angeschlossen werden. Nach dem Anschließen beträgt die Gesamtlänge 355 - 400 cm.



Indikation

Dieser Führungsdraht ist für die allgemeine perkutane Koronarintervention (PCI) vorgesehen. Er kann zum Einführen und Positionieren von Ballonkathetern und anderen interventionellen Instrumenten in das kardiovaskuläre System verwendet werden.

Dieser Führungsdraht ist nicht für eine Verwendung im neurovaskulären und peripheren Gefäßsystem geeignet.

Gegenanzeigen

- Stellen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität des Führungsdrahtdurchmessers mit anderen interventionellen Instrumenten sicher.

- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Patienten, die allergisch auf Kontrastmittel reagieren oder eine eingeschränkte Nierenfunktion haben.
- Die hydrophile Beschichtung dieses Führungsdrahtes enthält PEG400. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Patienten, die allergisch auf Polyethylenglykol (PEG) reagieren.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Schwangeren oder möglicherweise schwangeren Patientinnen (Röntgenstrahlen können den Fötus schädigen).
- Der Führungsdraht darf nur in einer Einrichtung verwendet werden, in der unverzüglich Notfalloperationen durchgeführt werden können. Wenn keine Notfalloperationen möglich sind, können schlimmstenfalls lebensbedrohliche Situationen auftreten.
- Der Führungsdraht wurde mit Ethylenoxidgas (EOG) sterilisiert und ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung oder erneute Sterilisierung kann die Leistungsqualität des Führungsdrahts beeinträchtigen, und es besteht das Risiko von Komplikationen wie z. B. Infektionen.

Warnhinweise

- Dieser Führungsdraht darf nur von einem für die Durchführung von PCI-Eingriffen qualifizierten Arzt verwendet werden.
- Dieser Führungsdraht darf niemals zusammen mit Kathetern mit Metallteilen, die direkt mit der Oberfläche dieses Führungsdrahtes in Berührung kommen können (z. B. Atherektomiekatheeter, Dilatoren aus Metall), Kanülen oder Dilatoren aus Metall verwendet werden.
- Während der Verwendung des Führungsdrahtes ist die Bewegung seiner Spitze unter Fluoroskopie zu kontrollieren und zu überwachen. Nicht in Bereichen von Gefäßen verwenden, die nicht mittels Bildgebung dargestellt werden oder werden können.
- Verbinden Sie den Führungsdraht nicht mit abnehmbaren Verlängerungsdrähten, die von anderen Herstellern als ASAHI INTECC hergestellt werden. Bewegen Sie den Führungsdraht nicht, solange der abnehmbare Verlängerungsdraht noch angeschlossen ist. Der Führungsdraht kann sonst beschädigt werden oder das abnehmbare Verlängerungskabel sich ungewollt lösen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Führungsdraht vor.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Führungsdraht darf nach dem auf der Produktverpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Entsorgen Sie jeden Führungsdraht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Führungsdrähte sind empfindliche Instrumente und müssen vorsichtig behandelt werden.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Öffnen Sie die Verpackung immer erst kurz vor der Verwendung. Verwenden Sie bei der Handhabung und Verwendung des Führungsdrahtes aseptische Techniken.
- Achten Sie darauf, dass der Führungsdraht immer feucht gehalten wird, um eine Beschädigung seiner hydrophilen Beschichtung zu vermeiden.
- Reinigen Sie diesen Führungsdraht nicht mit einer organischen Lösung, wie z. B. Alkohol.
- Ergreifen Sie nach der Anwendung vorbeugende Maßnahmen gegen Infektionen. Entsorgen Sie diesen Führungsdraht als medizinischen Abfall.
- Dieser Führungsdraht darf niemals gegen einen Widerstand geschoben, gebohrt, herausgezogen oder gedreht werden. Das Drehen oder Schieben des Führungsdrahtes gegen einen Widerstand kann zur Beschädigung bzw. Ablösung seiner Spitze oder zur unmittelbaren Beschädigung eines Gefäßes führen. Zuwiderhandlungen können zur Beschädigung des Führungsdrahtes führen. Ermitteln Sie die Ursache des Widerstands mittels Fluoroskopie und ergreifen Sie notwendige Abhilfemaßnahmen.
- Führungsdrähte grundsätzlich langsam und vorsichtig vorschieben oder zurückziehen.
- Drehen Sie den Führungsdraht im Inneren des Blutgefäßes nicht kontinuierlich in dieselbe Richtung. Drehen Sie den Führungsdraht abwechselnd im und entgegen dem

Uhrzeigersinn. Drehen Sie ihn nicht häufiger als zwei Mal (720°) in dieselbe Richtung.

- Spülen Sie den Führungsdraht während des Herausziehens und Wiedereinführens mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung oder einer anderen geeigneten Lösung, damit keine Luft in das interventionelle Instrument eintreten kann. Führen Sie den Austausch dieses Führungsdrahtes vorsichtig durch, um Lufteintritt bzw. Traumata zu vermeiden. Achten Sie beim Wiedereinführen des Führungsdrahtes darauf, dass die Spitze des interventionellen Instruments frei im Gefäßlumen liegt und nicht an der Gefäßwand anliegt. Es besteht ansonsten die Gefahr eines Traumas. Verwenden Sie zur Kontrolle der Position die röntgendichte Markierung des interventionellen Instruments.
- Die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes innerhalb des interventionellen Instruments ist eine wesentliche Eigenschaft eines lenkbaren Führungsdrahtsystems, da sie dem Anwender wertvolle haptische Informationen liefert. Untersuchen Sie das System vor dem Gebrauch auf eventuelle Widerstände. Verstellen Sie das hämostatische Ventil oder ersetzen Sie es durch ein verstellbares Ventil, wenn es die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes verhindert.
- Verwenden Sie bei der Platzierung des Stents nicht mehr als einen Führungsdraht und führen Sie den Führungsdraht nicht durch Stent-Stege. Der Stent kann dadurch beschädigt werden oder der Führungsdraht kann abreißen oder abbrechen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Führungsdraht in Größe und Form für den Eingriff geeignet und mit dem zu verwendenden Instrument kompatibel ist.

Fehlfunktionen und Zwischenfälle

Mögliche Fehlfunktionen und Zwischenfälle beim Gebrauch dieses Führungsdrahtes sind unter anderem:

1. Fehlfunktionen

Eine Läsion ist nicht passierbar	Bruch oder Verbiegen des Führungsdrahtes	Schäden wie Abtrennung
Schwierigkeiten beim Herausziehen	Ablösen der Beschichtung	

2. Zwischenfälle

Tod	Infektion	Gefäßdissektion
-----	-----------	-----------------

- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des medizinischen Instruments (z. B. Ballonkatheter oder sonstige interventionelle Instrumente), das zusammen mit diesem Führungsdraht verwendet werden soll.
- Beim Anschluss des abnehmbaren Verlängerungsdrahtes an diesen Führungsdraht sollte dieser fest an der Übergangslinie zwischen dem unbeschichteten und dem mit PTFE beschichteten Bereich am proximalen Ende des Führungsdrahtes eingeführt werden. Sollte eine Anomalie an der Verbindung festgestellt werden, ist die Verwendung des Führungsdrahtes sofort zu beenden.
- Überprüfen Sie den Führungsdraht vor der Verwendung und nach Möglichkeit auch während des Eingriffs sorgfältig auf Biegungen, Knicken oder sonstige Schäden. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Achten Sie beim Ausformen der Spitze darauf, die Spule nicht zu beschädigen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einführen des Führungsdrahtes, welches Ende das distale Ende ist, und führen Sie den Draht von der distalen Seite her ein.
- Sorgen Sie während des Eingriffs für eine kontinuierliche Spülung mit Kochsalzlösung zwischen dem Führungskatheter und dem interventionellen Instrument sowie zwischen dem interventionellen Instrument und dem Führungsdraht. Die Spülung verhindert die Bildung von Kontrastmittel bzw. eine Klumpenbildung auf dem Führungsdraht und im Lumen des Katheters.

Gefäßperforation

Thrombus

Arrhythmie

Blutdruckabfall

Komplikationen aufgrund von Blutungen

Infarkt

Vasospasmus

Allergische Reaktion

Embolie

Ischämie

Gefäßverschluss

Residenen

Anwendung

1. Überprüfung vor der Verwendung

- Vor dem Gebrauch alle Führungsdrähte und Verpackungen kontrollieren und auf Unversehrtheit prüfen.
- Vor dem Gebrauch überprüfen, ob der Führungsdraht mit den zu verwendenden interventionellen Instrumenten kompatibel ist.

2. Vorbereitung

- Wählen Sie den am besten geeigneten Führungsdraht für den betroffenen Bereich aus und entnehmen Sie den Dispenser mit dem Führungsdraht aus der sterilen Verpackung.
- Befüllen Sie den Dispenser mithilfe einer

Führungsdraht (proximales Ende)

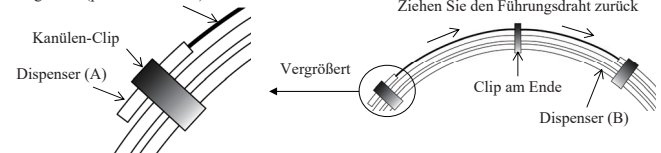


Abbildung 1

- Formen Sie die Spitze, falls erforderlich, auf die allgemein übliche Art, wenn das distale Ende des Führungsdrahtes mehr als 4 cm über das andere Ende des Dispensers hinausragt.
- Greifen Sie den am distalen Ende des Dispensers herausragenden Führungsdraht behutsam möglichst nahe am Dispenser und ziehen Sie ihn langsam und vorsichtig heraus.
- Injizieren Sie erneut heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser, falls beim Herausziehen des Führungsdrahts vom Dispenser Widerstand spürbar ist. Ziehen Sie den Führungsdraht erst dann weiter heraus, wenn kein Widerstand mehr spürbar ist. Achten Sie darauf, ausreichend heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser zu injizieren, da die hydrophile

- Spritze mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung, um das gesamte Instrument damit zu tränken. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung aus dem Dispenser austreten kann.
- Befüllen Sie das Lumen des interventionellen Instruments vor dem Einführen des Führungsdrahts mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung.
 - Lösen Sie den Führungsdraht vom Clip. Schieben Sie anschließend das distale Ende des Führungsdrahtes langsam durch den Dispenser (B). (Abbildung 1)

- Beschichtung des Führungsdrahtes durch gewaltsames Herausziehen beschädigt werden kann.
- Untersuchen Sie den Führungsdraht nach dem Herausziehen, um sicherzugehen, dass er nicht beschädigt ist.

3. Anleitung zum Einführen

- System über den Draht
 - Führen Sie das distale Ende des Führungsdrahtes vorsichtig in das Führungsdrahtlumen des interventionellen Instruments ein.
 - Schieben Sie den Führungsdraht vorsichtig vorwärts, bis sich seine Spitze direkt proximal zur Spitze des interventionellen Instruments befindet.

- c) Schließen Sie den Führungskatheter an und schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem (mit Führungsdraht) in den Y-Anschluss.
 - d) Schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem durch den Führungskatheter, bis die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
 - e) Ziehen Sie zum Abdichten des interventionellen Instruments das hämostatische Ventil des Y-Anschlusses an. Vergewissern Sie sich, dass sich der Führungsdraht noch nicht bewegen lässt.
 - f) Prüfen Sie, ob der Führungsdraht leicht gleitet.
 - g) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
 - h) Schieben Sie diesen Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
 - i) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
 - j) Schieben Sie das interventionelle Instrument bis zur Läsion vor und achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.
- Schnellwechselsystem
- a) Schieben Sie den Führungskatheter ein.
 - b) Setzen Sie das Einführbesteck für den Führungsdraht in den Y-Anschluss des

- Führungskatheters ein.
- c) Schieben Sie die Spitze des Führungsdrahtes vorsichtig in das Einführbesteck.
- d) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch den Führungskatheter, bis sich die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
- e) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- f) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- g) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- h) Entfernen Sie die Rotationshilfe und das Einführbesteck für den Führungsdraht.
- i) Folgen Sie dem interventionellen Instrument mit dem Führungsdraht. Achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt, und schieben Sie ihn bis zur Läsion vor. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

4. Auswechseln des Führungsdrahtes

- System über den Draht
- a) Entfernen Sie diesen Führungsdraht langsam und überwachen Sie seine Bewegung dabei unter Fluoroskopie.
- b) Führen Sie den nächsten Führungsdraht gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Anwendung“ ein.

Haftungsausschluss

„ASAHI INTECC CO., LTD. und dessen Partnerunternehmen“ (im Folgenden als das „Unternehmen“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle, Personenschäden und Zwischenfälle infolge des unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts/dieser Produkte oder jeder anderen Verwendung, die im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anweisungen steht. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Schäden, die (i) aus der Lagerung des Produkts/der Produkte nach dem Versand durch das Unternehmen oder (ii) aufgrund der Auswahl der Patienten, der Operationsmethoden oder aufgrund irgendwelcher sonstigen medizinischen Tätigkeiten seitens der medizinischen Einrichtung, die dieses Produkt verwendet, entstehen.

„ASAHI Gaia Next“ ist ein in Japan und weiteren Ländern eingetragenes Warenzeichen von ASAHI INTECC CO.,LTD.

Lagerbedingungen

Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung in einem gebogenen Zustand und nicht unter schweren Gegenständen. Führungsdraht und die Verpackung vor Nässe schützen. Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett auf der Führungsdrahtverpackung angegeben.

Inhalt

5 Stück/Schachtel

ASAHI Gaia Next Καθοδηγητικό σύρμα PCI

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τηρήστε τις ενδείξεις χρήσης, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το πώς χρησιμοποιείται, στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιπλοκές, όπως σοβαρός τραυματισμός του ασθενούς ή θάνατος.

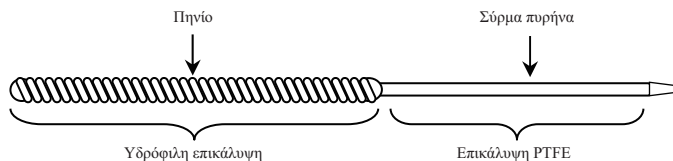
Εάν ο χρήστης ή ο ασθενής λάβει γνώση ενός σοβαρού περιστατικού που συνέβη σε σχέση με το καθοδηγητικό σύρμα, αναφέρετε το γεγονός στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για την ASAHI Gaia Next. Για λεπτομέρειες (μήκος του καθοδηγητικού σύρματος, μήκος του ακτινοσκοπικού τμήματος κ.λπ.), ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.

Περιγραφές

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι ένα καθοδηγητικό σύρμα με διαμορφώσιμο άκρο και διατίθεται σε προδιαμορφωμένες παραλλαγές. Η εξωτερική διάμετρος του καθοδηγητικού σύρματος είναι 0,36 mm (0,014 ίντσες). Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι συμβατό με τους υπάρχοντες καθετήρες διαστολής μπάλονιου και άλλες επεμβατικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην κοινή διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI). Το άνω τμήμα του άκρου του καθοδηγητικού σύρματος είναι ακτινοσκοπικό.

Για λίπανση, το άνω τμήμα της συσκευής είναι επικαλυμμένο με ένα υδρόφιλο πολυμερές και το εγγύς τμήμα του καθοδηγητικού σύρματος είναι επικαλυμμένο με πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE). Στο εγγύς άκρο της συσκευής, το οποίο είναι μικρότερο από 300 cm, υπάρχει μια σύνδεση για ένα σύρμα επέκτασης, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής. Το σύρμα επέκτασης της ASAHI INTECC μπορεί να συνδεθεί και το συνολικό μήκος μετά τη σύνδεση είναι 355-400 cm.



Ενδείξεις χρήσης

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για γενική διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και τοποθέτηση καθετήρων διαστολής μπάλονιου και άλλων επεμβατικών συσκευών εντός του καρδιαγγειακού συστήματος.

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα δεν προορίζεται για χρήση στο νευροαγγειακό και περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Αντενδείξεις

- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα της διαμέτρου του καθοδηγητικού σύρματος με άλλη επεμβατική συσκευή πριν από την πραγματική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργική αντίδραση στο σιαγναρικό υλικό ή με νεφρική δυσλειτουργία.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα περιέχει PEG400 στην υδρόφιλη επικάλυψη του. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις στην πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG).
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε έγκυες ασθενείς ή σε ασθενείς που μπορεί να είναι έγκυες (η ακτινογραφία μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο).
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ίδρυμα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Εάν μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση δεν είναι διαθέσιμη, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να συμβούν απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι προστατευόμενο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EOG) και προορίζεται μόνο για μία χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναποστεριώνετε. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή επαναποστείρωσης, η απόδοση ή η ποιότητα αυτού του καθοδηγητικού σύρματος μπορεί να υποβαθμιστεί και υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης.

Προειδοποιήσεις

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό που δεν είναι πλήρως εκπαιδευμένος στη θεραπεία PCI.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα σε συνδυασμό με καθετήρες με μεταλλικά μέρη που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιφάνεια αυτού του καθοδηγητικού σύρματος (π.χ. καθετήρες αθηρεκτομής, μεταλλικοί διαστολείς), μεταλλικές βελόνες ή μεταλλικούς υποδοχείς θήκης.
- Κατά τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος, ελέγχετε και παρακολουθείτε την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση. Μην το χρησιμοποιείτε σε σημεία του αγγείου που δεν είναι ή δεν μπορούν να απεικονιστούν.
- Μην συνδέετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα με αποσπώμενα σύρματα επέκτασης τα οποία παράγονται από κατασκευαστές διαφορετικούς από την ASAHI INTECC. Μην χειρίζεστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα όσο είναι συνδεδεμένο το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καθοδηγητικό σύρμα ή να αποκολληθεί ακούσια το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης.
- Μην τροποποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα για κανέναν λόγο.

Προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Απορρίψτε κάθε καθοδηγητικό σύρμα όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του.
- Τα καθοδηγητικά σύρματα είναι ευαίσθητα εργασία και πρέπει να τα χειρίζεστε προσεκτικά.
- Εάν η συσκευασία έχει ανοίξει ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα. Μην ανοίγετε τη συσκευασία μέχρι λίγο πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ασηπτική τεχνική κατά το χειρισμό και τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Διατηρείτε πάντα το καθοδηγητικό σύρμα σε υγρή κατάσταση για να αποφύγετε τη φθορά της υδρόφιλης επικάλυψής του.
- Μην σκουπίζετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα χρησιμοποιώντας οργανικό διάλυμα, όπως οινόπνευμα.
- Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά της μόλυνσης μετά τη χρήση. Απορρίψτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία ως ιατρικά απόβλητα.
- Ποτέ μην σπρώχνετε, βιδώνετε, αποσύρετε ή στρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα που συναντά αντίσταση. Η στρέψη ή η πίεση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ενάντια στην αντίσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και

αποκόλληση του άκρου αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ή άμεση ζημία σε ένα αγγείο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημία σε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα. Προσδιορίστε την αιτία της αντίστασης υπό ακτινοσκόπηση και λάβετε κάθε αναγκαία διορθωτική ενέργεια.

- Πάντα να προσωθείτε ή να αποσύρτετε τα καθοδηγητικά σύρματα αργά και προσεκτικά.
- Όταν περιστρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα στο εσωτερικό του αμοιόφρου αγγείου, μην περιστρέψετε συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση. Κατά την περιστροφή του καθοδηγητικού σύρματος, περιστρέψτε το εναλλάξ δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Μην περιστρέψετε περισσότερο από δύο περιστροφές (720°) προς την ίδια κατεύθυνση.
- Ξεπλύνετε το καθοδηγητικό σύρμα με ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή άλλο κατάλληλο διάλυμα κατά την αφαίρεση και την επανανοτομήσή του για να αποτρέψετε την είσοδο αέρα στην επεμβατική συσκευή. Πραγματοποιήστε την αλλαγή αυτού του καθοδηγητικού σύρματος προσεκτικά για να αποφύγετε την είσοδο αέρα και/ή τραυματισμό. Κατά την επανεισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος, επιβεβαιώστε ότι το άκρο της επεμβατικής συσκευής είναι ελεύθερο εντός του αυλού του αγγείου και δεν ακουμπά στο τοίχωμα του αγγείου. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε τον ακτινοσκόπεο δείκτη της επεμβατικής συσκευής για να επιβεβαιώσετε τη θέση.
- Η ελεύθερη κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εντός της επεμβατικής συσκευής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος κατενσωματωμένου καθοδηγητικού σύρματος, διότι παρέχει στο χρήστη πολύτιμες πληροφορίες αφής. Δοκιμάστε το σύστημα για τυχόν αντίσταση πριν από τη χρήση. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα αμώστασης με ρυθμιζόμενη βαλβίδα, εάν διαπιστωθεί ότι εμποδίζει την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Μην εκτελείτε τοποθέτηση ενδοπρόδεσης (stent) χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα

καθοδηγητικά σύρματα ή λειτουργία σύρματος μέσω του στηρίγματος της ενδοπρόδεσης (stent). Διαφορετικά, η ενδοπρόδεση (stent) μπορεί να υποστεί βλάβη ή το καθοδηγητικό σύρμα μπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί.

- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έχει το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για τη διαδικασία και είναι συμβατό με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στην ιατρική συσκευή (π.χ. καθετήρες διαστολής μπαλονιού ή άλλες επεμβατικές συσκευές) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα.
- Κατά τη σύνδεση του αποσπώμενου σύρματος επέκτασης με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, θα πρέπει να εισάγεται με ασφάλεια στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της επικάλυψης χωρίς PTFE και της επικάλυψης PTFE στο εγγύς άκρο του καθοδηγητικού σύρματος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία στη σύνδεση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Ελέγξτε προσεκτικά το καθοδηγητικό σύρμα για καμπύλες, στροφές ή άλλες ζημιές πριν από τη χρήση και όποτε είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά τη διαμόρφωση του άκρου, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πνίνο.
- Πριν εισαγάγετε το καθοδηγητικό σύρμα, επιβεβαιώστε ότι το άκρο είναι το άνω άκρο και βεβαιωθείτε ότι το εισαγάγετε από το άνω άκρο.
- Διατηρήστε συνεχή έκπλυση φυσιολογικού ορού μεταξύ του καθοδηγητικού καθετήρα και της επεμβατικής συσκευής και μεταξύ της επεμβατικής συσκευής και του καθοδηγητικού σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η έκπλυση αποτρέπει το σχηματισμό σκιαγραφικού και/ή τη δημιουργία θρόμβων στο καθοδηγητικό σύρμα και στον αυλό του καθετήρα.

1. Δυσλειτουργίες

Αδυναμία διαπέρασης μιας βλάβης
Δυσκολία στην αφαίρεση

Σπασμό ή κάμψη του καθοδηγητικού σύρματος
Αφαίρεση επικάλυψης

Ζημιές όπως ο διαχωρισμός

2. Αντίξοα περιστατικά

Θάνατος
Διάτρηση αγγείου
Θρόμβος
Αρρυθμία
Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Μόλυνση
Αιμορραγικές επιπλοκές
Έμφραγμα
Αγγειοσπασμός
Αλλεργική αντίδραση

Διατομή αγγείου
Εμβολή
Ισχαιμία
Αγγειακή απόφραξη
Υπόλοιπα

Πώς χρησιμοποιείται

1. Έλεγχος πριν από τη χρήση

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά και επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα είναι συμβατό με τις επεμβατικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

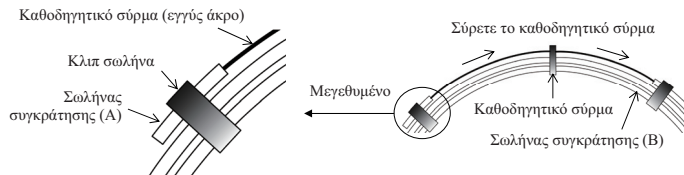
2. Προετοιμασία

- Επλέξτε το κατάλληλο καθοδηγητικό σύρμα για την πλήρεια περιοχή και αφαιρέστε το σωληνάριο υποδοχής που περιέχει το καθοδηγητικό σύρμα από την αποστειρωμένη συσκευασία.
- Γεμίστε τον σωλήνα υποδοχής με

ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό χρησιμοποιώντας μια σύριγγα για να εμποτίσετε ολόκληρη τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι ο ηπαρινισμένος και αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός μπορεί να χυθεί από τον σωλήνα υποδοχής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

γ) Γεμίστε τον αυλό της επεμβατικής συσκευής με τον ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την εισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος.

δ) Απελευθερώστε το καθοδηγητικό σύρμα από το κλιπ και σύρετε αργά το καθοδηγητικό σύρμα, σπρώξτε το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος μέσα από το σωλήνα υποδοχής (B). (Εικόνα 1)



Εικόνα 1

- Όταν το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος εκτείνεται περισσότερο από 4 cm πέρα από το άλλο άκρο του σωλήνα συγκράτησης, εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε το άκρο σύμφωνα με την

καθιερωμένη πρακτική.

ζ) Πιάστε απαλά το καθοδηγητικό σύρμα που βγήκε από το άνω άκρο του σωλήνα συγκράτησης, στο σημείο που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σωλήνα

Δυσλειτουργίες και αντίξοα περιστατικά

Πιθανές δυσλειτουργίες και αντίξοα περιστατικά από τη χρήση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

συγκράτησης και τραβήξτε το καθοδηγητικό σύρμα αργά και προσεκτικά προς τα έξω.

- η) Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος από το σωλήνα συγκράτησης, εγχύστε ξανά ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης. Συνεχίστε την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος αφού η αντίσταση δεν είναι πλέον αισθητή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγχύσει αρκετό ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης, διότι η υδρόφιλη επίστρωση μπορεί να καταστραφεί κατά τη βίαιη αφαίρεση του επικαλυμμένου καθοδηγητικού σύρματος.
- θ) Αφού βγάλετε το καθοδηγητικό σύρμα από το σωλήνα υποδοχής, ελέγξτε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

3. Διαδικασίες για την τοποθέτηση

- Σύστημα μέσω καλωδίου
- α) Εισάγετε προσεκτικά το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος στον αούλο του καθοδηγητικού σύρματος της επεμβατικής συσκευής.
- β) Προωθήστε προσεκτικά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έως ότου το άκρο του βρεθεί ακριβώς κοντά στο άκρο της επεμβατικής συσκευής.
- γ) Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό καθετήρα και εισαγάγετε το σύστημα επεμβατικής συσκευής (με το καθοδηγητικό σύρμα) στον σύνδεσμο Υ.
- δ) Προωθήστε το σύστημα επεμβατικής συσκευής μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα έως ότου το άκρο του συστήματος καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλησίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.
- ε) Σφίξτε τη βαλβίδα αμύστασης του συνδέσμου Υ για να δημιουργήσετε στεγανοποίηση γύρω από την επεμβατική συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εξακολουθεί να είναι ερικτή.
- ζ) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καθοδηγητικό σύρμα κινείται ομαλά.
- η) Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.
- θ) Προωθήστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με

αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.

- ι) Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.
- κ) Προωθήστε την επεμβατική συσκευή έως ότου φτάσετε στη βλάβη, αποτρέποντας παράλληλα τη μετακίνηση του καθοδηγητικού σύρματος. Βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του οδηγού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.

■ Σύστημα ταχείας ανταλλαγής

- α) Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό καθετήρα.
- β) Εισάγετε τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού σύρματος στον σύνδεσμο Υ του καθοδηγητικού καθετήρα.
- γ) Εισάγετε προσεκτικά το άκρο του οδηγού σύρματος στον εισαγωγέα.
- δ) Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα υπό ακτινοσκόπηση έως ότου το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλησίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.
- ε) Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.
- ζ) Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.
- η) Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.
- θ) Αφαιρέστε τη συσκευή ρολής του καθοδηγητικού σύρματος και τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού σύρματος.
- ι) Παρακολουθήστε την επεμβατική συσκευή πάνω από το καθοδηγητικό σύρμα αποτρέποντας την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος και προχωρήστε μέχρι να φτάσετε στη βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.

4. Διαδικασίες για την αντικατάσταση του καθοδηγητικού σύρματος

■ Σύστημα μέσω καλωδίου

- α) Αφαιρέστε αργά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, ενώ παρακολουθείτε την κίνηση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος υπό

ακτινοσκόπηση.

- β) Τοποθετήστε το επόμενο καθοδηγητικό σύρμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας ενότητας «Πώς χρησιμοποιείται».

Μέθοδος φύλαξης

Μην διατηρείτε το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία σε λυγισμένη ή/και βαριά φορτισμένη κατάσταση. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από νερό. Φυλάσσεται σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του καθοδηγητικού σύρματος.

Περιεχόμενα

5 τεμάχια / κουτί

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Σε καμία περίπτωση η «ASAHI INTECC CO., LTD. and its affiliated companies» (εφεξής η «Εταιρεία») δεν ευθύνεται για ατυχήματα, σωματικές βλάβες, αντίζοα περιστατικά που οφείλονται σε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος (των προϊόντων) ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνάδει με τις παρούσες οδηγίες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές είτε (i) που προκύπτουν από την αποθήκευση του προϊόντος (των προϊόντων) μετά την αποστολή από την Εταιρεία είτε (ii) που οφείλονται στην επίλογη ασθενών, τεχνικών χειρουργικής επέμβασης ή άλλων ιατρικών δραστηριοτήτων από το ιατρικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα).

Το «ASAHI Gaia Next» είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της ASAHI INTECC CO.,LTD. στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

ASAHI Gaia Next PCI vezetődrót

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a vezetődrótot, alaposan olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa be a jelen használati útmutató Felhasználási javallatok, Ellenjavallatok, Figyelmeztetések, Övintézkedések és Használati fejezetében foglaltakat. A leíratak figyelmen kívül hagyása nem várt eredményeket, a páciens súlyos testi sérülését vagy halálát okozhatja.

Amennyiben a felhasználónak vagy a páciensnek a vezetődróttal kapcsolatos súlyos incidens jut tudomására, jelentse a tényt a gyártónak és az illetékes hatóságoknak.

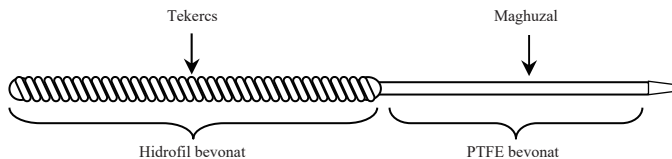
Ez a használati útmutató az ASAHI Gaia Next vezetődróra vonatkozik. A részleteket (a vezetődrót hossza, a röntgensugárzást nem áteresztő rész hossza stb.) lásd a termékcímkén.

Leírások

Ez a vezetődrót egy előre kialakított csúccsal rendelkező vezetődrót, amely előre kialakított változatokban kapható. A vezetődrót külső átmérője 0,36 mm (0,014 hüvelyk). Ez a vezetődrót kompatibilis a meglévő ballonos tágitókatéterekkel és az általános perkután koronária intervenció során használt intervencióeszközökkel. A vezetődrót csúcának disztális része röntgensugárzást nem áteresztő.

A kenhetőség érdekében az eszköz disztális része hidrofíll polimerrel, a vezetőhuzal proximális része pedig poli-tetrafluor-etilénell (PTFE) van bevonva.

A készülék proximális végén, melynek hossza kevesebb, mint 300 cm, egy csatlakozó található egy hosszabbító vezetékhez, amely a kombinált eszköz helyettesítésére használható; ASAHI INTECC hosszabbító vezeték csatlakoztatható, melynek teljes hossza a csatlakoztatást követően 355-400 cm.



Felhasználási javallatok

Ez a vezetődrót általános perkután koronária intervenció (PCI) céljára szolgál. Ballonos tágitókatéterek és egyéb intervencióeszközök katéterek kardio-vaszkuláris rendszerbe történő bevezetésére használható.

A vezetődrótot az idegrendszeri és perifériás érrendszerben nem használható.

Ellenjavallatok

- A tényleges használat előtt erősítse meg a vezetődrót átmérőjét másik intervencióeszközzel.
- Ne használja a vezetődrótot olyan betegeknél, akik allergiás reakciót mutatnak a kontrasztanyagra, vagy akiknek veseműködése károsodott.
- A vezetődrót hidrofíll bevonata PEG400 anyagot tartalmaz. Ne használja a vezetődrótot polietilén-glikolra (PEG) allergiás páciensek esetében.

- Ne használja a vezetődrótot terhes vagy gyaníthatóan terhes páciensek (a röntgensugárzás hatással lehet a magzatra).
- Ezt a vezetődrótot csak olyan intézményben szabad használni, ahol azonnal végrehajthatók a sürgősségi sebészeti beavatkozások. Ha sürgősségi sebészeti beavatkozás nem érhető el, a legrosszabb esetben életveszéllyel fenyegető események is bekövetkezhetnek.

Figyelmeztetések

- A vezetődrótot kizárólag a PCI eljárásokban megfelelően jártas orvos használhatja.
- Soha ne használja ezt a vezetődrótot olyan katéterekkel együtt, amelyeknek fém részei közvetlenül érintkezhetnek a vezetődrót felületével (pl. atherectomiás katéterek, fém tágitók), illetve fém tüskével vagy fém hüvelybehelyezőkkel.
- A vezetődrót használata során fluoroszkópiás megfigyeléssel ellenőrizze és kövesse nyomon a csúcs mozgását. Ne használja olyan ereket, amelyeket nem lehet vagy tud megtekinteni.
- Ne csatlakoztassa a vezetődrótot olyan leválasztható hosszabbító vezetékhez, amelyeket nem az ASAHI INTECC, hanem más gyártó gyártott. Ne manipulálja a vezetődrótot, ha a leválasztható hosszabbító drótot csatlakoztatva van. Ellenkező esetben a vezetődrót megsérülhet, illetve a leválasztható hosszabbító vezeték véletlenül megsérülhet.
- Semmilyen ok miatt ne módosítsa a vezetődrótot!

Övintézkedések

- Használja fel a vezetődrót csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül. Dobjon el minden olyan vezetődrótot, amelynek tellett a lejárata.
- A vezetődrótok törékeny műszerek, és óvatosan kell kezelni őket.
- Ne használja a vezetődrótot, ha a csomagolás kinyílt vagy megsérült. Kizárólag közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki a csomagolást. A vezetődrót kezeléséhez a használatához aszeptikus technikákat használjon.
- A vezetőhuzalt mindig tartsa nedves állapotban, hogy meggátolja a hidrofíll bevonat károsodását.
- Semmilyen szerves oldattal (pl. alkohollal) ne törölje át a vezetődrótot.
- Használat után alkalmazzon megelőző intézkedéseket a fertőzések elkerülésére. A vezetődrótot és a csomagolást orvosi hulladékként dobja ki.
- Soha ne tolja, csavarja be vagy húzza ki a vezetődrótot és soha ne fejtse ki nyomatekót rá, ha ellenállást tapasztal. Az eszköz erővel történő nyomása vagy tolása sérülést okozhat, és/vagy a vezetődrót csúcának leválásához vezethet, illetve közvetlen érkárosodást okozhat. Ennek elmulasztása esetén a vezetődrót károsodhat. Fluoroszkópiával állapítsa meg az ellenállás okát, és járjon el annak megfelelően.
- Mindig lassan és óvatosan vezesse be ill. húzza vissza a vezetődrótot.
- Ha a vezetődrótot nyomattal terheli az ér belsejében, ne terhelje folyamatosan ugyanabba az irányba. Ha nyomattal terheli a vezetődrótot, felválta forgassa az óramutató járásával ellentétes és megegyező irányokba. Ne forgassa több mint két fordulatnyit (720°) ugyanabba az irányba.
- Annak elkerülése érdekében, hogy levegő kerüljön az intervencióeszközbe, a vezetődrót eltávolítsa és a behelyezése során folyamatosan öblítse le a vezetődrótot heparinizált és sterilizált sóoldattal vagy egyéb megfelelő oldattal. A levegőbejutás és/vagy a trauma elkerülése érdekében óvatosan hajtsa végre a vezetődrót cseréjét. A vezetődrót ismételt bevezetések során győződjön meg róla, hogy az intervencióeszköz csúcsa szabadon mozog az ér lumenben, és nem ütöközik az érfalnak. Ennek elmulasztása sérüléshez vezethet. A helyzet megállapításához alkalmazzon sugár át nem eresztő jelzést az intervencióeszközhöz.
- A vezetődrót szabad mozgása a beavatkozási eszközön belül fontos tulajdonság az irányítható vezetődrótnál, mivel a felhasználónak értékes, kézzelfogható visszajelzést ad. Ellenőrizze a

rendszer használat előtt, nem tapasztal-e ellenállást. Állítsa be vagy cserélje ki a hemosztázis-szelepet egy állítható szelepre, ha úgy látja, hogy akadályozza a vezetődrót mozgását.

- Ne végezzen sztent behelyezést, ha több vezetődrótot használ, vagy a sztent bordán keresztül vezeti a drótot. Ellenkező esetben a sztent megsérülhet vagy a vezetődrót elszakadhat vagy szétíródhat.
- Használat előtt erősítse meg, hogy a vezetődrót mérete és formája megfelel-e a beavatkozásnak, és kompatibilis-e az azzal együtt használni kívánt eszközzel.
- Olvassa el a vezetődróttal együtt használandó orvosi eszközökhöz (pl. ballonos tágitó katéterekhez vagy egyéb intervencióeszközökhöz) mellékelt használati utasítást.
- Amikor a leválasztható hosszabbító drótot ehhez a vezetődróthoz csatlakoztatja, azt megfelelően kell behelyezni a vezetődrót proximális végén

található nem PTFE bevonat és PTFE bevonat közti határvonalba. Ha a csatlakozás során bármilyen rendellenességet észlel a csatlakozásban, azonnal függessze fel a vezetődrót használatát.

- Használat előtt, és amikor csak lehetséges a használat során, ellenőrizze a vezetődrótot, nincs-e rajta meghajlás, megtörés vagy egyéb sérülés. Ne használja a vezetődrótot, ha az sérült.
- A csúcs formázásakor figyeljen arra, hogy ne sértse meg a tekercset.
- A vezetődrót behelyezése előtt ellenőrizze, hogy melyik a disztális vége, és figyeljen arra, hogy azt a disztális végéről helyezze be.
- Az eljárás során a vezető katéter és az intervencióeszköz, valamint az intervencióeszköz és a vezetődrót között folyamatos sóoldatos öblítést kell alkalmazni. Az öblítést megakadályozza a kontrasztanyag és/vagy a vérrögök képződését a vezetődróton és a katéter lumenében.

Működési problémák és nemkívánatos események

A vezetődrót használatá révén fellépő lehetséges működési problémák és nemkívánatos események többek között az alábbiak lehetnek:

1. Működési problémák

Sikertelen átjutás a sérülésen	A vezetődrót törése vagy meghajlása	Sérülések, pl. szétválás
Nehézség az eltávolítás során	A bevonat leválása	

2. Mellékhatások

Halál	Fertőzés	Érszakadás
Az ér perforációja	Vérzési komplikációk	Légembólia
Thrombus	Infarktus	Iszkémia
Aritmia	Érgörcs	Érelzáródás
A vérnyomás csökkenése	Allergiás reakciók	Maradványok

Használat

1. Ellenőrzések a használat előtt

- Használat előtt vizsgálja meg figyelmesen, és győződjön meg róla, hogy a vezetődrót és csomagolása sértetlen-e.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vezetődrót kompatibilis-e a használni tervezett intervencióeszközökkel.

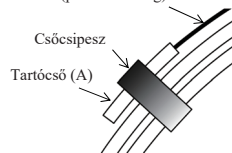
2. Előkészítés

- Válassza ki az érintett területhez legmegfelelőbb vezetődrótot, és távolítsa el a vezetődrótot tartalmazó csőtartót a steril csomagolásból.
- Fecskendő segítségével töltsse fel a csőtartót heparinizált és sterilizált sóoldattal, és áztassa be a teljes eszközt. Vigyázzon arra, hogy a

heparinizált és sterilizált sóoldat ennél a műveletnél kifolyhat a csőtartóból.

- A vezetődrót behelyezése előtt töltsse fel az intervencióeszköz lumenjét heparinizált és sterilizált sóoldattal.

Vezetődrót (proximális vég)



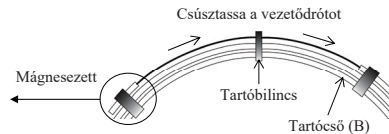
1. ábra

- Amikor a vezetődrót disztális vége legalább 4 cm-re van a tartócső másik végétől, akkor szükség esetén alakítsa a csúcsot a normál gyakorlatnak megfelelően.
- Fogja meg óvatosan a vezetődrótot, amely a tartócső disztális végéből jött ki, mégpedig a tartócsőhöz legközelebbi ponton, majd húzza ki a vezetődrótot lassan és óvatosan.
- Ha ellenállás érezhető a vezetődrót csőtartóból történő eltávolítása során, fesszkedezzen ismét heparinizált és sterilizált sóoldatot a csőtartóba. Az ellenállás megszűnése után folytassa a vezetődrót eltávolítását. Győződjön meg arról, hogy elengedő mennyiségű heparinizált és sterilizált sóoldatot fesszkedezzen be a csőtartóba, mert a hidrofíl bevonat megsérülhet a bevonatos vezetődrót erővel történő eltávolításakor.
- Miután kihúzza a vezetődrótot a tartócsőből, vizsgálja meg, és győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg.

3. A behelyezés műveletei

- Over-the-wire rendszer
 - Óvatosan nyomja be a vezetődrót disztális végét az intervencióeszköz vezetődrót lumenébe.
 - Óvatosan vezesse be a vezetődrótot, míg a csúcsa az intervencióeszköz csúcsának közelébe nem ér.
 - Kösse be a vezetőkatétert, és nyomja be az intervencióeszközrendszert (a vezetődróttal) az Y-csatlakozóba.
 - Tolja át az intervencióeszközrendszert a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót-rendszert

- Vegye ki a vezetődrótot a tartóbilincsből, és lassan csúszassa ki a vezetődrótot, majd tolja át a vezetődrót disztális végét a csőtartón (B). (1. ábra)



csúcsa meg nem közelíti a vezetőkatéter hegyét.

- Az intervencióeszköz körüli szigetelés létrehozása érdekében szorítsa meg az Y-csatlakozó hemosztázis-szelepet. Győződjön meg róla, hogy a vezetődrót mozgása továbbra is lehetséges-e.
- Ellenőrizze, hogy a vezetődrót simán mozog-e.
- Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatékesszközt a vezetődróthoz.
- Fluoroszkópia alatt tolja előre ezt a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.
- Figyelje a vezetődrót mozgását az ereken.
- A lézió eléréséig tolja be az intervencióeszközt, miközben megakadályozza a vezetődrót mozgását. Biztosítsa, hogy a vezetődrót disztális csúcsa és annak érből történő elhelyezkedése az intervencióeszköz használatá során is látható legyen.

■ Gyors cserélőrendszer

- Kösse be a vezetőkatétert.
- Nyomja be a vezetődrót bevezetőjét a vezetőkatéter Y-csatlakozójába.
- Óvatosan tolja be a vezetődrót csúcsát a bevezetőbe.
- Fluoroszkópia mellett tolja át a vezetődrótot a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót csúcsa a vezetőkatéter csúcsának közelébe nem kerül.
- Szükség esetén csatlakoztassa a nyomatékesszközt a vezetődróthoz.

- f) Fluoroszkópia alatt tolja előre a vezetődrtöt, hogy átjusson a léziön.
Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrtöt áthaladt-e a beszűkült részen.
- g) Figyelje a vezetődrt mozgását az erekben.
- h) Távolítsa el a vezetődrt nyomatóeszközét és a vezetődrt bevezetőjét.
- i) Kövesse nyomon az intervenciós eszközt a vezetődrt mentén, miközben megakadályozza a vezetődrt mozgását, és addig tolja előre, míg el nem éri a léziót.
Biztosítsa, hogy a vezetődrt disztális

csúcsa, és annak érben történő elhelyezkedése az intervenciós eszköz használata során is látható legyen.

4. A vezetődrt cseréjének eljárásai

■ Over-the-wire rendszer

- a) Lassan távolítsa el a vezetődrtöt annak folyamatos, fluoroszkópiás megfigyelése során.
- b) A „Használat” fejezetben leírtaknak megfelelően helyezze be a következő vezetődrtöt.

A tárolás módja

Ne tartsa a vezetődrtöt és csomagolását hajlított vagy erősen terhelt állapotban. Ezt a vezetődrtöt és csomagolását víztől távol kell tárolni. Hűvös, sötét és száraz helyen tárolja.

Lejárat

A lejárat dátumát lásd a vezetődrt csomagolásának címkéjén.

A csomag tartalma

5 darab / doboz

Felelősség kizárása

Az „ASAHI INTECC CO., LTD. és partnervállalatai” (a továbbiakban a „Vállalat”) semmilyen esetben sem vonható felelősségre az olyan balesetek, személyi sérülések vagy mellékhatások miatt, melyek a termék(ek) nem megfelelő, illetve a jelen utasításokkal összhangban nem lévő használatából adódnak. A vállalat semmiképpen nem felel azokért a károkért, amelyek vagy (i) a termék(ek)nek a vállalatától való kiszállítása utáni tárolására, vagy (ii) a betegek, sebészeti eljárások vagy más orvosi tevékenység megválasztására vezethetők vissza.

Az „ASAHI Gaia Next” is az ASAHI INTECC CO.,LTD. védjegye vagy bejegyzett védjegye Japánban és egyéb országokban.

ASAHI Gaia Next Filo guida per ICP

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il filo guida, leggere attentamente e attenersi a quanto riportato nelle sezioni "Indicazioni per l'uso", "Controindicazioni", "Avvertenze", "Precauzioni" e "Modalità di utilizzo" delle presenti Istruzioni per l'uso. In caso contrario potrebbero verificarsi complicanze, comprese gravi lesioni al paziente, anche mortali.

Se l'utente o il paziente viene a conoscenza di un incidente grave avvenuto in correlazione al filo guida, è tenuto a segnalarlo al produttore e alle autorità competenti.

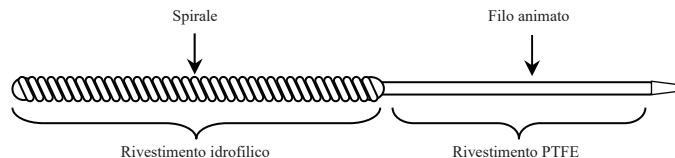
Le presenti Istruzioni per l'uso si applicano ad ASAHI Gaia Next. Per ulteriori informazioni (lunghezza del filo guida, lunghezza della sezione radiopaca, ecc.), consultare l'etichetta del prodotto.

Descrizioni

Si tratta di un filo guida orientabile con punta sagomabile, disponibile in diverse varianti presagomate. Il diametro esterno del filo guida è pari a 0,36 mm (0,014 pollici). Il filo guida è compatibile con cateteri per dilatazione a palloncino e altri dispositivi interventistici utilizzati negli interventi coronarici percutanei (ICP). La parte distale della punta del filo guida è radiopaca.

Ai fini della scorrevolezza, la parte distale del dispositivo è rivestita con polimero idrofilico, mentre la parte distale del filo guida è rivestita con politetrafluoroetilene (PTFE).

Sul terminale distale del dispositivo, inferiore a 300 cm, è presente un collegamento per un filo di prolunga, utilizzato per sostituire il dispositivo abbinato; può essere collegato il filo di prolunga ASAHI INTECC, raggiungendo una lunghezza totale dopo l'abbinamento di 355-400 cm.



Indicazioni per l'uso

Il filo guida è progettato per interventi coronarici percutanei (ICP). Viene utilizzato per l'introduzione e il posizionamento di cateteri per dilatazione a palloncino e altri dispositivi interventistici nel sistema cardiovascolare.

Il filo guida non è destinato all'uso nel sistema neurovascolare e nei vasi periferici.

Controindicazioni

- Prima dell'uso effettivo, verificare la compatibilità del diametro del filo guida con gli altri dispositivi interventistici.
- Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici ai mezzi di contrasto o affetti da disfunzione renale.

- Il rivestimento idrofilico del filo guida contiene PEG400. Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici al polietilenglicole (PEG).
- Non utilizzare il filo guida nelle pazienti in stato di gravidanza, anche presunto, (i raggi X possono nuocere al feto).
- Il filo guida deve essere utilizzato in strutture sanitarie in grado di eseguire prontamente un intervento chirurgico d'urgenza. Nel caso in cui sia impossibile eseguire un intervento chirurgico

d'urgenza, nel peggiore dei casi possono verificarsi eventi con rischio per la vita del paziente.

- Il filo guida è presterilizzato con ossido di etilene (EOG) ed è inteso esclusivamente monouso. Non riutilizzare né risterilizzare. Se riutilizzato o risterilizzato, le prestazioni o la qualità del filo guida possono risultare compromesse, con rischio di complicanze, comprese infezioni.

Avvertenze

- Il filo guida deve essere utilizzato esclusivamente da un medico qualificato per i trattamenti ICP.
- Non utilizzare il filo guida in abbinamento a cateteri con parti metalliche che possano entrare direttamente a contatto con la superficie del filo guida (p.es. cateteri per aterectomia, dilatatori metallici), aghi metallici o inserter con guaina metallica.
- Durante l'uso del filo guida, controllare e monitorare il movimento della punta sotto guida

- fluoroscopica. Non utilizzare in aree vascolari non visualizzate o impossibili da visualizzare.
- Non collegare il filo guida a fili di prolunga scollegabili prodotti da aziende diverse da ASAHI INTECC. Non maneggiare il filo guida con il filo di prolunga scollegabile collegato. In caso contrario, il filo guida può subire danni o la prolunga rimovibile può staccarsi accidentalmente.
- Non modificare il filo guida per nessun motivo.

Precauzioni

- Non utilizzare il filo guida oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta. Eliminare il filo guida se la data di scadenza è stata superata.
- I fili guida sono strumenti delicati che vanno maneggiati con cura.
- Non utilizzare il filo guida se la confezione è aperta o danneggiata. Non aprire la confezione fino al momento immediatamente precedente all'uso. Maneggiare e utilizzare il filo guida in condizioni estetiche.
- Mantenere sempre umido il filo guida, in modo da evitare danni al rivestimento idrofilico.
- Non pulire il filo guida con soluzioni organiche come alcol.
- Dopo l'utilizzo adottare misure preventive contro le infezioni. Smaltire il filo guida e la relativa confezione come rifiuti medicali.
- In caso di resistenza, non spingere, ruotare, ritrarre o torcere il filo guida. Torcere o spingere il filo guida a fronte di resistenza può danneggiarlo e/o causarne il distacco della punta ovvero danneggiare direttamente un vaso. In caso contrario, il filo guida può subire danni. Determinare le cause della resistenza tramite fluoroscopia e intraprendere le necessarie azioni correttive.

- Far avanzare o ritrarre il filo guida sempre lentamente e con cautela.
- Durante la torsione del filo guida all'interno di un vaso sanguigno, non procedere sempre nella stessa direzione, bensì ruotarlo alternativamente in senso orario e antiorario. Non eseguire più di due rotazioni (720°) nello stesso senso.
- Durante la rimozione o il reinserimento del filo guida, irrigarlo con soluzione salina eparinata e sterilizzata o con altra soluzione idonea per evitare l'ingresso di aria nel dispositivo interventistico. Eseguire con cautela la sostituzione del filo guida per evitare l'ingresso di aria e/o traumi. Quando si introduce nuovamente il filo guida, verificare che la punta del dispositivo interventistico sia libera all'interno del lume del vaso e non urti contro la parete del vaso stesso. In caso contrario, si possono provocare traumi. Utilizzare il marcatore radiopaco del dispositivo interventistico per verificare la posizione.
- Il movimento libero del filo guida all'interno del dispositivo interventistico è una caratteristica importante dei sistemi a filo guida orientabile perché fornisce all'operatore utili informazioni tattili. Prima dell'uso verificare la presenza di resistenze nel sistema. Se si nota che la valvola

emostatica si oppone al movimento del filo guida, regolarla o sostituirla con una valvola regolabile.

- Non eseguire il posizionamento di stent utilizzando più di un filo guida o facendo passare il filo attraverso le maglie dello stent. In caso contrario, lo stent può danneggiarsi o il filo guida può rompersi o spezzarsi.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida abbia le dimensioni e la forma corrette per la procedura specifica e sia compatibile con il dispositivo da abbinare.
- Vedere le Istruzioni per l'uso allegate al dispositivo medico (p.es. cateteri per dilatazione a palloncino o altri dispositivi interventistici) da abbinare al filo guida.
- Quando si collega il filo di prolunga scollegabile al filo guida, questo deve essere inserito saldamente tra il segmento rivestito in PTFE e il segmento non rivestito in PTFE sull'estremità

prossimale del filo guida. In caso di anomalia durante l'inserimento, interrompere immediatamente l'uso del filo guida.

- Controllare attentamente l'eventuale presenza di piegature, torsioni o altri danni del filo guida prima dell'uso e, se possibile, durante la procedura. Non utilizzare il filo guida se è danneggiato.
- Durante la sagomatura della punta, prestare attenzione a non danneggiare la spirale.
- Prima di inserire il filo guida, individuare l'estremità distale e verificare che venga inserito con questa estremità.
- Durante la procedura, mantenere un'irrigazione continua tra il catetere guida e il dispositivo interventistico, e tra il dispositivo interventistico e il filo guida. L'irrigazione impedisce la presenza di mezzo di contrasto e/o la formazione di coaguli sul filo guida e nel lume del catetere.

Malfunzionamenti ed effetti avversi

I possibili malfunzionamenti ed effetti avversi durante l'uso del filo guida comprendono, tra gli altri:

1. Malfunzionamenti

Mancato attraversamento di una lesione	Rottura o piegatura del filo guida	Danni quali distacco
Difficoltà di rimozione	Distacco del rivestimento	

2. Effetti avversi

Decesso	Infezioni	Dissezione vascolare
Perforazione vascolare	Complicanze emorragiche	Embolia
Trombo	Infarto	Ischemia
Aritmia	Vasospasmo	Occlusione vascolare
Riduzione della pressione arteriosa	Reazione allergica	Residuale

Modalità di utilizzo

1. Ispezione prima dell'uso

- Prima dell'uso, eseguire un'ispezione accurata e verificare che il filo guida e la relativa confezione non siano danneggiati.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida sia compatibile con il dispositivo interventistico da utilizzare.

2. Preparazione

- Selezionare il filo guida più adatto per l'area interessata e rimuovere dalla confezione sterile il tubo contenitore con il filo guida.
- Riempire il tubo contenitore con soluzione salina eparinata e sterilizzata utilizzando una siringa, in modo da immergere l'intero dispositivo. Durante l'operazione, la soluzione salina eparinata e sterilizzata può fuoriuscire dal tubo contenitore.

- Prima di inserire il filo guida, riempire il lume del dispositivo interventistico con la soluzione salina eparinata e sterilizzata.
- Rilasciare il filo guida dal fermo di coda e

Filo guida (estremità prossimale)

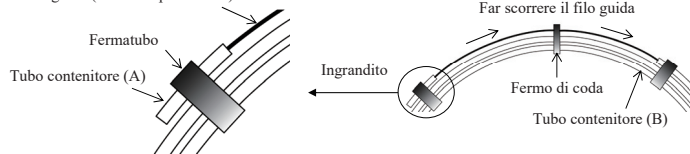


Figura 1

- Quando l'estremità distale del filo guida sporge di oltre 4 cm dall'altra estremità del tubo contenitore, sagomare la punta, se necessario, secondo le pratiche standard.
- Afferrare delicatamente il filo guida fuoriuscito dall'estremità distale del tubo contenitore, il più vicino possibile a quest'ultimo, ed estrarlo lentamente e con cautela.
- In caso di resistenza durante la rimozione del filo guida dal tubo contenitore, iniettare altra soluzione salina eparinata e sterilizzata nel tubo contenitore. Continuare a rimuovere il filo guida quando non si avverte più resistenza. Assicurarsi di iniettare nel tubo contenitore sufficiente soluzione salina eparinata e sterilizzata perché il rivestimento idrofobico potrebbe subire danni se si rimuove con forza il filo guida rivestito.
- Dopo avere estratto il filo guida dal tubo contenitore, ispezionarlo per verificare che non sia danneggiato.

3. Procedure per l'inserimento

- Sistema Over-the-wire
 - Inserire con attenzione l'estremità distale del filo guida nel lume del filo guida del dispositivo interventistico.
 - Far avanzare con cautela il filo guida finché la punta non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dispositivo interventistico.
 - Innestare il catetere guida e inserire il sistema del dispositivo interventistico (con il filo guida) nel connettore a Y.
 - Far avanzare il sistema del dispositivo

farlo scorrere lentamente, spingendone l'estremità distale attraverso il tubo contenitore (B). (Figura 1)

- interventistico attraverso il catetere guida finché la punta del sistema del filo guida non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
- Serrare la valvola emostatica del connettore a Y per creare una chiusura ermetica attorno al dispositivo interventistico. Verificare che il movimento del filo guida sia ancora possibile.
- Verificare che il filo guida si muova agevolmente.
- Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione. Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.
- Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- Far avanzare il dispositivo interventistico fino a raggiungere la lesione, evitando che il filo guida si sposti. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

■ Sistema di sostituzione rapida

- Innestare il catetere guida.
- Inserire l'introduttore del filo guida nel connettore a Y del catetere guida.
- Inserire con cautela la punta del filo guida nell'introduttore.
- Far avanzare il filo guida attraverso il catetere sotto guida fluoroscopica finché la punta del filo guida non si trova in posizione

- appena proximale rispetto alla punta del catetere guida.
- e) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- f) Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione. Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.
- g) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- h) Rimuovere il dispositivo di controllo della torsione del filo guida e l'introduttore del filo guida.
- i) Guidare il dispositivo interventistico sul filo guida evitandone lo spostamento e avanzare fino a raggiungere la lesione. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.
4. Procedure per la sostituzione del filo guida
- Sistema Over-the-wire
- a) Rimuovere lentamente il filo guida, controllandone il movimento sotto guida fluoroscopica.
- b) Inserire il nuovo filo guida secondo le indicazioni contenute nella presente sezione "Modalità di utilizzo".

Metodo di conservazione

Non conservare il filo guida e la relativa confezione ripiegati e/o sottoposti a carichi pesanti. Il filo guida e la relativa confezione devono essere conservati lontano dall'acqua. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Data di scadenza

La data di scadenza è indicata sull'etichetta applicata sulla confezione del filo guida.

Contenuto

5 pezzi / scatola

Esclusione di responsabilità

In nessun modo "ASAHI INTECC CO., LTD. e le sue affiliate" (in seguito denominate "Azienda") possono essere ritenute responsabili per incidenti, lesioni personali ed effetti avversi dovuti a qualsiasi utilizzo improprio di questo/i prodotto/i in contravvenzione alle presenti istruzioni. In nessun caso l'Azienda può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti (i) dalla conservazione dei prodotti dopo la spedizione dall'Azienda stessa o (ii) causati dalla selezione di pazienti, tecniche chirurgiche o altre attività mediche effettuate dalla struttura medica che utilizza i prodotti.

"ASAHI Gaia Next" è un marchio commerciale o un marchio registrato di ASahi INTECC CO.,LTD. in Giappone e in altri Paesi.

ASAHI Gaia Next Prowadnik PCI

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem przewodnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w punktach „Wskazania do stosowania”, „Przeciwwskazania”, „Przestrogi”, „Środki ostrożności” oraz „Sposób korzystania z produktu”, będących częścią niniejszej instrukcji użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować powikłaniami, które mogą prowadzić do poważnych urazów u pacjenta bądź do jego śmierci.

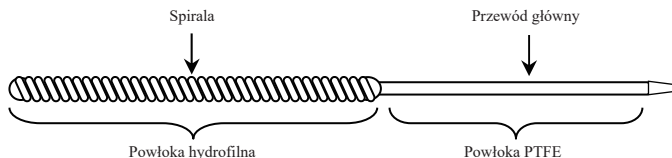
Jeżeli użytkownik lub pacjent dowie się o poważnym zdarzeniu związanym z przewodnikiem, powinien zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi.

Niniejsza „Instrukcja użytkowania” dotyczy wyrobu ASAHI Gaia Next. Informacje szczegółowe (długość przewodnika, długość odcinka nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, itd.) podano na etykiecie produktu.

Opis

Ten przewodnik to sterowany przewodnik z formowaną końcówką, dostępny w wersjach wstępnie formowanych. Średnica zewnętrzna przewodnika wynosi 0,36 mm (0,014 cala). Ten przewodnik jest kompatybilny z istniejącymi balonowymi cewnikami dylatacyjnymi i innymi urządzeniami interwencyjnymi stosowanymi w powszechnej przeszskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Dystalna część końcówki przewodnika nie przepuszcza promieni rentgenowskich.

Aby zapewnić poślizg, dystalna część urządzenia jest pokryta hydrofilnym polimerem, a proksymalna część przewodnika jest pokryta politetrafluoroetylenem (PTFE). Na proksymalnym końcu urządzenia, o długości mniejszej niż 300 cm, znajduje się złącze dla przewodu przedłużającego, który jest używany do wymiany urządzenia połączonego; można podłączyć przewód przedłużający ASAHI INTECC, a całkowita długość po połączeniu wynosi 355-400 cm.



Wskazania do stosowania

Ten przewodnik jest przeznaczony do ogólnej przeszskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Można go używać do wprowadzania i pozycjonowania balonowych cewników dylatacyjnych i innych urządzeń interwencyjnych w obrębie układu krążenia.

Ten przewodnik nie jest przeznaczony do stosowania w strukturach nerwowo-naczyniowych i naczyniach obwodowych.

Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność średnicy przewodnika z innym urządzeniem interwencyjnym.
- Nie należy stosować przewodnika u pacjentów, u których występuje reakcja alergiczna na środki kontrastowe lub z zaburzeniami czynności nerek.
- Ten przewodnik zawiera w swojej powłoce hydrofilnej PEG400. Nie stosować przewodnika u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne na glikol polietylenowy (PEG).
- Nie stosować przewodnika u pacjentek w ciąży lub pacjentek, które mogą być w ciąży (promieniowanie rentgenowskie może szkodliwie oddziaływać na płód).
- Prowadnik musi być używany w instytucji, w której można przeprowadzać zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym. Jeśli przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym będzie niemożliwe, w najgorszym przypadku może dojść do zdarzeń zagrażających życiu.
- Prowadnik jest wstępnie sterylizowany tlenkiem etylenu (EOG) i jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie lub ponowna sterylizacja mogą negatywnie wpłynąć na działanie lub jakość przewodnika, a także sprzyjają ryzyku wystąpienia powikłań, z zakażeniem włącznie.

Przestrogi

- Prowadnik może być używany wyłącznie przez lekarza, który został w pełni przeszkolony w zakresie PCI.
- Nigdy nie należy używać tego przewodnika w połączeniu z cewnikami posiadającymi metalowe części, które mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią tego przewodnika (np. cewniki do aterekotomii, metalowe rozszerzacze), metalowymi igłami lub wkładkami w osłonie metalowej.
- Podczas stosowania przewodnika należy sprawdzać i monitorować ruch jego końcówki
- Prowadnik może być używany wyłącznie przez obszarach naczyń, które nie są lub nie mogą zostać uwidocznione.
- Nie należy łączyć tego przewodnika z przedłużaczami wyprodukowanymi przez firmy inne niż ASAHI INTECC. Nie ruszać przewodnikiem, gdy podłączony jest przedłużacz. W przeciwnym razie przewodnik może zostać uszkodzony lub przedłużacz może zostać nieumyślnie odłączony.
- W żaden sposób nie modyfikować przewodnika.

Środki ostrożności

- Nie używać tego przewodnika po upływie daty ważności wskazanej na etykiecie. Wszystkie przewodniki, których data ważności upłynęła, należy wyrzucić.
- Przewodniki to delikatne instrumenty i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, nie należy używać przewodnika. Produkt należy rozpakować zawsze bezpośrednio przed użyciem. Podczas przenoszenia i użycia przewodnika należy zachować zasady aseptyki.
- Należy zawsze utrzymywać przewodnik w stanie wilgotnym, aby nie uszkodzić jego powłoki hydrofilnej.
- Nie należy wycierać tego przewodnika używając roztworu organicznego, np. alkoholu.
- Po użyciu narzędzia należy podjąć środki zapobiegające zakażeniu. Zutylizować przewodnik i opakowanie jako odpad medyczny.
- Nigdy nie należy pchać, wkręcać, wyciągać ani obracać przewodnika, który napotyka na opór. Obracanie lub pchanie przewodnika wbrew napotkanemu oporowi może spowodować uszkodzenie i/lub oddzielenie końcówki przewodnika lub uszkodzić bezpośrednio naczynie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego przewodnika. Należy określić fluoroskopowo przyczynę oporu i podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.
- Prowadniki należy zawsze wsuwać i wyjmować powoli i ostrożnie.
- Obracając ten przewodnik w naczyniu krwionośnym, nie należy obracać go ciągle w tym samym kierunku. Obracając przewodnik,

należy to czynić naprzemiennie zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie należy obracać o więcej niż dwa obroty (720°) w tym samym kierunku.

- Podczas wyciągania i ponownego wprowadzania przewodnika należy przepłukać go heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej lub innym odpowiednim roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do urządzenia zabiegowego. Przewodnik należy wymieniać ostrożnie, aby nie dopuścić powietrza i/lub nie spowodować urazu. Wprowadzając przewód ponownie, należy upewnić się, czy końcówka urządzenia zabiegowego jest swobodna w świetle naczyń i czy nie jest nastawiona na ścianę naczyń. W przeciwnym razie może dojść do urazu. Aby potwierdzić położenie, należy zastosować nieprzepuszczający promieni rentgenowskich znacznik urządzenia zabiegowego.
- Swobodny ruch przewodnika w urządzeniu zabiegowym jest ważną cechą sterowanego systemu przewodnika, ponieważ daje użytkownikowi cenne, realne informacje. Przed użyciem należy sprawdzić system pod kątem występowania oporu. Wyregulować lub wymienić zastawkę hemostatyczną na zastawkę regulowaną jeśli hamuje ruch przewodnika.
- Nie umieszczać stentu przy użyciu więcej niż jednego przewodnika lub operując przewodnikiem za pośrednictwem rozprórki stentu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stentu bądź pęknięcia lub rozpadnięcia się przewodnika.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ten przewód ma odpowiedni rozmiar i kształt do

zabiegu oraz czy jest kompatybilny z urządzeniem, które będzie używane w połączeniu z nim.

- Należy zapoznać się z Instrukcją użycia dołączoną do wyrobu medycznego (np. balonowych cewników dylatacyjnych lub innych urządzeń interwencyjnych), który ma być używany w połączeniu z tym przewodnikiem.
- Podłączając przedłużacz do tego przewodnika należy go bezpiecznie włożyć do linii granicznej pomiędzy powłoką niewykonaną z PTFE a powłoką z PTFE na proksymalnym końcu przewodnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w połączeniu, należy natychmiast zaprzestać używania przewodnika.
- Dokładnie sprawdzić przewód, czy nie uległ zgięciu, zagięciu lub innym uszkodzeniom przed użyciem, a także dokładnie go sprawdzać, jeśli to możliwe, podczas wykonywania zabiegu. Nie używać uszkodzonego przewodnika.
- Podczas formowania końcówki należy uważać, aby nie uszkodzić spirali.
- Przed wprowadzeniem przewodnika należy sprawdzić, który koniec jest końcem dystalnym i upewnić się, że jest on wprowadzany od strony dystalnej.
- Podczas zabiegu należy utrzymywać ciągłe płukanie solą fizjologiczną pomiędzy cewnikiem prowadzącym a urządzeniem interwencyjnym oraz pomiędzy urządzeniem interwencyjnym a przewodnikiem. Płukanie zapobiega gromadzeniu się środka kontrastowego i/lub tworzeniu się skrzepów na przewodniku i w świetle cewnika.

Perforacja naczyń

Powikłania związane z krwawieniem

Zator

Powstanie zakrzepu

Zawał

Ischemia

Arytmia

Skurcz naczyń

Okluzja naczyńiowa

Obniżenie ciśnienia krwi

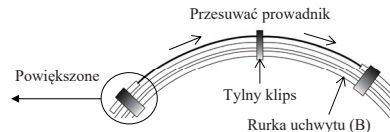
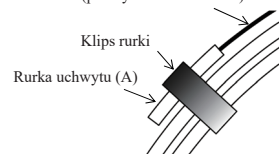
Reakcja alergiczna

Ryzyko szczątkowe

Sposób korzystania z produktu

1. Sprawdzenie przed użyciem
 - a) Przed użyciem dokładnie sprawdzić i potwierdzić, czy przewód i opakowanie nie są uszkodzone.
 - b) Przed użyciem potwierdzić, że przewód jest kompatybilny z mającymi zostać użytymi urządzeniami interwencyjnymi.
2. Przygotowanie
 - a) Wybrać najbardziej odpowiedni przewód dla zmienionego chorobowo miejsca i wyciągnąć rurkę uchwytu zawierającą przewód ze sterylnego opakowania.
 - b) Napelnić rurkę uchwytu heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej przy użyciu strzykawki, aby nawilżyć całe urządzenie. Należy pamiętać, że heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej może wtedy wylać się z rurki uchwytu.
 - c) Przed włożeniem przewodnika napelnić światło urządzenia zabiegowego heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej.
 - d) Zwołnić przewód z tylnego klipsa i wolno go przesunąć, pchnąć dystalną końcówkę przewodnika przez rurkę uchwytu (B) (rys. 1).

Przewodnik (proksymalna końcówka)



Rysunek 1

- e) Gdy końcówka dystalna przewodnika jest przedłużona o ponad 4 cm poza drugi koniec rurki uchwytu, wówczas, jeśli jest to konieczne, należy uformować końcówkę w sposób standardowy.
 - f) Delikatnie chwycić przewód wystający z dystalnego końca rurki uchwytu, możliwie najbliżej rurki uchwytu oraz powoli i ostrożnie wyciągnąć przewód.
 - g) Jeśli odczuwalny jest opór podczas wyjmowania przewodnika z rurki uchwytu, należy ponownie wstrzyknąć heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej do rurki uchwytu. Kiedy opór przestanie być wyczuwalny, należy kontynuować wyciąganie przewodnika. Należy upewnić się, że wstrzyknięto odpowiednią ilość heparynizowanego i jałowego roztworu soli fizjologicznej do rurki uchwytu, ponieważ podczas wyjmowania powlekanego przewodnika z użyciem dużej siły może dojść do uszkodzenia powłoki hydrofilnej.
 - h) Wyciągnąć przewód z rurki uchwytu, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.
3. Procedury wkładania
 - System over-the-wire
 - a) Włożyć dystalną końcówkę przewodnika ostrożnie w światło przewodnika urządzenia interwencyjnego.
 - b) Wprowadzić ten przewód ostrożnie do momentu, gdy jego końcówka jest w pozycji proksymalnej do końcówki urządzenia interwencyjnego.
 - c) Zaczepić cewnik prowadzący i włożyć urządzenie interwencyjne (z przewodnikiem)

Usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane

Eventualnie usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane związane z użyciem przewodnika obejmują m.in.:

1. Nieprawidłowe działanie

Niemożliwość przejścia za zmianę	Złamanie lub wygięcie przewodnika	Uszkodzenia takie jak oddzielenie
Trudności w wyjęciu	Odechodzenie powłoki	

2. Działania niepożądane

Śmierć	Zakażenie	Rozwarstwienie ściany naczyń
--------	-----------	------------------------------

- do złącza Y.
- Wprowadzać urządzenie interwencyjne przez cewnik prowadzący do momentu, gdy końcówka przewodnika będzie w pozycji proksymalnej w stosunku do końcówki cewnika prowadzącego.
 - Zacisnąć zastawkę hemostatyczną złącza Y, aby utworzyć uszczelnienie dookoła urządzenia interwencyjnego. Upewnić się, czy ruch przewodnika jest ciągle dozwolony.
 - Sprawdzić, czy przewód porusza się gładko.
 - Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodnika, jeśli to konieczne.
 - Wprowadzić przewód pod obserwacją fluoroskopową, aby przejść przez zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
 - Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.
 - Wprowadzić urządzenie interwencyjne do momentu osiągnięcia zmiany zapobiegając ruchowi przewodnika. Zapewnić, by dystalna końcówka przewodnika i jego umiejscowienie były widoczne podczas poruszania urządzeniem interwencyjnym.
- System szybkiej wymiany
- Zacześć cewnik prowadzący.
 - Wprowadzić introduktor przewodnika do złącza Y cewnika prowadzącego.
 - Ostrożnie włożyć końcówkę przewodnika do
- introduktora.
- Wprowadzić przewód przez cewnik wprowadzający pod kontrolą fluoroskopową do momentu, gdy końcówka przewodnika znajdzie się w pozycji proksymalnej do końcówki cewnika wprowadzającego.
 - Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodnika, jeśli to konieczne.
 - Wprowadzić przewód pod kontrolą fluoroskopową, aby przejść za zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
 - Obserwować ruch przewodnika w naczyniach.
 - Usunąć urządzenie obrotowe przewodnika oraz introduktor przewodnika.
 - Śledzić urządzenie interwencyjne za przewodnikiem, zapobiegając ruszaniu się przewodnika, wprowadzać do momentu dotarcia do zmiany. Zadbaj o to, by dystalna końcówka przewodnika i jej miejsce w naczyniu były widoczne w trakcie wykonywania ruchów urządzeniem interwencyjnym.
4. Procedury wymiany przewodnika
- System over-the-wire
- Usunąć wolno przewód, monitorując ruch przewodnika fluoroskopowo.
 - Włożyć następny przewód zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Sposób korzystania z produktu”.

wskutek niewłaściwego wyboru pacjentów, technik chirurgicznych lub jakichkolwiek innych działań lekarskich powziętych przez instytucję medyczną korzystającą z produktu.

„ASAHI Gaia Next” jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ASAHI INTECC CO.,LTD. w Japonii i innych krajach.

Przechowywanie

Nie przechowywać przewodnika i opakowania w pozycji zgiętej i/lub silnie obciążonej. Przewódnik i opakowanie należy przechowywać z dala od wody. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

Data ważności

Data ważności jest podana na etykiecie umieszczonej na opakowaniu przewodnika.

Zawartość

5 sztuk / pudełko

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Firma „ASAHI INTECC CO., LTD. i jej podmioty zależne” (odtąd nazywane „Firmą”) w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, obrażenia osób, zdarzenia niepożądane spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu lub produktów albo jakimkolwiek innym działaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe (i) wskutek nieprawidłowego przechowywania produktu po jego wysyłce z Firmy lub (ii)

ASAHI Gaia Next Fio guia PCI

Instruções de utilização

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este fio guia e observe o estipulado nas secções Indicações de utilização, Contraindicações, Advertências, Precauções e Procedimento recomendado nestas Instruções de Utilização. A não observação pode resultar em complicações, incluindo lesão grave ou morte do paciente.

Se um utilizador ou doente tomar conhecimento de que um incidente sério ocorreu relativamente ao fio guia, comunique a situação ao fabricante e à autoridade competente.

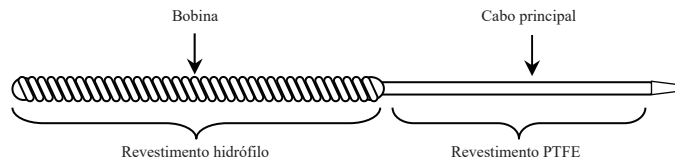
Estas Instruções de Utilização aplicam-se ao ASAHI Gaia Next. Para informações (comprimento do fio guia, comprimento da secção radiopaca, etc.), consulte a etiqueta do produto.

Descrição

Este fio guia é um fio guia controlável com uma ponta moldável e está disponível em variantes pré-moldadas. O diâmetro externo do fio guia é de 0,36 mm (0,014 polegadas). O fio guia é compatível com os cateteres de dilatação por balão existentes e outros dispositivos de intervenção utilizados na intervenção coronária percutânea (ICP) comum. A porção distal da ponta do fio guia é radiopaca.

Para lubrificação, a porção distal do dispositivo é revestida com um polímero hidrófilo e a porção proximal do fio guia é revestida com politetrafluoretileno (PTFE).

Na extremidade proximal do dispositivo, que tem menos de 300 cm, há uma ligação para um fio de extensão, que é utilizado para substituir o dispositivo combinado. O fio de extensão ASAHI INTECC pode ser ligado e o comprimento total após a ligação é de 355-400 cm.



Indicações de utilização

Este fio guia tem como finalidade a intervenção coronária percutânea (ICP) geral. Pode ser utilizado para introduzir e posicionar cateteres de dilatação por balão e outros dispositivos de intervenção na vascularização coronária.

Este fio guia não se destina a utilização na neurovasculatura ou na vascularização periférica.

Contraindicações

- Confirmar a compatibilidade do diâmetro do fio guia com outro dispositivo de intervenção antes da utilização efetiva.
- Não utilizar o fio guia em doentes que façam reação alérgica ao meio de contraste ou que tenham disfunção renal.
- O fio guia contém PEG400 no seu revestimento hidrófilo. Não utilizar o fio guia em doentes que

façam reações alérgicas ao polietileno glicol (PEG).

- Não use o fio guia em doentes grávidas ou que possam estar grávidas (o raio X pode afetar o feto).
- Este fio guia deve ser utilizado numa instituição onde seja possível efetuar imediatamente uma cirurgia de emergência. Se não estiver disponível uma cirurgia de emergência, no pior dos

cenários, podem ocorrer eventos potencialmente fatais.

- Este fio guia foi pré-esterilizado com gás de óxido de etileno (GOE) e destina-se apenas a uma utilização única. Não reutilize ou reesterilize. Se reutilizado ou reesterilizado, o desempenho ou a qualidade deste fio guia e respetiva embalagem pode ficar comprometido/a, havendo o risco de ocorrência de complicações, incluindo infeção.

Advertências

- Este fio guia deve ser utilizado exclusivamente por um médico com a devida formação no tratamento por ICP.
- Nunca utilize este fio guia em combinação com cateteres com peças de metal que possam entrar em contacto direto com a superfície deste fio guia (por exemplo, cateteres de aterectomia, dilatadores de metal), agulhas de metal ou introdutores de bainha metálica.
- Durante a utilização do fio guia, verificar e controlar o movimento da sua ponta sob

fluoroscopia. Não utilize em áreas dos vasos que não sejam ou não possam ser visualizadas.

- Não ligue este fio guia a fios de extensão destacáveis disponibilizados por outros fabricantes além da ASAHI INTECC. Não manipule este fio guia enquanto o fio de extensão destacável estiver ligado. De contrário, o arame guia poderá ser danificado ou o fio de extensão destacável poderá ser separado não intencionalmente.
- Não modifique este fio guia sob nenhum pretexto.

Precauções

- Não utilize o fio guia após o prazo de validade indicado na etiqueta. Elimine qualquer fio guia que ultrapasse o prazo de validade.
- Os fios-guia são instrumentos delicados e devem ser manuseados com cuidado.
- Não utilize o fio guia se a embalagem estiver aberta ou danificada. Abra a embalagem diretamente antes da utilização do produto. Utilize uma técnica asséptica no manuseamento e utilização do fio guia.
- Mantenha sempre o fio guia no estado húmido para evitar danos no revestimento hidrófilo.
- Não limpe este fio guia utilizando uma solução orgânica como álcool.
- Tome medidas preventivas contra infeções após a utilização. Descarte este fio guia e a embalagem como resíduos médicos.
- Nunca empurre, force, retire ou rode este fio guia a ponto de sentir resistência. Rodar ou empurrar este fio guia quando sentir resistência pode provocar danos e/ou a separação da ponta deste fio guia ou lesões diretas num vaso. Não seguir estas indicações poderá causar danos a este fio guia. Determine a causa da resistência sob

fluoroscopia e adote quaisquer medidas necessárias.

- Introduza sempre ou retire os fios-guia devagar e com cuidado.
- Ao rodar este fio guia dentro do vaso sanguíneo, não rode continuamente na mesma direção. Ao rodar o fio guia, faça-o alternadamente no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido inverso. Não exceda as duas rotações (720°) na mesma direção.
- Irrigue o fio guia com solução salina heparinizada e esterilizada ou outra solução adequada enquanto o remove e reinsere para evitar a entrada de ar no dispositivo de intervenção. Efetue a troca deste fio guia com cuidado para evitar a entrada de ar e/ou traumatismos. Ao reintroduzir o fio guia, confirme se a ponta do dispositivo de intervenção está desobstruída no lúmen do vaso e não está a incidir contra a parede do vaso. A não observação desta regra pode resultar em trauma. Utilize o marcador radiopaco do dispositivo de intervenção para confirmar a posição.
- A liberdade de movimentos do fio guia dentro do dispositivo de intervenção é uma característica

importante de um sistema de fio guia orientável porque fornece ao utilizador informações tácteis úteis. Teste o sistema para verificar se apresenta resistência antes da utilização. Regule ou substitua a válvula hemostática por uma válvula regulável caso se considere que esta inibe os movimentos do fio guia.

- Não efetue a administração do stent utilizando mais de um fio guia ou operação com fio através de um suporte do stent. De contrário, o stent poderá danificar-se ou o fio guia poderá partir-se ou partir-se.
- Antes de utilizar, confirme que este fio guia tem o tamanho e formato apropriados para o procedimento e se é compatível com o dispositivo a ser utilizado em combinação.
- Consulte as instruções de utilização anexas ao dispositivo médico (por exemplo, cateteres de dilatação por balão ou outros dispositivos de intervenção) a serem utilizados em combinação com este fio guia.
- Quando ligar o fio de extensão destacável a este fio guia, deverá ser firmemente inserido até à

linha divisória entre os segmentos não revestidos com PTFE e os segmentos revestidos com PTFE na extremidade proximal do fio guia. Se alguma anormalidade for encontrada na conexão, deixe de utilizar o fio guia imediatamente.

- Inspeccione cuidadosamente o fio guia para verificar se apresenta dobras, vincos ou outros danos antes da utilização e sempre que possível durante o procedimento. Não utilize o fio guia se este estiver danificado.
- Ao moldar a ponta, tenha cuidado para não danificar a bobina.
- Antes de inserir o fio guia, verifique qual é a extremidade distal e certifique-se de o inserir a partir da extremidade distal.
- Mantenha uma solução salina contínua entre o cateter-guia e o dispositivo de intervenção e entre o dispositivo de intervenção e o fio guia durante o procedimento. A irrigação evita a formação e/ou coagulação do meio de contraste no fio guia e no lúmen do cateter.

Avarias e efeitos adversos

As possíveis avarias e efeitos adversos resultantes da utilização deste fio guia incluem, sem carácter limitativo:

1. Avarias

Incapacidade para atravessar uma lesão	Quebra ou dobra do fio guia	Danos como separação
Dificuldade na remoção	Saída do revestimento	

2. Efeitos adversos

Morte	Infeção	Dissecção do vaso
Perfuração do vaso	Complicações de hemorragia	Embolia
Trombo	Enfarte	Isquemia
Arritmia	Vasoespasmo	Oclusão vascular
Redução da pressão arterial	Reação alérgica	Residual

Como utilizar

- Inspeção antes da respetiva utilização
 - Antes da utilização, inspeccione e confirme cuidadosamente se o fio guia e a embalagem não estão danificados.
 - Antes da utilização, confirme se o fio guia é compatível com o dispositivo de intervenção a

utilizar.

2. Preparativos

- Selecione o fio guia mais adequado para a área afetada e remova o tubo de suporte que contém o fio guia da embalagem esterilizada.

- Encha o tubo de suporte com solução salina heparinizada e esterilizada utilizando, uma seringa para embeber o dispositivo completo. Tenha em atenção que a solução salina heparinizada e esterilizada pode derramar do tubo de suporte durante esta ação.
- Encha o lúmen do dispositivo de intervenção

Fio guia (extremidade proximal)

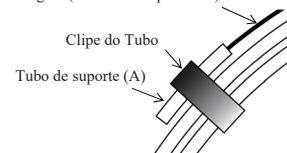


Figura 1

- Quando a extremidade distal do fio guia for superior a 4 cm para além da outra extremidade do tubo de suporte, caso seja necessário, deverá moldar a ponta em conformidade com a prática padrão.
- Agarrar gentilmente o arame guia que saiu da extremidade distal do tubo de suporte, na ponta, o mais próximo possível do tubo de suporte e puxar o arame guia lenta e cuidadosamente.
- Se sentir resistência ao remover o fio guia do tubo de suporte, volte a injetar a solução salina heparinizada e esterilizada no tubo de suporte. Continue a remover o fio guia depois de deixar de sentir resistência. Certifique-se de que injeta solução salina heparinizada e esterilizada suficiente no tubo de suporte, visto que o revestimento hidrófilo pode danificar-se ao remover o fio guia revestido com força excessiva.
- Depois de puxar o fio guia para fora do tubo de suporte, inspeccione-o para garantir que não está danificado.

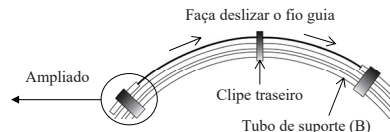
3. Procedimentos de inserção

■ Sistema ao longo do fio

- Insira a extremidade distal do fio guia cuidadosamente no lúmen do fio guia do dispositivo de intervenção.
- Faça avançar este fio guia cuidadosamente até a ponta ficar proximal à ponta do dispositivo de intervenção.
- Encaixe o cateter-guia e insira o sistema de

com a solução salina heparinizada e esterilizada antes de inserir o fio guia.

- Liberte o fio guia do clipe traseiro e faça-o deslizar lentamente, empurre a extremidade distal do fio guia através do tubo de suporte (B). (Figura 1)



- dispositivo de intervenção (com o fio guia) no conector em Y.
- Faça avançar o sistema de dispositivo de intervenção pelo cateter-guia até a ponta do sistema de fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
- Aperte a válvula hemostática do conector em Y para criar um isolamento em torno do dispositivo de intervenção. Certifique-se de que o fio guia ainda apresenta liberdade de movimentos.
- Certifique-se de que o fio guia se move sem obstruções.
- Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- Faça avançar este fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.
- Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- Faça avançar o dispositivo de intervenção até atingir a lesão, evitando que o fio guia se mova. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

■ Sistema de troca rápida

- Encaixe o cateter-guia.
- Insira o introdutor do fio guia no conector em Y do cateter-guia.
- Insira cuidadosamente a ponta do fio guia no introdutor.

- d) Faça avançar o fio guia pelo cateter-guia sob fluoroscopia até a ponta do fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
- e) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- f) Faça avançar o fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.
- g) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- h) Remova o dispositivo de rotação do fio guia e o introdutor do fio guia.
- i) Localize o dispositivo de intervenção no fio guia evitando que este se mova e faça-o

avançar até atingir a lesão. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

4. Procedimentos para trocar o fio guia

- Sistema ao longo do fio
 - a) Remova este fio guia lentamente enquanto monitoriza o movimento deste fio guia sob fluoroscopia.
 - b) Insira o fio guia seguinte de acordo com as instruções da secção “Procedimento recomendado”.

Método de armazenamento

Não mantenha o fio guia e a embalagem dobrados e/ou sob carga excessiva. Este fio guia e embalagem devem ser mantidos afastados de água. Guarde num local fresco, escuro e seco.

Data de validade

A data de validade é indicada na etiqueta da embalagem do fio guia.

Conteúdo

5 peças/caixa

Exoneração de responsabilidade

De modo algum deverá a “ASAHI INTECC CO., LTD. e a suas empresas afiliadas” (doravante designada como a “Empresa”) ser responsabilizada por acidentes, lesões pessoais, efeitos adversos devido ao uso inapropriado do(s) produto(s) ou outro uso inconsistente com estas instruções. Em circunstância alguma será a Empresa responsável por quaisquer danos (i) decorrentes do armazenamento do(s) produto(s) após a expedição por parte da Empresa ou (ii) devido à seleção dos doentes, técnicas cirúrgicas ou quaisquer outras intervenções médicas efetuadas pela instituição médica que utiliza o(s) produto(s).

“ASAHI Gaia Next” é uma marca comercial ou marca registada da ASAHI INTECC CO.,LTD. no Japão e noutros países.

ASAHI Gaia Next Alambre guía para ACP

Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el alambre guía y tenga en cuenta las secciones **Indicaciones para el uso**, **Contraindicaciones**, **Advertencias**, **Precauciones** y **Procedimientos recomendados de las Instrucciones de uso**. Si no se hace de este modo, pueden surgir complicaciones, incluyendo lesiones graves del paciente o su muerte.

Si un usuario o paciente se entera de que ha ocurrido un incidente grave en relación con el alambre guía, informe el hecho al fabricante y la autoridad competente.

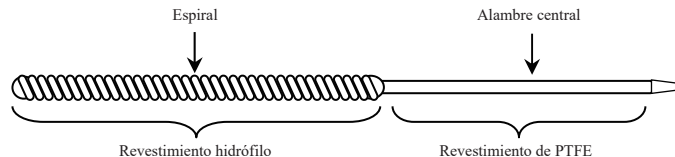
Estas instrucciones de uso son para ASAHI Gaia Next. Para ver los detalles (longitud del alambre guía, longitud de la sección radiopaca, etc.), consulte la etiqueta del producto.

Descripciones

Este alambre guía es direccionable, cuenta con una punta conformable y está disponible en variantes preconformadas. El diámetro externo del alambre guía es de 0,36 mm (0,014 pulgadas). Este alambre guía es compatible con los catéteres de dilatación con balón existentes y otros dispositivos quirúrgicos utilizados en la angioplastia coronaria percutánea (ACP) común. La parte distal de la punta del alambre guía es radiopaca.

Para aumentar la lubricidad, la parte distal del dispositivo está revestida de un polímero hidrófilo y la parte proximal del alambre guía está revestida de politetrafluoroetileno (PTFE).

En el extremo proximal del dispositivo, que es inferior a 300 cm, hay una conexión para un alambre de extensión, que se utiliza para sustituir el dispositivo combinado; se puede conectar el alambre de extensión de ASAHI INTECC, y la longitud total después de la conexión es de 355-400 cm.



Indicaciones para el uso

Este alambre guía fue concebido para la angioplastia coronaria percutánea (ACP) general. Se puede usar para introducir y colocar catéteres de dilatación con globo y otros dispositivos quirúrgicos dentro de la cardiocirculación.

Este alambre guía no fue concebido para usar en la neurovasculatura y la vasculatura periférica.

Contraindicaciones

- Confirme la compatibilidad del diámetro del alambre guía con el de otro dispositivo quirúrgico antes de su uso real.
- No utilice el alambre guía en pacientes que presenten reacciones alérgicas a los medios de contraste o que tengan disfunción renal alterada.

- Este alambre guía contiene PEG400 en su revestimiento hidrófilo. No utilice el alambre guía en pacientes que presenten reacciones alérgicas a polietilenglicol (PEG).
- No utilice el alambre guía en pacientes embarazadas o que puedan estarlo (los rayos X podrían afectar el feto).
- Este alambre guía se debe utilizar en lugares donde se pueda realizar de modo inmediato una operación quirúrgica de emergencia. Si no se puede ejecutar una operación quirúrgica de

emergencia, en el peor de los casos, pueden producirse situaciones en las que se ponga en peligro la vida.

- Este alambre guía está esterilizado previamente con gas de óxido de etileno (EOG), habiéndose concebido solo para un único uso. No lo vuelva a utilizar ni a esterilizar. Si lo vuelve a utilizar o a esterilizar, pueden haberse visto afectadas las prestaciones o la calidad de este alambre guía, existiendo riesgo de complicaciones, incluyendo infecciones.

Advertencias

- Este alambre guía solo debe utilizarlo un médico con la adecuada formación en el tratamiento de ACP.
- Nunca utilice este alambre guía en combinación con catéteres con partes metálicas que puedan entrar en contacto directo con la superficie del alambre guía (p. ej., catéteres de aterectomía, dilataadores metálicos), agujas metálicas o insertadores de fundas metálicas.
- Durante el uso del alambre guía, verifique y controle el movimiento de esta punta bajo

fluoroscopia. No lo utilice en zonas de vasos que no se visualicen o no se puedan visualizar.

- No conecte este alambre guía con alambres de extensión desmontables producidos por fabricantes distintos a ASAHI INTECC. No manipule este alambre guía mientras se encuentra conectado el alambre de extensión desmontable. En caso contrario, el alambre guía puede resultar dañado o se puede desacoplar accidentalmente el alambre de extensión desmontable.
- No modifique este alambre guía bajo ninguna circunstancia.

Precauciones

- No utilice el alambre guía después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. Deseche cualquier alambre guía después de su fecha de caducidad.
- Los alambres guía son instrumentos delicados y se deben manejar con cuidado.
- Si el envase está abierto o deteriorado, no utilice el alambre guía. No abra el envase hasta inmediatamente antes de proceder a su uso. Utilice técnicas asépticas en la manipulación y el empleo del alambre guía.
- Siempre mantenga el alambre guía en estado húmedo para evitar daños en su revestimiento hidrófilo.
- No limpie este alambre guía con una solución orgánica, como alcohol.
- Tras usar el alambre, tome medidas preventivas para evitar infecciones. Deseche este alambre guía y el envase como residuos médicos.
- No empuje, taladre, retire, ni presione nunca este alambre guía cuando note resistencia. Torsionar o empujar este alambre guía contra una resistencia puede dañar o separar la punta de este alambre guía o dañar directamente un vaso. Si no

se hace de este modo, podría dañarse el alambre guía. Determine la causa de la resistencia bajo fluoroscopia y tome las medidas necesarias.

- Avance y retire el alambre guía siempre despacio y con cuidado.
- Al girar este alambre guía en el interior del vaso sanguíneo, no proceda a su rotación continua en el mismo sentido. Al girar el alambre guía, rótele en sentido horario y antihorario de forma alternativa. No gire más de dos vueltas (720°) en la misma dirección.
- Rocíe el alambre guía con una solución salina esterilizada y heparinizada o de otro tipo adecuado al proceder a la retirada y a la reintroducción para evitar que entre aire en el dispositivo quirúrgico. Tenga cuidado al cambiar este alambre guía para evitar que entre aire o que se produzcan traumatismos. Al reintroducir el alambre guía, confirme que la punta del dispositivo quirúrgico se encuentra libre en el vaso y no se apoya contra la pared del mismo. Si no se hace de este modo, se puede provocar un traumatismo. Utilice el marcador radiopaco del dispositivo quirúrgico para confirmar la posición.

- El movimiento libre del alambre guía dentro del dispositivo quirúrgico es una característica importante de un sistema de alambre guía direccionable, ya que da al usuario una información táctil valiosa. Pruebe la resistencia del sistema antes de utilizarlo. Ajuste o cambie la válvula hemostática con una válvula regulable si observa que inhibe el movimiento del alambre guía.
- No proceda a la colocación de un stent empleando más de un alambre guía ni a la operación del alambre a través del tirante de un stent. En caso contrario, el stent puede resultar dañado o el alambre guía se podría romper o quedar inservible.
- Antes de utilizarlo, confirme que este alambre guía es adecuado en tamaño y forma para el procedimiento y compatible con el dispositivo que se utilizará en combinación.
- Consulte las instrucciones de uso adjuntas al dispositivo médico (p. ej., catéteres de dilatación con balón u otros dispositivos de intervención) que se usarán en combinación con este alambre guía.
- Al conectar el alambre de extensión desmontable con este alambre guía, se debe insertar firmemente en la línea límite que se encuentra entre los revestimientos de PTFE y distinto a PTFE en el extremo proximal del alambre guía. Si se encuentra alguna anomalía en la conexión, deje de usar el alambre guía inmediatamente.
- Revise el alambre guía atentamente por si tiene dobleces, torceduras, u otro daño, antes de utilizarlo y siempre que sea posible durante el procedimiento. No utilice el alambre guía si está dañado.
- Al conformar la punta, tenga cuidado de no dañar la espiral.
- Antes de insertar el alambre guía, verifique cuál es el extremo distal y asegúrese de insertarlo desde el extremo distal.
- Mantenga un rociado continuo de solución salina entre el catéter guía y el dispositivo quirúrgico y entre el dispositivo quirúrgico y el alambre guía durante el procedimiento. El rociado evita la formación del medio de contraste o la coagulación en el alambre guía y en la luz del catéter.

Fallos de funcionamiento y efectos adversos

Se pueden producir posibles fallos de funcionamiento y efectos adversos en el uso de este alambre guía, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Fallos de funcionamiento

Fallo al atravesar una lesión	Rotura o curvatura del alambre guía	Daños como la separación
Dificultad de extracción	Desprendimiento del revestimiento	

2. Efectos adversos

Muerte	Infección	Diseción del vaso
Perforación del vaso	Complicaciones de hemorragia	Embolia
Trombo	Infarto	Isquemia
Arritmia	Vasoespasmo	Oclusión vascular
Reducción de la presión arterial	Reacción alérgica	Residuo

Procedimientos recomendados

- Inspección antes de utilizarlo
 - Antes de utilizarlo, revise atentamente y confirme que ningún alambre guía o paquete está dañado.
 - Antes de utilizarlo, confirme que el alambre guía sea compatible con los dispositivos

quirúrgicos que se utilizarán.

2. Preparación

- Seleccione el alambre guía más adecuado para el área afectada y retire el tubo sujetador que contiene el alambre guía del paquete estéril.
- Rellene el tubo sujetador con una solución salina esterilizada y heparinizada empleando una jeringuilla para empapar el dispositivo en

Alambre guía (extremo proximal)

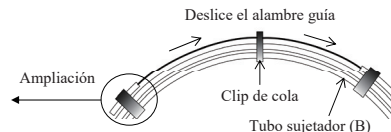
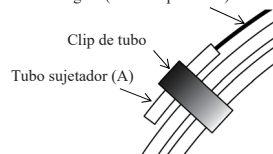


Figura 1

- Si es necesario, cuando el extremo distal del alambre guía se prolongue más de 4 cm más allá del otro extremo del tubo sujetador, conforme la punta de acuerdo con la práctica estándar.
- Sujete suavemente el alambre guía que sale del extremo distal del tubo sujetador, por el punto más cercano posible al tubo sujetador, y extraiga el alambre guía lenta y cuidadosamente.
- Si se siente resistencia al extraer el alambre guía del tubo sujetador, inyecte de nuevo una solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador. Continúe extrayendo el alambre guía cuando haya dejado de percibirse la resistencia. Asegúrese de inyectar suficiente solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador, debido a que el revestimiento hidrófilo puede dañarse al extraer con fuerza el alambre guía.
- Después de sacar el alambre guía del tubo sujetador, compruebe que no esté dañado.

3. Procedimientos de inserción

- Sistema del alambre
 - Inserte el extremo distal del alambre guía con cuidado en la luz del alambre guía del dispositivo quirúrgico.
 - Avance este alambre guía con cuidado hasta que su punta esté inmediatamente próxima a la punta del dispositivo quirúrgico.

- su conjunto. Tenga en cuenta que la solución salina esterilizada y heparinizada se puede derramar del tubo sujetador en este momento.
- Rellene la luz del dispositivo quirúrgico con solución salina esterilizada y heparinizada antes de insertar de nuevo la guía.
- Suelte la guía del clip de cola y deslicela lentamente, presione el extremo distal de la guía a través del tubo sujetador(B). (Figura 1)

- Meta el catéter guía e inserte el sistema del dispositivo quirúrgico (con el alambre guía) en el conector en Y.
- Avance el sistema del dispositivo quirúrgico a lo largo del catéter guía hasta que la punta del sistema del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.
- Apriete la válvula hemostática del conector en Y para cerrar herméticamente alrededor del dispositivo quirúrgico. Compruebe que aún se pueda mover el alambre guía.
- Asegúrese de que el alambre guía se mueva sin problemas.
- Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
- Avance este alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.
- Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
- Avance el dispositivo quirúrgico hasta que alcance la lesión mientras que evita que se mueva el alambre guía. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

■ Sistema de intercambio rápido

- Meta el catéter guía.

- b) Inserte el introductor del alambre guía en el conector en Y del catéter guía.
- c) Inserte con cuidado la punta del alambre guía en el introductor.
- d) Avance el alambre guía a lo largo del catéter guía bajo fluoroscopia hasta que la punta del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.
- e) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.
- f) Avance el alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.
- g) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.
- h) Extraiga el dispositivo de torsión del alambre guía y el introductor del alambre guía.
- i) Siga al dispositivo quirúrgico por el alambre guía mientras evita que este se mueva, y avance hasta que alcance la lesión. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

4. Procedimientos para cambiar el alambre guía

■ Sistema del alambre

- a) Extraiga este alambre guía despacio mientras controla su movimiento bajo fluoroscopia.
- b) Inserte el siguiente alambre guía siguiendo las instrucciones de la sección Procedimientos recomendados.

Método de conservación

No conserve la guía y el envase doblados ni soportando cargas pesadas. Esta guía y su envase se deben mantener alejados del agua. Proceda a su almacenamiento en un lugar fresco, oscuro y seco.

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad se indica en la etiqueta del envase del alambre guía.

Contenido

5 unidades/caja

Exención de responsabilidad

“ASAHI INTECC CO., LTD. y sus empresas afiliadas” (en adelante, “la Compañía”) no se hace responsable bajo ningún concepto por accidentes, heridas personales, efectos adversos debido al mal uso de cualquier índole del producto o de los productos, o por cualquier uso que no observe estas instrucciones. En ningún caso la Compañía será responsable por daños (i) procedentes de la conservación de los productos una vez enviados por la Compañía o (ii) debidos a la selección de pacientes, técnicas quirúrgicas o cualquier otra actividad médica de la institución médica que utilice los productos.

“ASAHI Gaia Next” es una marca comercial o marca registrada de ASAHI INTECC CO.,LTD. en Japón y otros países.

ASAHI Gaia Next PCI-ledare

Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant före användning av denna ledare och följ bruksanvisningens avsnitt för Indikationer, Kontraindikationer, Varningar, Försiktighetsåtgärder och Användning. Om instruktionerna inte följs kan det leda till komplikationer inklusive allvarliga personsador för patienten eller till och med dödsfall.

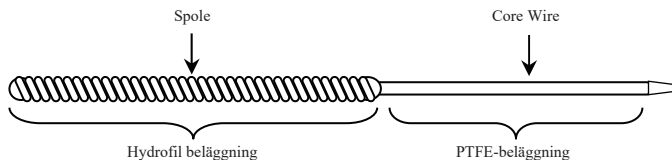
Om en användare eller patient får kännedom om en allvarlig incident som inträffat i samband med ledaren så ska detta rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

Denna bruksanvisning gäller för ASAHI Gaia Next. Detaljerad information (ledarens längd, längd på röntgentät del, osv.), anges på produktens etikett.

Beskrivningar

Denna ledare är styrbar med formbar spets och finns i förformade varianter. Ledarens ytterdiameter är 0,36 mm (0,014 tum). Denna ledare är kompatibel med befintliga ballongdilationskatetrar och andra interventionsanordningar som används vid vanlig perkutan kranskärlsintervention (PCI). Den distala delen av ledarens spets är röntgentät.

För smörjbarhet är den distala delen av anordningen belagd med en hydrofil polymer och den proximala delen av ledaren med polytetrafluoretylen (PTFE). Vid den proximala änden av enheten (är mindre än 300 cm) finns en anslutning för en förlängningskabel som används för att ersätta den kombinerade enheten. ASAHI INTECC:s förlängningskabel kan anslutas och den totala längden efter anslutning är 355–400 cm.



Indikationer

Denna ledare är avsedd för allmän perkutan kranskärlsintervention (PCI). Den kan användas för att införa och placera ballongdilationskatetrar och andra interventionsanordningar inom kardiovaskulär utrustning. **Denna ledare är inte avsedd för användning i neurovaskulaturen och perifer vaskulaturen.**

Kontraindikationer

- Bekräfta ledarens diameter är kompatibel med annan interventionsanordning före faktisk användning.
- Använd inte ledaren i patienter som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller nedsatt njurfunktion.
- Denna ledare innehåller PEG400 i sin hydrofila beläggning. Använd inte ledaren i patienter som har allergiska reaktioner mot polyetylen glykol (PEG).

- Använd inte ledaren för gravida patienter eller patienter som kan vara gravida (röntgen kan påverka fostret).
- Denna ledare måste användas på en institution där det finns omedelbar tillgång till nödkirurgi. Om det inte finns tillgång till nödkirurgi kan det i värsta fall uppstå livshotande situationer.

Varningar

- Denna ledare får endast användas av en läkare som är fullständig utbildad i PCI-behandling.
- Använd aldrig denna ledare i kombination med katetrar som har delar av metall som kan komma i direkt kontakt med ledarens yta (t.ex. aterektomikatetrar, metalldilatorer), metallnålar eller metallhylsor.
- Vid användning av ledaren ska du kontrollera och övervaka rörelsen av dess spets under

- fluoroskopi. Använd inte i kärlområden som inte är visualiserade eller inte kan visualiseras.
- Anslut inte denna ledare till en avtagbar förlängningsledare tillverkad av en annan producent än ASAHI INTECC. Manipulera inte denna ledare när den löstagbara förlängningsledaren är ansluten. Detta kan annars leda till att ledaren skadas eller att den avtagbara förlängningsledaren lossnar.
- Modifiera inte ledaren av något skäl.

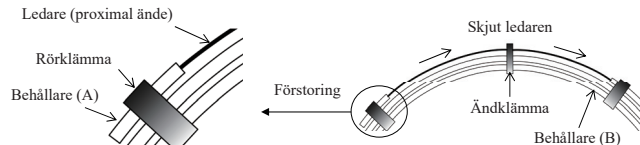
Försiktighetsåtgärder

- Använd inte ledaren efter utgångsdatumet på etiketten. Kassera alla ledare som har passerat utgångsdatumet.
- Ledare är ömtåliga instrument och ska hanteras försiktigt.
- Använd inte ledaren om förpackningen är öppen eller skadad. Öppna inte förpackningen förrän alldeles innan produkten ska användas. Använd aseptisk teknik vid hantering och användning av ledaren.
- Förvara alltid ledaren i vått tillstånd för att förhindra skador på dess hydrofila beläggning.
- Torka inte av ledaren med en organisk lösning, t.ex. alkohol.
- Vidta förebyggande åtgärder mot infektion efter användning. Kasta ledaren och förpackningen som medicinskt avfall.
- Du får aldrig trycka, borra, dra tillbaka eller vrida denna ledare vid motstånd. Om ledaren förs in eller trycks mot motstånd kan det orsaka skador på spetsen och/eller leda till att spetsen lossnar från ledaren eller orsaka direkta skador på ett kärl. Underlåtenhet att göra så kan orsaka skada på ledaren. Fastställ orsaken till motståndet under fluoroskopi och vidta alla nödvändiga korrigerande åtgärder.
- För alltid in och dra tillbaka ledare långsamt och försiktigt.
- När ledaren vrids inuti blodkärlet ska den inte vridas i samma riktning hela tiden. Rotera ledaren medurs och moturs om varnatt när du vriden den. Rotera inte mer än två varv (720°) i samma riktning.
- Spola ledaren med steril hepariniserad koksaltlösning eller annan lämplig lösning när den dras ut eller förs in för att förhindra att det tränger in luft i interventionsinstrumentet. Byten av ledaren ska utföras försiktigt för att förhindra trauma och/eller att det tränger in luft. När ledaren förs in igen är det viktigt att säkerställa att interventionsinstrumentets spets är fri inom kärlets lumen och att den inte ligger mot kärlets vägg. Om du inte gör detta kan det orsaka trauma. Använd interventionsinstrumentets röntgentäta markör för att bekräfta positionen.
- Ledarens fria rörelse inuti interventionsinstrumentet är en viktig funktion i ett styrbart ledarsystem eftersom det ger användaren värdefull känselinformation. Testa systemet för motstånd före användning. Justera eller ersätt hemostasventilen med en justerbar ventil om den förhindrar ledarens rörelse.
- Placera inte stenten med hjälp av mer än en ledare eller ledaranvändning genom stentstödet. Detta kan annars leda till att stenten skadas eller att ledaren bryts av eller går sönder.
- Kontrollera innan användning att ledaren har en lämplig storlek och form för proceduren och är kompatibel med enheten som den ska användas med.

- Se bruksanvisningen som är fäst vid den medicinska utrustningen (t.ex. ballongdilationskatetrar eller andra interventionsanordningar) som ska användas i kombination med denna ledare.
- Vid anslutning av den löstagbara förlängningskabeln till ledaren bör den föras in säkert till gränslinjen mellan icke-PTFE-höljet och PTFE-höljet i den proximala änden av ledaren. Om någon avvikelse upptäcks i anslutningen så ska du omedelbart sluta använda ledaren.
- Inspektera ledaren noggrant för böjningar, veck eller andra skador före användning och när det är

möjligt under proceduren. Använd inte ledaren om den är skadad.

- När du formar spetsen ska du vara försiktig så att du inte skadar spolen.
- Innan du för in ledaren ska du ta reda på vilken ände som är den distala änden och se till att föra in den från den distala änden.
- Upprätthåll en kontinuerlig koksaltlösning mellan styrkatetern och interventionsanordningen samt mellan interventionsanordningen och ledaren under proceduren. Spolning förhindrar bildning av kontrastmedel och/eller koagulering på ledaren och i kateterlumen.



Figur 1

Funktionsfel och biverkningar

Möjliga funktionsfel och biverkningar som kan uppstå vid användning av denna ledare inkluderar, men är inte begränsade till:

1. Funktionsfel

Misslyckande att korsa en lesion/skada	Brott eller böjning av ledaren	Skador såsom separation
Svår att avlägsna	Kommer av beläggningen	

2. Biverkningar

Dödsfall	Infektion	Kärldissektion
Kärlperforering	Blödningskomplikationer	Embolism
Trombos	Infarkt	Ischemi
Arytmi	Vasospasm	Vaskulär tilltäppning
Blodtryckssänkning	Allergisk reaktion	Residual

Användning

1. Inspektion innan användning

- Kontrollera noggrant att ledaren och förpackningen är oskadade före användning.
- Bekräfta att ledaren är kompatibel med interventionsinstrumenten som ska användas före användning.

2. Förberedelse

- Välj den lämpligaste ledaren för det drabbade området och avlägsna behållaren som innehåller ledaren från den sterila förpackningen.
- Fyll behållaren med steril hepariniserad koksaltlösning med hjälp av en spruta för att blöta hela utrustningen. Tänk på att steril

hepariniserad koksaltlösning kan rinna över ur behållaren när du gör detta.

- Fyll lumen på interventionsinstrumentet med steril hepariniserad koksaltlösning innan ledaren förs in.
- Lossa ledaren från ändklämmen och skjut ledaren långsamt framåt. Tryck ledarens distala ände genom behållaren (B). (Figur 1)

- När ledarens distala ände sticker ut mer än 4 cm på den andra sidan av behållaren så formar du spetsen i enlighet med vanlig praxis.
- Greppa försiktigt ledaren som sticker ut ur den distala änden av behållaren i spetsen så nära behållaren som möjligt och dra sakt och försiktigt ut ledaren.
- Om du känner ett motstånd när ledaren tas ur behållaren så injicerar du steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren igen. Försätt att ta bort ledaren när du inte längre känner motståndet. Se till att injicera tillräckligt med steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren eftersom den hydrofila beläggningen kan skadas om den ytbehandlade ledaren dras ut med våld.
- När ledaren har dragits ut ur den rörformiga behållaren ska den inspekteras för att kontrollera att den inte är skadad.

3. Proceduren för insättning

- System med införsel via ledare
 - För in den distala änden av ledaren försiktigt i ledarlumen för interventionsinstrumentet.
 - För fram ledaren försiktigt tills dess spets befinner sig precis proximalt i relation till interventionsinstrumentets spets.
 - Anslut ledarkatetern och för in interventionsinstrumentsystemet (med ledare) i Y-anslutningen.
 - För fram interventionsinstrumentsystemet genom ledarkatetern tills spetsen för ledarsystemet befinner sig precis proximalt i relation till spetsen för ledarkatetern.
 - Stäng Y-anslutningens hemostasventil för att skapa en föregångning runt interventionsinstrumentet. Säkerställ att det fortfarande går att röra ledaren.
 - Kontrollera att det är möjligt att röra ledaren friktionsfritt.

- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- Observera ledarens rörelse i kärlen.
- För in interventionsinstrumentet tills lesionsområdet nås samtidigt som rörelse av ledaren förhindras. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

■ System för snabbt byte

- Anslut ledarkatetern.
- För in ledarens införsel i ledarkateterns Y-anslutning.
- För försiktigt in ledarens spets i införseln.
- För in ledaren genom ledarkatetern under fluoroskopi tills ledarens spets befinner sig precis proximalt i relation till ledarkateterns spets.
- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- Observera ledarens rörelse i kärlen.
- Avlägsna ledarens vridenhet och införsel.
- För interventionsinstrumentet över ledaren samtidigt som rörelse av ledaren förhindras, tills lesionsområdet nås. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

4. Procedurer för byte av ledaren

- System med införsel via ledare

a) Avlägsna ledaren långsamt, samtidigt som ledarens rörelser övervakas via fluoroskopi.

b) För in nästa ledare i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Användning".

Förvaring

Ledaren och förpackningen får inte förvaras böjd och/eller utsättas för stor belastning vid förvaring. Denna ledare och förpackning ska skyddas mot vatten. Förvara den på en sval, mörk och torr plats.

Utgångsdatum

Utgångsdatumet anges på etiketten på ledarens förpackning.

Innehåll

5 stycken/ask

Ansvarsfriskrivning

Under inga omständigheter är "ASAHI INTECC CO., LTD. och dess dotterbolag" (kallas nedan för "Företaget") ansvarig för olyckor, personskador, biverkningar som beror på felaktig användning av produkten/produkterna eller annan användning oförenlig med dessa instruktioner. I inget fall ska Företaget hållas ansvarigt för skador som antingen (i) uppstår från förvaring av produkten/produkterna efter transport från Företaget eller (ii) inträffar på grund av patientval, operationstekniker eller någon annan medicinsk aktivitet av den sjukvårdsinrättning som använder produkten/produkterna.

"ASAHI Gaia Next" är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör ASAHI INTECC CO., LTD. i Japan och andra länder.

ASAHI Gaia Next Vodicí drát pro PCI

Návod k použití

Před použitím výrobku si tyto pokyny důkladně přečtěte a v tomto návodu k použití věnujte pozornost sekci Indikace pro použití, Kontraindikace, Upozornění, Bezpečnostní pokyny a Doporučený postup při použití. V opačném případě může dojít ke komplikacím, včetně závažného poranění pacienta nebo smrti.

Pokud se uživatel nebo pacient dozví o závažné události, ke které došlo v souvislosti s vodicím drátem, oznamte tuto skutečnost výrobci a příslušnému orgánu.

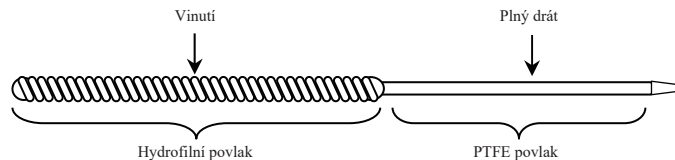
Tento návod k použití se týká vodicích drátů ASAHI Gaia Next. Detailní charakteristiku (délku vodicího drátu, délku radiokonstrastní části atd.) naleznete na štítku na obalu výrobku.

Popis

Tento vodicí drát je říditelný vodicí drát s tvarovatelnou špičkou a je k dispozici v předem tvarovaných variantách. Vnější průměr vodicího drátu je 0,36 mm (0,014 palce). Tento vodicí drát je kompatibilní se stávajícími balónkovými dilatačními katétry a dalšími intervenčními zařízeními používanými při běžné perkutánní koronární intervenci (PCI). Distální část špičky vodicího drátu je radiokonstrastní.

Z důvodu lubrikace je distální část zařízení potažena hydrofilním polymerem a proximální část vodicího drátu je potažena polytetrafluorethanem (PTFE).

Na proximálním konci zařízení, který je kratší než 300 cm, je připojení pro prodlužovací drát, který se používá k nahrazení kombinovaného zařízení. Připojit je možné prodlužovací drát společnosti ASAHI INTECC a celková délka po připojení je 355–400 cm.



Indikace pro použití

Tento vodicí drát je určen k obecné perkutánní koronární intervenci (PCI). Lze jej použít k zavedení a umístění balónkových dilatačních katetrů a dalších intervenčních zařízení do kardiiovaskulárního systému. **Tento vodicí drát není určen pro použití v neurovaskulárním systému ani periferních cévách.**

Kontraindikace

- Před vlastním použitím ověřte kompatibilitu průměru vodicího drátu s jiným intervenčním zařízením.
- Nepoužívejte vodicí drát u pacientů, kteří jsou alergičtí na kontrastní látku, nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin.
- Tento vodicí drát obsahuje ve svém hydrofilním povlaku PEG400. Vodicí drát nepoužívejte u pacientů, kteří jsou alergičtí na Polyethylen glykol (PEG).

- Vodicí drát nepoužívejte u těhotných pacientek ani pacientek, které mohou být těhotné (rentgenové záření může ovlivnit plod).
- Tento vodicí drát je nutné používat pouze ve zdravotnickém zařízení, které disponuje možností hned provést akutní chirurgický zákrok. Pokud není možnost provést akutní chirurgický zákrok, v nejhorším případě může dojít k příchodům ohrožujícím pacienta na životě.

Upozornění

- Tento vodicí drát smí používat pouze lékař, který je plně vyškolen v terapii metodou PCI.
- Tento vodicí drát nikdy nepoužívejte v kombinaci s katétry obsahujícími kovové části, které se mohou přímo dotýkat povrchu tohoto vodicího drátu (např. atereotomické katétry, kovové dilatátory), kovovými jehlami nebo zaváděči s kovovými pouzdry.
- Během používání vodicího drátu kontrolujte a sledujte pohyb jeho špičky pod skioskopickou

- Vodicí drát je předem sterilizován plynným ethylenoxidem (EOG) a je určen na jedno použití. Nepoužívejte jej opakovaně ani neprovádějte opakovanou sterilizaci. V případě opakovaného použití nebo sterilizování vodicího drátu může být snížena jeho funkčnost nebo kvalita a může dojít ke komplikacím, včetně infekce.

- kontrolou. Nepoužívejte v oblastech, které nejsou viditelné nebo je zviditelnit nelze.
- Vodicí drát nepřipojujte k odnímatelným prodlužovacím drátům vyráběným jinými výrobci než společností než ASAHI INTECC. Vodicím drátem nemanipulujte, když je připojen odnímatelný prodlužovací drát. Jinak může dojít k poškození vodicího drátu nebo neúmyslnému uvolnění odnímatelného prodlužovacího drátu.
- V žádném případě vodicí drát neupravujte.

Bezpečnostní pokyny

- Vodicí drát nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku. Po datu použitelnosti je nutné vodicí drát zlikvidovat.
- Vodicí dráty jsou jemné nástroje a je nutné s nimi pracovat opatrně.
- Pokud je balení otevřeno nebo poškozeno, vodicí drát nepoužívejte. Obal otevřete až bezprostředně před použitím. Při manipulaci s vodicím drátem dodržujte aseptické podmínky.
- Vodicí drát udržíte vždy vlhký, aby nedošlo k poškození jeho hydrofilního povlaku.
- Vodicí drát neotírejte organickými roztoky (jako např. alkohol).
- Po použití učiňte bezpečnostní opatření proti přenosu infekce. Vodicí drát a obaly likvidujte jako biologický odpad.
- Nikdy netlačte, nevytahujte ani nekruťte nebo nesnažte vrtat vodicím drátem, který narazil na odpor. Kroucení nebo zatlačování vodicího drátu proti odporu může vést k poškození nebo oddělení špičky vodicího drátu nebo přímému poškození cévy. V opačném případě může dojít k poškození tohoto vodicího drátu. Skioskopem zjistěte důvod odporu a proveďte veškeré potřebné nápravné akce.
- Vodicí drát vždy zavádějte a vytahujte pomalu a opatrně.
- Při rotaci vodicího drátu uvnitř krevní cévy neotáčejte stále ve stejném směru. Při rotaci vodicího drátu jím otáčejte střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček. Neotáčejte o více než dvě otočení (do 720°) ve stejném směru.
- Při vyjímání a opakovaném zavádění vodicí drát propíchněte heparinovaným sterilním fyziologickým roztokem nebo jinou vhodnou tekutinou, aby se zabránilo vniknutí vzduchu do intervenčního zařízení. Při výměně vodicího drátu postupujte opatrně, aby do systému nevnikl vzduch nebo nedošlo k poranění. Při opakovaném zavádění vodicího drátu se ujistěte, že je špička intervenčního zařízení volně umístěná v lumen cévy a nenaléhá na její stěnu. Jinak může dojít k poranění. Po potvrzení polohy intervenčního zařízení použijte radiokonstrastní markery.
- Volný pohyb vodicího drátu uvnitř intervenčního zařízení představuje důležitou funkci říditelného systému vodicího drátu, jelikož podává uživateli důležité taktilní informace. Před použitím systému otestujte, jestli při průchodu necítíte žádný odpor. Pokud zjistíte, že hemostatický ventil zpomaluje pohyb vodicího drátu, upravte jej nebo jej nahraďte nastavitelným ventilem.
- K zavádění stentu nepoužívejte více než jeden vodicí drát ani drát nezavádějte mřížkou stentu.

V opačném případě může dojít k poškození stentu nebo poškození či zlomení vodičho drátu.

- Před použitím se ujistěte, že tento vodič drát má odpovídající velikost a tvar pro daný zákrok a že je kompatibilní se zařízením, v kombinaci s kterým má být použit.
- Přečtěte si návod k použití přiložený ke zdravotnickému prostředku (např. balónkovému dilatačnímu katétru nebo jiným intervenčním prostředkům), který má být použit v kombinaci s tímto vodičím drátem.
- Při připojování k vodičimu drátu je nutné odnímatelný prodlužovací drát bezpečně zasunout k hraniční čáře mezi povrchovou úpravou bez PTFE a s PTFE na proximálním konci vodičho drátu. Pokud zjistíte jakoukoli abnormální připojení, okamžitě přestaňte vodič drát používat.

- Vodič drát před použitím, a kdykoli to bude během zákroku možné, pečlivě kontrolujte, jestli není ohnutý, zalomený nebo poškozený jiným způsobem. Pokud je vodič drát poškozený, nepoužívejte jej.
- Při tvarování špičky dávejte pozor, abyste nepoškodili vinuti.
- Před zavedením vodičho drátu zkontrolujte, který konec je distální, a ujistěte se, že provádíte zavádění z distálního konce.
- Během zákroku provádějte kontinuální proplachování fyziologickým roztokem mezi vodičím katétre a intervenčním zařízením a vodičím drátem. Proplachování zabraňuje hromadění kontrastní látky a/nebo srážení na vodičím drátu a v lumen katétru.

Poruchy funkce a nežádoucí účinky

Poruchy funkce a nežádoucí účinky spojené s používáním tohoto vodičho drátu mohou mimo jiné zahrnovat následující:

1. Poruchy funkce

Nemožnost dostat se přes lézi	Odlovení nebo ohnutí vodičho drátu	Poškození, jako je oddělení
Potíže při vytažování	Odlupování povlaku	

Úmrtí	Infekce	Disekce cévy
Perforace cévy	Komplikace spojené s krvácením	Embolie
Krevní sraženina	Infarkt	Ischémie
Arytmie	Vasospasmus	Okluze cév
Snížení krevního tlaku	Alergická reakce	Residuum

Doporučený postup při použití

1. Prohlídka před použitím

- Před použitím pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou vodič drát a obal poškozeny.
- Před použitím se ujistěte, že je vodič drát kompatibilní s používáním intervenčními zařízeními.

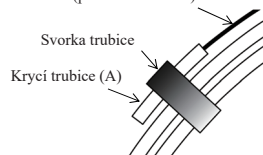
2. Příprava

- Výberte nejvhodnější vodič drát pro postiženou oblast a vyjměte krycí trubici s

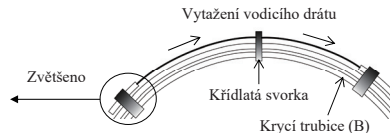
- vodičím drátem ze sterilního obalu.
- Pomocí injekční stříkačky naplňte krycí trubici heparinizovaným, sterilním fyziologickým roztokem tak, aby se namočilo celé zařízení. Vezměte na vědomí, že heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok může z krycí trubice uniknout.
- Před zavedením vodičho drátu, naplňte lumen intervenčního zařízení heparinizovaným, sterilním fyziologickým roztokem.

- Vodič drát uvolněte z křídlaté svorky a pomalu jej suňte, protlačte distální konec

Vodič drát (proximální konec)



vodičho drátu přes krycí trubici (B). (Obrázek 1)



Obrázek 1

- Vyčnívá-li distální konec vodičho drátu o více než 4 cm z opačného konce držáku, je možné v případě potřeby upravit jeho špičku v souladu s běžnou praxí.
- Jemně uchopte vodič drát vyčnívající z distálního konce držáku v nejbližším možném místě u držáku a pomalu a opatrně jej vytáhněte.
- Pokud při vytažování vodičho drátu z krycí trubice zjistíte odpor, znovu do krycí trubice vstříkněte heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok. Jakmile odpor odezní, pokračujte ve vytažování vodičho drátu. Do krycí trubice je nutné vstříknout dostatečný objem heparinizovaného, sterilního fyziologického roztoku, aby nedošlo k poškození hydrofilního povlaku při vytažování vodičho drátu za použití síly.
- Po vytažení vodičho drátu z krycí trubice jej zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozen.

3. Postupy při zavádění

■ Systém Over-the-wire

- Opatrně vložte distální konec vodičho drátu do lumen pro vodič drát intervenčního zařízení.
- Vodič drát opatrně zavádějte, dokud jeho špička nedosáhne polohy proximálně ke špičce intervenčního zařízení.
- Zařaďte vodič katétr a vložte systém intervenčního zařízení (s vodičím drátem) do Y konektoru.
- Posunujte systém intervenčního zařízení skrz vodič katétr, dokud špička vodičho drátu nedosáhne proximální polohy vůči špičce vodičho katétru.
- Utáhněte hemostatický ventil Y konektoru, aby se vytvořilo těsné spojení kolem

intervenčního zařízení. Ujistěte se, že je stále umožněn pohyb vodičho drátu.

- Kontrolujte, že se vodič drát pohybuje hladce.
- V případě potřeby připojte k vodičimu drátu přiložené rotační zařízení.
- Za skiaskopické kontroly posunujte tento vodič drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodič drát dosáhl zúžené cílové léze.
- Kontrolujte pohyb vodičho drátu v cévách.
- Posunujte intervenční zařízení, dokud nedosáhnete léze, při tom zajistěte, aby se vodič drát nepohyboval. Zajistěte, aby distální špička vodičho drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

■ Systém rychlé výměny

- Zařaďte vodič katétr.
- Vložte zavaděč vodičho drátu do Y konektoru vodičho katétru.
- Do zavaděče opatrně vložte špičku vodičho drátu.
- Za skiaskopické kontroly posunujte vodič drát přes vodič katétr, dokud špička vodičho drátu nedosáhne polohy proximálně od špičky vodičho katétru.
- V případě potřeby připojte k vodičimu drátu přiložené rotační zařízení.
- Za skiaskopické kontroly posunujte vodič drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodič drát dosáhl zúžené cílové léze.
- Kontrolujte pohyb vodičho drátu v cévách.
- Vyjměte rotační zařízení vodičho drátu a zavaděč vodičho drátu.
- Intervenční zařízení posunujte po vodičím

drátě, dokud nedosáhnete léze, při tom zamezte pohybu vodičoho drátu. Zajistěte, aby distální špička vodičoho drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

- Systém Over-the-wire
 - a) Vodičí drát pomalu vyjměte za skiaskopického monitorování pohybu.
 - b) Vložte další vodičí drát v souladu s pokyny uvedenými v části „Doporučený postup při použití“.

4. Postupy při výměně vodičoho drátu

Podmínky uchovávání

Vodičí drát a obal se nesmí při uchovávání ohýbat ani silně zatěžovat. Tento vodičí drát a obal musí být uchovávány mimo dosah vody. Uchovávejte v chladu, temnu a suchu.

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti je uvedeno na štítku na obalu vodičoho drátu.

Obsah

5 kusů / krabička

Odmítnutí odpovědnosti

V žádném případě není „ASAHI INTECC CO., LTD. a přidružené společnosti“ (dále jen „Společnost“) odpovědná za nehody, zranění osob, nežádoucí účinky vzniklé v důsledku jakéhokoli nesprávného použití výrobku (výrobků) nebo za jakékoli jiné použití, které není v souladu s těmito pokyny. V žádném případě nebude Společnost odpovědná za škody (i) vzniklé v důsledku skladování výrobku nebo výrobků po dodání od Společnosti nebo (ii) v důsledku výběru pacientů, operačních technik nebo jakýchkoli jiných lékařských úkonů prováděných zdravotnickým zařízením, které výrobek nebo výrobky používá.

„ASAHI Gaia Next“ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ASAHI INTECC CO.,LTD. v Japonsku a dalších zemích.

ASAHI Gaia Next PCI-ledesonder

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar ledesonden i bruk og overhold indikasjoner for bruk, advarsler, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler ved bruk og anbefalt prosedyre i disse instruksjonene for bruk. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner, inkludert alvorlig skade på pasienten eller død.

Hvis en bruker eller en pasient får kjennskap til en alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til ledesonden, rapporter dette til produsenten og den kompetente myndigheten.

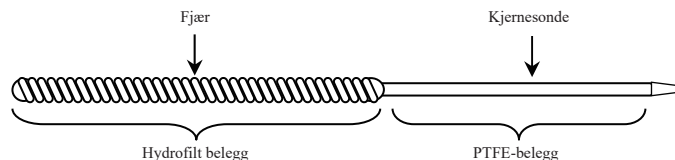
Bruksanvisningen gjelder for ASAHI Gaia Next. For detaljer (lengde av ledesonden, lengden på den røntgentette seksjonen, osv.), se produktetiketten.

Beskrivelser

Denne ledesonden er en styrbar ledesonde med formbar tupp og er tilgjengelig i forhåndsformede varianter. Den ytre diameteren på ledesonden er 0,36 mm (0,014 tommer). Denne ledesonden er kompatibel med eksisterende katetere for ballongdilatasjon og andre enheter for intervensjon som brukes ved vanlig perkutan koronar intervensjon (PCI). Den distale delen av tuppen på ledesonden er røntgentett.

For smøreevne er den distale delen av enheten belagt med en hydrofil polymer og den proksimale delen av ledesonden er belagt med polytetrafluoretylen (PTFE).

I den proksimale enden av enheten, som er mindre enn 300 cm, er det en tilkobling for en forlengelsesledning, som brukes til å erstatte den kombinerte enheten; ASAHI INTECC sin skjøteledning kan kobles til, og total lengde etter tilkobling er 355–400 cm.



Indikasjoner for bruk

Denne ledesonden er beregnet for generell perkutan koronar intervensjon (PCI). Den kan brukes til å introdusere og plassere katetere for ballongdilatasjon og andre enheter for intervensjon innenfor det kardiiovaskulære systemet.

Denne ledesonden er ikke beregnet for bruk i det nevrovaskulære eller det kardiiovaskulære systemet.

Kontraindikasjoner

- Bekreft kompatibiliteten til diameteren på ledesonden med andre enheter for intervensjon for faktisk bruk.
- Ikke bruk ledesonden til pasienter som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler, eller som har nedsatt nyrefunksjon.
- Ikke bruk ledesonden inneholder PEG400 i sitt hydrofile belegg. Ikke bruk ledesonden hos

pasienter som har allergiske reaksjoner på polyetylen glykol (PEG).

- Ikke bruk ledesonden til gravide pasienter eller pasienter som kan være gravide (røntgen kan påvirke fosteret).
- Denne ledesonden skal brukes i institusjoner der akuttkirurgi ikke er tilgjengelig, kan i verste fall livstruende situasjoner oppstå.

Advarsler

- Denne ledesonden må kun brukes av en lege som har full opplæring i PCI-prosedyrer.
- Bruk aldri denne ledesonden i kombinasjon med katetere som har metalldele som kan komme i direkte kontakt med overflaten av denne ledesonden (f.eks. aterektomikatetere, metalldilatorer), metallnåler eller metallhysterinleggere.
- Når ledesonden brukes, kontroller og overvåk bevegelsen til tuppen under fluoroskopi. Enheten

- må ikke brukes i blodåren som ikke kan sees eller visualiseres.
- Ledesonden skal ikke kobles til avtakbare forlengelsessonder produsert av andre enn ASAHI INTECC. Ledesonden må ikke manipuleres mens den avtakbare forlengelsen er tilkoblet. Hvis ikke kan ledesonden bli skadet eller den avtakbare forlengelsessonden kan løsnes uten at det er meningen.
- Ikke endre denne ledesonden av noen årsaker.

Forholdsregler ved bruk

- Bruk ikke ledesonden etter holdbarhetsdatoen som er angitt på etiketten. Kast ledesonder som overskrider holdbarhetsdatoen.
- Ledesonder er ømfintlige instrumenter og bør behandles forsiktig.
- Ikke bruk ledesonden dersom emballasjen er åpnet eller skadet. Ikke åpne emballasjen før like før bruk. Bruk aseptisk teknikk ved håndtering og bruk av ledesonden.
- Hold alltid ledesonden i våt tilstand for å unngå skade på dets hydrofile belegg.
- Ledesonden må ikke tørkes med en organisk løsning som alkohol.
- Iverksett preventive tiltak mot infeksjon etter bruk. Kast ledesonden og emballasjen som medisinsk avfall.
- Ledesonder som møter motstand må aldri skyves, skrues, trekkes tilbake eller ettertrekkes. Hvis ledesonden skyves eller ettertrekkes mot motstand, kan dette forårsake skade og/eller separasjon av tuppen fra ledesonden eller direkte skader på blodårene. Unnlattelse av å gjøre det kan føre til skade på denne ledesonden. Fastslå årsaken til motstanden under gjennomlysning, og iverksett nødvendige tiltak.
- For eller trekk alltid ledesondene sakte og forsiktig frem.
- Ved ettertrekking av denne ledesonden inne i blodåren, skal den ikke ettertrekkes kontinuerlig i samme retning. Når ledesonden ettertrekkes, skal den roteres vekselvis med klokken og mot klokken. Ikke overstig to rotasjoner (720°) i samme retning.
- Skyll ledesonden med heparinisert og sterilisert saltvann eller annet egnet løsning mens ledesonden fjernes og settes inn igjen for å hindre at det kommer luft inn i intervensjonsenheten. Utfør utveksling av denne ledesonden nøye for å hindre at det kommer luft inn og/eller traumer. Når ledesonden føres inn på nytt, må du bekrefte at tuppen på intervensjonsenheten er fri innenfor lumen til blodåren og ikke ligger mot åreveggen. Uten slik observasjon kan det oppstå skade. Bruk den røntgentette markøren på intervensjonsenheten til å bekrefte plasseringen.
- Fri bevegelse av ledesonden innen intervensjonsenheten er en viktig funksjon i en styrbar ledesonde fordi det gir brukeren verdifull informasjon. Systemet må testes for motstand før bruk. Juster eller bytt hemostaseventilen med en justerbar ventil dersom det hemmer bevegelsen til ledesonden.
- Ikke utfør stentplassering ved bruk av mer enn én ledesonde eller bruk av vaier gjennom

stentveggen. Hvis ikke kan stenten bli skadet eller ledesonden kan brette.

- Før bruk, kontroller at denne ledesonden er passende i størrelse og form for prosedyren og er kompatibel med enheten som skal brukes i kombinasjon.
- Se instruksjonene som er festet til det medisinske utstyret (f.eks. ballongdilatasjonskategorier eller annet intervensjonsutstyr) som skal brukes i kombinasjon med denne ledesonden.
- Når den avtakbare forlengelsessonden kobles sammen med denne ledesonden, bør ledesonden være satt godt inn i grenselinjen mellom ikke-PFTE-belegg og PRFE-belegg i den proximale enden av ledesonden. Slutt å bruke ledesonden umiddelbart hvis det blir funnet noe unormalt i tilkoblingen.

- Sjekk ledesonden nøye for bend, knekk eller andre skader før bruk og når det er mulig under prosedyren. Ikke bruk ledesonden hvis den er skadet.
- Når du former tuppen, vær forsiktig så du ikke skader spolen.
- Før du setter inn ledesonden, sjekk hvilken ende som er den distale enden og sørg for å sette den inn fra den distale enden.
- Oppretthold en kontinuerlig saltvannsspyling mellom ledekateret og intervensjonsenheten, og mellom intervensjonsenheten og ledesonden under prosedyren. Skylling forhindrer dannelse av kontrastmidler og/eller koagulering på ledesonden og i kateterlumen.

Feilfunksjoner og ugunstige effekter

Mulige feilfunksjoner og ugunstige effekter ved bruk av denne ledesonden inkluderer, men er ikke begrenset til:

1. Feilfunksjoner

Unnlatelse av å krysse en lesjon	Brudd eller bøyning av ledesonden	Skader som separasjon
Vanskeligheter med å fjerne	Belegget går av	

2. Ugunstige effekter

Dødsfall	Infeksjon	Disseksjon
Karperforering	Blødningskomplikasjoner	Emboli
Trombe	Infarkt	Ischemia
Arytmi	Vasospasm	Vaskulær okklusjon
Blodtrykksreduksjon	Allergisk reaksjon	Rester

Anbefalt prosedyre

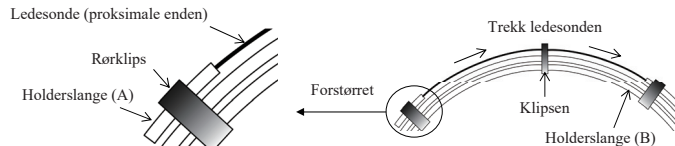
1. Inspeksjon før bruk

- Før bruk, sjekk nøye og bekreft at alle ledesonder og pakker er uskadet.
- Før bruk, bekreft at ledesonden er kompatibel med intervensjonsenheten som skal brukes.

2. Forberedelse

- Velg den mest passende ledesonden for det berørte området; fjern holderslangen som inneholder ledesonden fra den sterile pakningen.
- Fyll holderslangen med heparinisert og

- sterilisert saltvann ved bruk av en sprøyte, for å væte hele enheten. Merk deg at heparinisert og sterilisert saltvann kan søle ut av slangen på dette tidspunktet.
- Fyll lumenen på intervensjonsenheten med heparinisert og sterilisert saltvann for du fører inn ledesonden.
- Løsne ledesonden fra klipsen og trekk ledesonden sakte mens du skyver den distale enden av ledesonden gjennom holderslangen (B). (Figur 1)



Figur 1

- Når ledesondens distale ende stikker mer enn 4 cm ut av den andre enden av holderslangen former du om nødvendig tuppen i samsvar med standard praksis.
- Ta forsiktig tak i ledesonden som kom ut fra den distale enden av holderslangen på det punktet som er så nær holderslangen som mulig, og dra ledesonden ut sakte og forsiktig.
- Hvis du merker motstand når ledesonden fjernes fra holderslangen, skal du sprøyte inn heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen på nytt. Fortsett å fjerne ledesonden når du ikke lenger kjenner motstand. Pass på at du sprøyter inn tilstrekkelig heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen, da det hydrofile belegget kan bli skadet hvis du fjerner den belagte ledesonden med tvang.
- Når ledesonden trekkes ut av holderslangen, sjekk for skader.

3. Prosedyrer for innsetting

■ Over-the-wire-systemet

- Sett den distale enden av ledesonden forsiktig inn i lumen til intervensjonsenheten.
- Flytt ledesonden forsiktig frem inntil tuppen er proksimalt til tuppen av intervensjonsenheten.
- Aktiver ledekateret og sett intervensjonsenhetsystemet (med ledesonde) inn i Y-koblingen.
- Før intervensjonsenhetsystemet fremover gjennom det ledekateret til tuppen av ledesondensystemet er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
- Stram hemostaseventilen på Y-koblingen for å lage en forsegling rundt intervensjonsenheten. Sørg for at ledesonden fortsatt kan beveges.

- Sjekk at ledesonden beveger seg jevnt.
- Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
- Før ledesonden fremover til du har passert lesjonen. Bruk fluoroskopi til å kontrollere fremdriften. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mällesjonen.
- Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
- Før intervensjonsenheten fremover inntil lesjonen er nådd mens du hindrer ledesonden i å bevege seg. Sørg for at den distale tuppen av ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjoner av intervensjonsenheten.

■ System for raskt bytte

- Aktiver ledekateret.
- Sett innføringssettet på ledesonden inn i Y-koblingen på ledekateret.
- Sett tuppen forsiktig inn i innføringssettet.
- Før ledesonden fremover gjennom det ledekateret under fluoroskopi inntil tuppen til ledesonden er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
- Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
- Flytt ledesonden frem under fluoroskopi og passer gjennom lesjonen. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mällesjonen.
- Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
- Fjern ledesondens vridningsenhet og innføringssettet til ledesonden.
- Spor intervensjonsenheten over ledesonden mens du hindrer ledesonden i å bevege seg, og før den fremover inntil lesjonen er nådd. Sørg for at den distale tuppen til ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjon av

- intervensjonsenheten.

4. Prosedyrer for å bytte ut ledesonden
 - Over-the-wire-systemet
 - a) Fjern ledesonden sakte mens ledesondens

bevegelse overvåkes under fluoroskopi.
b) Sett inn den neste ledesonden i samsvar med retningslinjene i denne "Anbefalt prosedyre"-delen.

Oppbevaring

Ikke oppbevar ledesonden og emballasjen i bøyd stilling eller med svært tung belastning. Denne ledesonden og emballasjen skal holdes borte fra vann. Oppbevares mørkt, tørt og kjølig.

Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdatoen er angitt på etiketten på ledesondens emballasje.

Innhold

5 stk/eske

Ansvarsfraskrivelse

"ASAHI INTECC CO., LTD. og dets tilsluttede selskaper" (heretter kalt "selskapet") skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for ulykker, personskader, kontraindikasjoner på grunn av uriktig bruk av produktet eller produktene eller annen bruk som ikke er i overensstemmelse med disse instruksjonene. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader (i) som oppstår på grunn av hvordan produktet/-ene oppbevares etter forsendelse fra Selskapet, eller (ii) på grunn av pasientutvalg, kirurgiske teknikker eller noen andre medisinske aktiviteter ved helseinstitusjonen som bruker produktet/-ene.

"ASAHI Gaia Next" er et varemerke eller et registrert varemerke for ASAHI INTECC CO.,LTD. i Japan og andre land.

ASAHI Gaia Next Vodiaci drôt PCI

Návod na použitie

Pred použitím vodiaceho drôtu si **pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte pokyny uvedené v častiach Indikácie na použitie, Kontraindikácie, Upozornenia, Bezpečnostné opatrenia a Spôsob použitia**. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku komplikáciám, vrátane vážneho zranenia alebo smrti pacienta.

Ak sa používateľ alebo pacient dozvie o závažnom incidente, ku ktorému došlo v súvislosti s vodiacim drôtom, musí túto skutočnosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu.

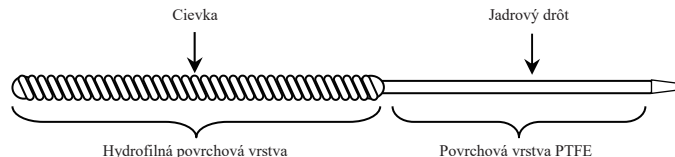
Tento návod na použitie sa vzťahuje na vodiace drôty ASAHI Gaia Next. Podrobnosti (dĺžka vodiaceho drôtu, dĺžka kontrastnej časti a pod.) nájdete na etikete výrobku.

Popis

Tento vodiaci drôt je ovládateľný vodiaci drôt s tvarovateľnou špičkou a je dostupný v predtvarovaných variantoch. Vonkajší priemer vodiaceho drôtu je 0,36 mm (0,014 palca). Tento vodiaci drôt je kompatibilný s existujúcimi balónikovými dilatačnými katétami a inými intervenčnými pomôckami používanými pri bežnej perkutánnej koronárnej intervencii (PCI). Distálna časť špičky vodiaceho drôtu je kontrastná.

Kvôli kľazovosti je distálna časť pomôcky potiahnutá hydrofilným polymérom a proximálna časť vodiaceho drôtu je potiahnutá polytetrafluoretyénom (PTFE).

Na proximálnom konci pomôcky, ktorý je kratší ako 300 cm, sa nachádza prípojka pre predlžovací drôt, ktorý sa používa na nahradenie kombinovanej pomôcky. Je možné pripojiť predlžovací drôt ASAHI INTECC a celková dĺžka po pripojení je 355 – 400 cm.



Indikácie na použitie

Tento vodiaci drôt je určený na všeobecnú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI). Môže sa používať na zavádzanie a umiestňovanie balónikových dilatačných katétov a iných intervenčných pomôcok v kardiiovaskulárnom systéme.

Tento vodiaci drôt nie je určený na použitie v neurovaskulatúre a periférnej vaskulatúre.

Kontraindikácie

- Pred samotným použitím overte kompatibilitu priemeru vodiaceho drôtu s inou intervenčnou pomôckou.
- Vodiaci drôt nepoužívajte u pacientov s alergickou reakciou na kontrastnú látku alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

- Hydrofilná povrchová vrstva tohto vodiaceho drôtu obsahuje PEG400. Nepoužívajte vodiaci drôt u pacientov, u ktorých sa vyskytla alergická reakcia na polyetylén glykol (PEG).
- Nepoužívajte vodiaci drôt u tehotných pacientok alebo pacientok, ktoré môžu byť tehotné (röntgenové zariadenie môže ovplyvniť plod).
- Tento Vodiaci drôt sa smie používať v inštitúcii, kde sa môže okamžite vykonať pohotovostná chirurgická operácia. Ak nie je dostupná

pohotovostná chirurgická operácia, v najhoršom prípade môže dôjsť k život ohrozujúcim udalostiam.

- Vodiaci drôt je vopred sterilizovaný plynným etylénoxidom (EOG) a je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte ani nesterilizujte opakovane. Keby sa opakovane použil alebo sterilizoval, mohla by sa narušiť funkčnosť alebo kvalita vodiaceho drôtu a hrozilo by riziko komplikácií, vrátane infekcie.

Upozornenia

- Vodiaci drôt smie používať výhradne lekár, ktorý je úplne vyškolený v oblasti liečby PCI.
- Nikdy nepoužívajte tento vodiaci drôt v kombinácii s katétami s kovovými časťami, ktoré sa môžu priamo dotýkať povrchu tohto vodiaceho drôtu (napr. aterektomické katétre, kovové dilatátory), kovovými ihlami alebo kovovými puzdrovými zavádzačmi.
- Počas používania vodiaceho drôtu kontrolujte a monitorujte pohyb jeho špičky pod fluoroskopom. Nepoužívajte ho v oblastiach ciev, ktoré nemožno vizualizovať.
- Vodiaci drôt nespájajte s odnímateľnými predlžovacími drôtmí od iných výrobcov ako ASAHI INTECC. Nemanipulujte s vodiacim drôtom, kým je k nemu pripojený odnímateľný vodiaci drôt. Ináč sa vodiaci drôt poškodí alebo sa odpojiteľný predlžujúci drôt neúmyselne odpojí.
- Vodiaci drôt zo žiadneho dôvodu neupravujte.

Bezpečnostné opatrenia

- Vodiaci drôt nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na etikete obalu. Zlikvidujte všetky vodiace drôty, ktoré sú po dátume expirácie.
- Vodiace drôty sú citlivé nástroje a je potrebné narábať s nimi opatrne.
- Ak je obal otvorený alebo poškodený, vodiaci drôt nepoužívajte. Obal otvárajte až tesne pred použitím. Pri manipulácii s vodiacim drôtom, ako aj pri ich používaní, použite aseptickú techniku.
- Vodiaci drôt udržiavajte vždy vo vlhkom stave, aby ste zabránili poškodeniu jeho hydrofilnej povrchovej vrstvy.
- Vodiaci drôt neutierajte pomocou organického roztoku, napríklad alkoholu.
- Po použití podniknite protinfekčné preventívne opatrenia. Vodiaci drôt a obal zlikvidujte ako zdravotný odpad.
- Nikdy netlačte, neskrúčajte, nevťahujte ani netočte vodiaci drôt takou silou, aby ste cítili odpor. Točenie alebo zatlačenie vodiaceho drôtu napriek odporu môže spôsobiť poškodenie vodiaceho drôtu a oddelenie jeho špičky alebo priame poškodenie ciev. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiaceho drôtu. Pod fluoroskopickým pozorovaním určite príčinu odporu a podniknite potrebný nápravný krok.
- Vodiace drôty vždy zasúvajte alebo vytahujte pomaly a opatrne.
- Počas krútenia vodiacim drôtom vnútri krvnej cievy nekrúťte ním stále tým istým smerom. Pri krútení vodiacim drôtom ho striedavo otáčajte v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby ste nevykonali viac ako dve rotácie (720°) tým istým smerom.
- Pri odstraňovaní a opätovnom zavádzaní vodiaci drôt opláchnite heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom alebo iným vhodným roztokom, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do intervenčnej pomôcky. Výmenu vodiaceho drôtu vykonajte opatrne, aby nedošlo k vniknutiu vzduchu a/alebo vzniku traumy. Pri opakovanom zavádzaní vodiaceho drôtu sa presvedčte, že špička intervenčnej pomôcky je v lúmene cievy voľná a že nesmeruje k stene cievy. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu. Polohu potvrdte pomocou kontrastnej značky intervenčnej pomôcky.
- Voľný pohyb vodiaceho drôtu v intervenčnej pomôcke je dôležitým príznakom ovládacieho systému vodiaceho drôtu, pretože používateľovi poskytuje cenné dotykové informácie. Pred použitím systému vyskúšajte, ako sa správa pri odpore. Nastavte alebo vymeňte hemostatický

ventil pomocou nastavovacieho ventilu, ak je prítomný, aby ste zamedzili pohybu vodiaceho drôtu.

- Stent neumiestňujte pomocou viacerých vodiacich drôtov ani nemanipulujte s drôtom prostredníctvom výstupu stentu. V opačnom prípade sa stent môže poškodiť a vodiaci drôt sa môže zlomiť alebo roztrhnúť.
- Pred použitím sa uistite, že vodiaci drôt má vhodnú veľkosť a tvar pre daný postup a je kompatibilný s pomockou, ktoré sa má použiť v kombinácii s ním.
- Pozrite si návod na použitie priložený k zdravotníckej pomôcke (napr. balónikové dilatčné katétre alebo iné intervenčné pomôcky), ktorá sa má použiť v kombinácii s týmto vodiacim drôtom.
- Pri pripájaní odnímateľného predlžovacieho drôtu k tomuto vodiacemu drôtu by sa drôt mal bezpečne zaviesť po hraničnú líniu medzi vrstvou bez polytetrafluoretylénu (PTFE) a vrstvou z PTFE na proximálnom konci vodiaceho drôtu. Ak sa v pripojke zistí akákoľvek abnormalita, okamžite prestaňte vodiaci drôt používať.
- Pred použitím vodiaceho drôtu a kedykoľvek je to možné počas zákroku dôkladne skontrolujte, či vodiaci drôt nie je ohnutý, zauzlený alebo inak poškodený. Ak je vodiaci drôt poškodený, nepoužívajte ho.
- Pri tvarovaní špičky dávajte pozor, aby ste nepoškodili cievku.
- Pred zavedením vodiaceho drôtu skontrolujte, ktorý koniec je distálny, a dajte na to, aby ste ho zavádzali z distálneho konca.
- Počas zákroku vykonávajte priebežné preplachovanie fyziologickým roztokom medzi vodiacim katétrom a intervenčnou pomockou a medzi intervenčnou pomockou a vodiacim drôtom.
- Príprava: heparinizovanie zabraňuje tvorbe a/alebo zrážaniu kontrastnej látky na vodiacom drôte a v lúмене katétra.

Poruchy činnosti a nežiaduce účinky

K možným poruchám činnosti a nežiaducim účinkom pri používaní vodiaceho drôtu okrem iného patria:

1. Porucha činnosti

Neúspešný prechod léziou	Zlomenie alebo ohnutie vodiaceho drôtu	Poškodenie, ako napríklad oddelenie
Ťažkosti pri odstraňovaní	Odlúpenie povrchovej vrstvy	

2. Nežiaduce účinky

Úmrtie	Infekcia	Disekcia ciev
Perforácia ciev	Krvávacé komplikácie	Embólia
Trombus	Infarkt	Ischémia
Arytmia	Vazospazmus	Cievna oklúzia
Zníženie krvného tlaku	Alergická reakcia	Reziduálne

Spôsob použitia

1. Kontrola pred použitím

- Pred použitím dôkladne skontrolujte a overte, či vodiaci drôt a obal nie sú poškodené.
- Pred použitím sa presvedčte, že vodiaci drôt je kompatibilný s intervenčnými pomockami, ktoré sa majú použiť.

2. Príprava

- Zvoľte najvhodnejší vodiaci drôt pre

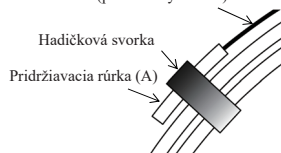
pošihnutú oblasť a pridržiavaciu rúrku obsahujúcu vodiaci drôt vyberte zo sterilného obalu.

- Pridržiavaciu rúrku pomocou injekčnej striekačky naplňte heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom, aby sa navlhčila celá pomôcka. Pripomíname, že počas tohto úkonu môže heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok vytiecť z

pridržiavacej rúrky.

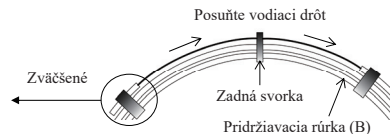
- Pred zavedením vodiaceho drôtu naplňte lúmen intervenčnej pomôcky heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom.

Vodiaci drôt (proximálny koniec)



Obrázok 1

- Vodiaci drôt uvoľníte zo zadnej svorky a pomaly ho posúvajte, distálny koniec vodiaceho drôtu tlačte cez pridržiavaciu rúrku (B). (Obrázok 1)



- Ak sa distálny koniec vodiaceho drôtu predlží o viac ako 4 cm za druhý koniec pridržiavacej rúrky, v prípade potreby upravte tvar špičky podľa štandardného postupu.
- Jemne uchopte vodiaci drôt, ktorý vychádza z distálneho konca pridržiavacej rúrky v bode, ktorý je čo najbližšie k pridržiavacej rúrke, a vodiaci drôt pomaly a opatrne vytiahnite.
- Ak pri vytahovaní vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky pocítite odpor, znovu vstrekните do pridržiavacej rúrky heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok. Keď sa odpor stratí, pokračujte vo vytahovaní vodiaceho drôtu. Dbajte na to, aby ste do pridržiavacej rúrky vstrekli dostatok heparinizovaného a sterilizovaného fyziologického roztoku, pretože pri násilnom vytahovaní potiahnutého vodiaceho drôtu sa môže poškodiť jeho hydrofílna povrchová vrstva.
- Po vytiahnutí vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky sa presvedčte, či nie je poškodený.

- vodiaci katéter, až kým sa špička systému vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
- Utiahnite hemostatický ventil Y-konektora, aby sa vytvorilo utiesnenie okolo intervenčnej pomôcky. Ubezpečte sa, že pohyb vodiaceho drôtu je ešte stále možný.
- Kontrolou sa presvedčte, že sa vodiaci drôt hladko pohybuje.
- V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
- Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým neprejde cez léziu. Angiografiou overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
- Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievach.
- Intervenčnú pomocku zasúvajte, až kým sa nedostane k lézii, pričom zabraňte pohybu vodiaceho drôtu. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomockou.

3. Postupy pre zavedenie

■ Systém Over the wire (OTW)

- Distálny koniec vodiaceho drôtu opatrne zaveďte do lúmenu pre vodiaci drôt intervenčnej pomôcky.
- Opatrne zasúvajte vodiaci drôt, až kým sa jeho špička nedostane najbližšie k špičke intervenčnej pomôcky.
- Nasaďte vodiaci katéter a zaveďte systém intervenčnej pomôcky (s vodiacim drôtom) do Y-konektora.
- Systém intervenčnej pomôcky zasúvajte cez

■ Systém Rapid exchange (RX)

- Nasaďte vodiaci katéter.
- Zavádzač vodiaceho drôtu zaveďte do Y-konektora vodiaceho katétra.
- Opatrne zaveďte špičku vodiaceho drôtu do zavádzača.
- Vodiaci drôt zasúvajte cez vodiaci katéter pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým sa špička vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
- V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.

- f) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním tak, aby prešiel cez léziu. Angiografiou overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
- g) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v cievach.
- h) Odstráňte torzné zariadenie vodiaceho drôtu a zavádzajte vodiaceho drôtu.
- i) Veďte intervenčnú pomôcku po vodiacom drôte, pričom zabráňte pohybu vodiaceho drôtu, a zasúvajte ju až kým sa nedostane k lézii. Zabezpečte, aby bola distálna špička

vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

- 4. Postupy na výmenu vodiaceho drôtu
 - Systém Over the wire (OTW)
 - a) Vodiaci drôt pomaly odstraňujte, pričom sledujte pohyb vodiaceho drôtu pod fluoroskopickým pozorovaním.
 - b) Zaveďte ďalší vodiaci drôt v súlade s pokynmi v časti Spôsob použitia.

Spôsob uschovávaní

Vodiaci drôt a jeho obal nenechávajte ohnutý a/alebo vystavený príliš veľkej záťaži. Vodiaci drôt a jeho obal chráňte pred vodou. Uchovávajte na chladnom, tmavom a suchom mieste.

Dátum expirácie

Dátum expirácie je vyznačený na štítku na obale vodiaceho drôtu.

Obsah

5 kusov v jednej škatuli

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť ASAHI INTECC CO., LTD. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Spoločnosť“) nebude niesť žiadnu zodpovednosť za úrazy, osobné zranenia, nežiaduce účinky zapríčinené nesprávnym používaním produktu (produktov) alebo iným používaním, ktoré nie je v súlade s týmto návodom. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce (i) zo skladovania produktu (produktov) po odoslaní zo spoločnosti ani (ii) z dôvodu výberu pacientov, chirurgických postupov alebo iných lekárskeho činnosti zo strany zdravotníckych zariadení, kde sa produkt (produkty) používa.

„ASAHI Gaia Next“ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti ASAHI INTECC CO.,LTD. v Japonsku a ďalších krajinách.

ASAHI Gaia Next PCI juhttraat

Kasutusjuhend

Enne juhttraadi kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid ja järgige selle kasutusjuhendi peatükke „Kasutusnäidustused“, „Vastunäidustused“, „Hoiatused“, „Ettevaatusabinõud“ ja „Kasutamine“. Selle teabe eiramine võib viia tüsistusteni, kaasa arvatud patsiendi tõsine vigastus või surm.

Kui kasutaja või patsient saab teada tõsisest vahejuhtumist, mis juhttraadiga seoses aset leidis, tuleb tootjat ja pädevat asutust sellest teavitada.

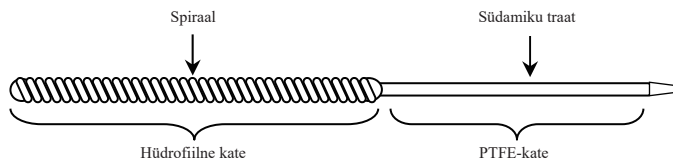
Käesolev kasutusjuhend kehtib ASAHI Gaia Nexti juhttraatide kohta. Andmeid (juhttraadi pikkus, röntgenkontrastse osa pikkus jne) vaadake tootesildilt.

Kirjeldused

See juhttraat on vormitava otsaga suunatav juhttraat ja see on saadaval eelvormitud versioonidena. Juhttraadi välisdiameeter on 0,36 mm (0,014 tolli). See juhttraat ühildub olemasolevate balloondilatatsiooni kateetrite ja muude sekkumiseadmetega, mida tavalises perkautaans koronaarinterventsioonis (PCI) kasutatakse. Juhttraadi otsa distaalne osa on labipaistmatu.

Määrimise tagamiseks on seadme distaalne osa kaetud hüdrofiilse polümeeriga ja juhttraadi proksimaalne osa polüetrafluorotüleeniga (PTFE).

Seadme proksimaalses otsas, mis on alla 300 cm, on ühendus pikendusjuhtme jaoks, mida kasutatakse kombineeritud seadme asendamiseks; sellega saab ühendada ASAHI INTECC-i pikendusjuhtme ja kogupikkus peale ühendamist on 355–400 cm.



Näidustused

See juhttraat on mõeldud üldiseks perkautaansks koronaarinterventsiooniks (PCI). Seda saab kasutada balloondilatatsiooni kateetrite ja muude sekkumiseadmete sisestamiseks ja paigutamiseks kardiovaskulaarsüsteemi.

See juhttraat ei ole ette nähtud kasutamiseks neurovaskulaarses ja perifeerses veresoontes.

Vastunäidustused

- Kontrollige enne tegelikku kasutamist juhttraadi läbimõõdu ühilduvust muu sekkumiseadmega.
- Ärge kasutage juhttraati patsientidel, kellel on kontrastaine suhtes allergiline reaktsioon või kellel on neuromuskulaarse häire.
- Juhttraat sisaldab hüdrofiilset kattel ainet PEG400. Ärge kasutage juhttraati patsientidel, kes on polüetüleenglükooli (PEG) suhtes allergilised.

- Ärge kasutage juhttraati rasedate või potentsiaalselt rasedate patsientide puhul (röntgenikiirgus võib loodet mõjutada).
- Seda juhttraati tohib kasutada vaid asutuses, kus on võimalik erakorralise kirurgilise operatsiooni viivitamatult teostamine. Kui erakorralise kirurgilise operatsiooni tegemise võimalus puudub, võivad halvimal juhul tekkida surmaga lõppevad tüsistused.

Hoiatused

- Seda juhttraati tohib kasutada vaid PCI protseduuri ajal täieliku koolituse saanud arst.
- Ärge kunagi kasutage seda juhttraati koos kateetritega, millel on metallosad, mis võivad otse selle juhttraadi pinnaga kokku puutuda (nt aterektomia kateetrid, metallist dilataatorid), metallist nõelte ega metallist hülsiga sisestajatega.
- Juhttraadi kasutamise ajal kontrollige ja jälgige selle otsa liikumist röntgenoloogiliselt. Ärge kasutage veresoone piirkondades, mille visualiseerimine ei ole võimalik.
- Ärge ühendage selle juhttraadi külge eemaldatavaid pikendustrate, mille tootja on muu kui ettevõtte ASAHI INTECC. Ärge käsitsege seda juhttraati, kui eemaldatav pikendustraat on ühendatud. Vastasel juhul võite kahjustada juhttraati või eemaldatava pikendustradi tahmatult lahti ühendada.
- Ärge muutke juhttraati ühelgi põhjusel.

Ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage juhttraati pärast sildil toodud aegumiskuupäeva möödumist. Aegumiskuupäeva ületanud juhttraadid tuleb ära visata.
- Juhttraadid on õrnad instrumendid ja neid tuleb käsitada ettevaatlikult.
- Ärge kasutage juhttraati, kui pakend on avatud või kahjustatud. Avage pakend alles vahetult enne kasutamist. Kasutage juhttraadi käsitsemisel aseptilist tehnikat.
- Hoidke juhttraati alati märjana, et vältida selle hüdrofiilse katte kahjustamist.
- Ärge pühkige juhttraati orgaanilise lahusega, näiteks alkoholiga.
- Võtke tarvitusele ennetavad meetmed kasutusjärgse infektsioonihoo vältimiseks. Kõrvaldage juhttraadi ja pakend kui meditsiinilised jäätmed.
- Ärge kunagi lükake, keerake, tõmmake välja ega pöörake juhttraati, mille osas on tunda takistust. Juhttraadi pööramine või liikkumine takistuse vastu võib juhttraati kahjustada ja/või põhjustada juhttraadi otsa eraldumist või otseselt kahjustada veresoont. Selle eiramine võib juhttraati kahjustada. Tehke takistuse põhjus röntgenoloogiliselt kindlaks ja kõrvaldage see.
- Juhttraadi vaba liikumine röntgenoloogilises seadmes on juhitava juhttraadi süsteemi oluline funktsioon, kuna see annab kasutajale väärtuslikku takistust teavet. Enne kasutamist kontrollige süsteemi mis tahes takistuste suhtes. Kui hemostaatiline klapp takistab juhttraadi liikumist, reguleerige hemostaatilist klappi või vahetage see välja reguleeritava klapi vastu.

- Ärge sisestage stenti kasutades enam kui ühte juhtetraati või kui käsitsete traati läbi stendi seina. Vastasel juhul võib stent kahjustuda või juhtetraat võib puruneda või lahti tulla.
- Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat oleks protseduuri jaoks sobiva suuruse ja kujuga ning ühilduks kombineeritult kasutatava seadmega.
- Vaadake selle juhtetraadiga koos kasutatava selle külge kinnitatava meditsiiniseadme (nt balloondilatatsiooni kateetrid või muud sekkumisseadmed) kasutusjuhendit.
- Juhtetraadiga ühendamiseks tuleb eemaldatav pikendustraata kindlalt sisestada juhtetraadi proksimaalse otsa mitte-PTFE katte ja PTFE katte piirile. Kui ühenduses avastatakse häireid, lõpetage juhtetraadi kasutamine kohe.
- Kontrollige juhtetraati hoolikalt painutuskohtade, keerdude ja muude kahjustuste suhtes enne kasutamist ja igal võimalikul ajal protseduuri jooksul. Ärge kasutage juhtetraati, kui see on kahjustatud.
- Olge otsa vormimisel ettevaatlik, et spiraali mitte kahjustada.
- Enne juhtetraadi sisestamist kontrollige, milline ots on distaalne ots, ja sisestage see kindlasti distaalsest otsast.
- Protseduuri ajal säilitage juhtkateetri ja sekkumisseadme ning sekkumisseadme ja juhtetraadi vaheline pidev loputamine. Loputamine hoiab ära kontrastaine moodustumise ja/või hüübimise juhtetraadil ja kateetri luumenis.

Tõrked ja kõrvaltoimed

Juhtetraadi kasutamisel tingitud võimalike tõrgete ja kõrvaltoimete hulka kuuluvad muuhulgas järgnevad.

1. Talitlushäired

Kahjustuskoha lähimise ebaõnnestumine	Juhtetraadi purunemine või kõverdumine	Kahjustus, näiteks eraldumine
Keeruline eemaldada	Katte eraldumine	

2. Kõrvaltoimed

Surm	Infektsioon	Vereosone dissektsioon
Vereosone perforatsioon	Veritsustüsistused	Emboolia
Tromb	Kärbumine	Isheemia
Arütmia	Vasospasm	Vaskulaarne oklusioon
Vererõhu langus	Allergiline reaktsioon	Jäädgid

Kasutamine

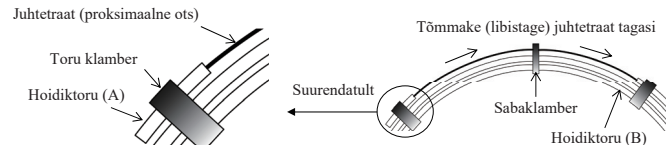
1. Kasutuseelne kontrollimine

- Enne kasutamist kontrollige juhtetraati ja pakendit hoolikalt ja veenduge, et need oleksid kahjustamata.
- Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat ühilduks kasutatavate menetlusradioloogiliste seadmetega.
- Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhtetraadi sisestamist.

2. Ettevalmistus

- Valige kahjustatud ala jaoks sobivaim juhtetraat ja eemaldage hoidiktoru koos juhtetraadiga steriilselt pakendist.
- Täitke hoidiktoru hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega,

- kasutades kogu seadme märjaks tegemiseks süstalt. Arvestage, et sellel ajal võib hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogiline lahus hoidiktorust välja pritsida.
- Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhtetraadi sisestamist.
- Vabastage juhtetraat sabaklambrist ja libistage, lukates juhtetraadi distaalset otsa aeglaselt läbi hoidiktoru (B). (Joonis 1)



Joonis 1

- Kui juhtetraadi distaalne ots on hoidiku toru teisest otsast rohkem kui 4 cm väljas, siis võite vajaduse korral muuta otsa kuju vastavalt tavapärasele praktikale.
 - Haarake õrnalt juhtetraadist, mis väljus hoidiku toru distaalsest otsast, võimalikult hoidiku toru lähedalt ja tõmmake juhtetraat aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
 - Kui juhtetraadi eemaldamisel hoidiktorust on tunda takistust, süstige hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust uuesti hoidiktorusse. Jätke juhtetraadi eemaldamist kui takistust pole enam tunda. Veenduge, et süstiksite hoidiktorusse piisavalt hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust, sest hüdrofiilne kate võib kahjustuda, kui kattega juhtetraadi eemaldamisel kasutatakse jõudu.
 - Pärast juhtetraadi hoidiktorust välja tõmbamist kontrollige, et see ei oleks kahjustatud.
3. Sisestamismeetodid
- Üle traadi süsteem
 - Sisestage juhtetraadi distaalne ots ettevaatlikult röntgenoloogilise seadme juhtetraadi valendikku.
 - Lükake juhtetraati ettevaatlikult edasi, kuni selle ots on röntgenoloogilise seadme otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
 - Haarake juhtekateeter ja sisestage röntgenoloogilise seadme süsteem (koos juhtetraadiga) Y-konnektoris.
 - Lükake röntgenoloogilise seadme süsteemi läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi süsteemi ots on juhtekateetri otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
 - Pinguldage Y-konnektori hemostaatilist klappi, et röntgenoloogilise seadme ümber tekiks tihend. Veenduge, et juhtetraati saaks siiski liigutada.
 - Kontrollige, et juhtetraat liiguks sujuvalt.
 - Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhtetraadi külge.
 - Lükake seda juhtetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogiliselt kontrollides edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.
 - Jälgige juhtetraadi liikumist veresoones.
 - Lükake röntgenoloogilist seadet edasi kuni kahjustuseni ja hoidke samas juhtetraati liikumatuna. Veenduge, et juhtetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.
- Kiire vahetamise süsteem
- Kinnitage juhtekateeter.
 - Sisestage juhtetraadi sisestaja juhtekateetri Y-konnektoris.
 - Sisestage juhtetraadi ots ettevaatlikult sisestajasse.
 - Lükake röntgenoloogiliselt kontrollides juhtetraati läbi juhtekateetri kuni juhtetraadi ots on juhtekateetri otsaga täpselt proksimaalselt.
 - Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhtetraadi külge.
 - Lükake juhtetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogiliselt kontrollides edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhtetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.
 - Jälgige juhtetraadi liikumist veresoones.
 - Eemaldage juhtetraadi pööramise seade ja juhtetraadi sisestaja.
 - Tuvastage juhtetraadil olev röntgenoloogiline seade, hoidke samas juhtetraati liikumatuna, ja lükake edasi kuni kahjustuseni. Veenduge, et juhtetraadi

distaalne ots ja selle asukoht veresoones
oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise
ajal nähtav.

a) Eemaldage see juhtetraat aeglaselt ja jälgige
samas juhtetraadi liikumist
röntgenoloogiliselt.

b) Sisestage järgmine juhtetraat vastavalt
peatükis „Kasutamine” toodud juhiste.

4. Viisid juhtetraadi vahetamiseks

- Üle traadi süsteem

Hoiustamine

Ärge hoidke juhtetraati ja pakendit painutatuna ega suure raskuse all. Juhtetraati ja pakendit peab veest
eemal hoidma. Hoidke jahedas, pimedas ja kuivas kohas.

Aegumiskuupäev

Aegumiskuupäev on toodud juhtetraadi pakendi etiketil.

Pakendi sisu

5 tükki karbis

Vastutusest loobumise säte

„ASAHI INTECC CO., LTD.“ ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi „ettevõtte“) ei vastuta mingil viisil
õnnetuste, vigastuste ega kõrvaltoimete eest, mille põhjuseks on toote sobimatu kasutamine või
käsitleva juhendi eiramine. Mitte ühelgi juhul ei ole ettevõtte vastutav mis tahes kahjude eest, mis
tulenevad kas i) toote (toodete) hoiustamisest pärast ettevõttepoolset tarnimist või ii) patsientide,
operatsioonitehnikate või mis tahes muude meditsiiniliste tegevuste valikust toodet (tooteid) kasutava
meditsiiniiasutuse poolt.

„ASAHI Gaia Next“ on ettevõtte ASAHI INTECC CO.,LTD. registreeritud kaubamärk Jaapanis ja teistes
riikides.

ASAHI Gaia Next PCI vadītājstīga

Lietošanas norādījumi

Pirms izmantot šo vadītājstīgu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus un ievērojiet Lietošanas norādījumos ietvertu sadaļu "Lietošanas indikācijas", "Kontraindikācijas", "Brīdinājumi", "Piesardzības pasākumi" un "Kā lietot" informāciju. To neievērojot, var izraisīt sarežģījumus, tajā skaitā nopietnus pacienta savainojumus vai nāvi.

Ja lietotājs vai pacients uzzina par nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar vadītājstīgu, šis fakts ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.

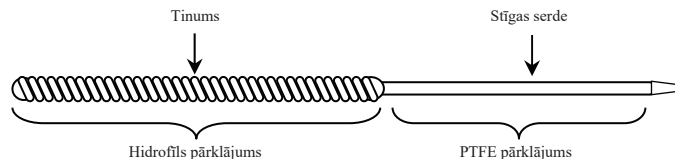
Šie Lietošanas norādījumi attiecas uz ASAHI Gaia Next. Detalizētu informāciju (vadītājstīgas garumu, starojumu neaurlaidīgās daļas garumu u. c.) skatiet izstrādājuma etiķetē.

Apraksts

Šī vadītājstīga ir virzāma vadītājstīga ar formējamo uzgali, un tā ir pieejama iepriekš izveidotās formās. Vadītājstīgas ārējais diametrs ir 0,36 mm (0,014 collas). Šī vadītājstīga ir saderīga ar esošajiem balonveida paplašināšanas katetriem un citām ķirurģiskām ierīcēm, kas tiek parasti lietotas perkutānās koronārās intervences (PCI) procedūrās. Vadītājstīgas uzgala distālā daļa ir starojumu neaurlaidīga.

Lubrikācijai ierīces distālā daļa ir pārklāta ar hidrofilu polimēru un vadītājstīgas proksimālā daļa ir pārklāta ar polietilēna fluorētienu (PTFE).

Proksimālajā ierīces (kas ir īsāka par 300 cm) galā ir savienojuma vieta stīgas pagarinājumam, kas tiek izmantots, lai aizstātu kombinēto ierīci. Šajā vietā var pievienot ASAHI INTECC stīgas pagarinājumu, un kopējais stīgas garums pēc savienošanas ir 355–400 cm.



Lietošanas indikācijas

Šo vadītājstīgu ir paredzēts izmantot vispārīgās perkutānās koronārās intervences (PCI) procedūrās. To var izmantot, lai sirds un asinsvadu sistēmā ievadītu un izvietotu balonveida paplašināšanas katetrus un citas ķirurģiskas ierīces.

Vadītājstīgu nav paredzēts izmantot neirovaskulārās un perifēro asinsvadu procedūrās.

Kontraindikācijas

- Pirms faktiskās izmantošanas pārbaudiet vadītājstīgas diametra atbilstību citām ķirurģiskajām ierīcēm.
- Neizmantojiet vadītājstīgu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija uz kontrastvielām vai kuriem ir nieru darbības traucējumi.
- Šīs vadītājstīgas hidrofilajā pārklājumā ir savienojums PEG400. Nelietojiet vadītājstīgu

pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija uz polietilēna glikolu (PEG).

- Neizmantojiet vadītājstīgu grūtniecēm vai pacientiem, kurām varētu būt iestājusies grūtniecība (rentgenstari var ietekmēt augli).
- Šī vadītājstīga jāizmanto iestādē, kur vai tūlītīgi veikt ķirurģisku operāciju. Ja nav pieejama tūlītēja ķirurģiskās operācijas iespēja, ļaunākajā

gadījumā var tikt izraisīti dzīvībai bīstami notikumi.

- Šī vadītājstīga ir iepriekš sterilizēta ar etilēnoksidu gāzi (EOG) un paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantojiet to nesterilizēti atkārtoti. Atkārtoti lietojot vai sterilizējot, var tikt apdraudēta šīs vadītājstīgas veikspēja un kvalitāte un attiecīgi rasties sarežģījumu, tajā skaitā, infekcijas risks.

Brīdinājumi

- Šo vadītājstīgu drīkst lietot tikai ārsts, kas ir pilnībā apmācīts PCI.
- Nekad neizmantojiet vadītājstīgu kopā ar katetriem, kam ir metāla detaļas, kas var tieši saskarties ar šīs vadītājstīgas virsmu (piemēram, aterektoņijas katetri, metāla dilatatori), metāla adatām vai metāla apvalka ievadītājiem.
- Vadītājstīgas lietošanas laikā pārbaudiet un uzraugiet tās uzgala kustību fluoroskopijās
- Nelietojiet vadītājstīgu pēc etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām. Izmetiet visas vadītājstīgas, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
- Vadītājstīgas ir trausli instrumenti, tāpēc ar tām jārīkojas uzmanīgi.
- Ja iesaiņojums ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo vadītājstīgu. Neatveriet iesaiņojumu līdz pašai lietošanai. Pārviotot un izmantojot vadītājstīgu, izmantojiet aseptisku tehniku.
- Vadītājstīgai vienmēr jābūt mitrai, lai novērstu tās hidrofilā pārklājuma bojājumus.
- Neslaukiet vadītājstīgu, izmantojot organisku šķidrumu, piemēram, alkoholu.
- Šķīduma lietošana veicot profilakses pasākumus, lai nepieļautu infekciju. Izmetiet vadītājstīgu un tās iepakojumu kā medicīnas atkritumus.
- Nekādā gadījumā nestumiet, negrieziet, neizvelciet un nespiediet šo vadītājstīgu, ja ir jūtama pretestība. Stumjot vai spiežot šo vadītājstīgu ar spēku, iespējama vadītājstīgas sabojāšana un/vai uzgala atdalīšanās, kā arī iespējami tieši asinsvadu bojājumi. To neievērojot, šai vadītājstīgai var rasties bojājumi. Ar fluoroskopijas palīdzību nosakiet pretestības cēloni un veiciet visas nepieciešamās korektīvās darbības.
- Vienmēr virziet vai izņemiet vadītājstīgas lēnām un uzmanīgi.
- Nelietojiet tajās asinsvadu vietās, kuras netiek vizualizētas vai nevar vizualizēt.
- Nepievienojiet šo vadītājstīgu atvienojamiem stīgas pagarinājumiem, kas nav ASAHI INTECC ražojums. Neveiciet manipulācijas ar vadītājstīgu, kamēr ir pievienots atvienojamais stīgas pagarinājums. Pretējā gadījumā var sabojāties vadītājstīga vai var netīšām atvienoties atvienojamais vadītājstīgas pagarinājums.
- Nekādā gadījumā nemodificējiet šo vadītājstīgu.

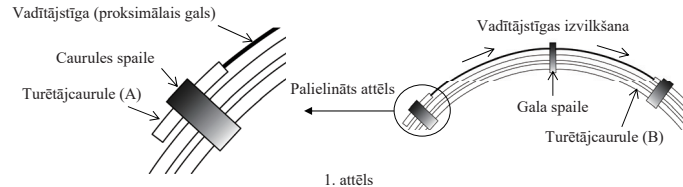
Piesardzības

- Grozot šo vadītājstīgu asinsvadā, negroziet to nepārtraukti vienā virzienā. Griezt vadītājstīgu, grieztot to pamīšus pulksteņrādītāju kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Neveiciet vairāk nekā divus apgriezienus (720°) vienā virzienā.
- Ņemot vērā, ka šī ierīce ir paredzēta vienreizējai lietošanai, noskaidrojiet to ar sterilizētu heparinētu fizioloģisko šķidrumu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi ķirurģiskajā ierīcē. Uzmanīgi veiciet šīs vadītājstīgas nomaigu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi un/vai traumas. Ievadot vadītājstīgu no jauna, pārliecinieties, lai ķirurģiskās ierīces gals ir brīvs asinsvada lūmenā un nepieskaras asinsvada sienai. To neievērojot, var izraisīt asinsvadu traumas. Lai apstiprinātu pozīciju, izmantojiet starojumu neaurlaidīgu ķirurģiskās ierīces marķieri.
- Brīva vadītājstīgas kustība ķirurģiskajā ierīcē ir svarīga vadāmas vadītājstīgas sistēmas funkcija, jo lietotājam tā nodrošina vērtīgu taustes informāciju. Pirms lietošanas pārbaudiet sistēmu, vai nav nekādas pretestības. Ja konstatējat, ka hemostatisks vārstis kavē vadītājstīgas kustību, koriģējiet to vai aizstājiet ar regulējamu vārstu.
- Neveiciet stenta ievietošanu, izmantojot vairāk nekā vienu vadītājstīgu vai asinsvada operāciju

cauri stenta sienai. Pretējā gadījumā stents var tikt bojāts vai vadītājs tīģa var salūzt vai pārlūzt.

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir izvēlēts procedūrai atbilstošs vadītājs tīģis izmērs un forma un vai tā ir saderīga ar ierīci, ko paredzēts lietot kombinācijā ar šo vadītājs tīģi.
- Skatiet lietošanas instrukciju, kas pievienota medicīnas ierīcei (piemēram, balona dilatācijas katetri vai citas iekārtas ierīces), ko paredzēts lietot kopā ar šo vadītājs tīģi.
- Savienojot ar vadītājs tīģi atvienojamo vadītājs tīģis pagarinājumu, tas stingri jāievieto līdz robežlīnijai starp ne PTFE un PTFE pārklājumu vadītājs tīģis proksimālajā galā. Ja savienojumā ir novērojama jebkāda problēma, nekavējoties pārtrauciet vadītājs tīģis izmantošanu.

- Pirms lietošanas un procedūras veikšanas laikā (kad vien iespējams) uzmanīgi pārbaudiet vadītājs tīģi, vai nav liekumu, mezglu vai citu bojājumu. Nelietojiet vadītājs tīģi, ja tā ir bojājumi.
- Uzgaļa veidošanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tīnu.
- Pirms vadītājs tīģis ievietošanas pārbaudiet, kurš ir distālais gals, un sāciet ievietošanu ar distālo galu.
- Procedūras laikā uzturiet nepārtrauktu skalošanu ar fizioloģisko šķidrumu starp virzītājs katetru un ķirurģisko ierīci, kā arī starp ķirurģisko ierīci un vadītājs tīģi. Skalošana novērš kontrastvielas krāšanos un/vai recēšanu uz vadītājs tīģis un katetra lūmenā.



- Kad vadītājs tīģis distālais gals ir pagarināts par vairāk kā 4 cm otrā turētājs katetra galā, ja nepieciešams, veidojiet gala formu atbilstoši standarta praksei.
- Vadītājs tīģi, kas tika izvirzīta pa turētājs katetra distālo galu, saudzīgi satveriet pēc iespējas tuvāk turētājs katetrai un lēnām un uzmanīgi izvelciet.
- Ja, izņemot vadītājs tīģi no turētājs katetra, jūtama pretestība, injicējiet turētājs katetrā ne jauna heparīnu saturu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu. Kad vairs nav jūtama pretestība, turpiniet vadītājs tīģis izņemšanu. Noteikti injicējiet turētājs katetrā pietiekamu heparīnu saturu sterilizētu fizioloģiskā šķidruma daudzumu, jo ar spēku noņemot pārklāto vadītājs tīģi, var sabojāt hidrofilo pārklājumu.
- Pēc vadītājs tīģis izvilkšanas no turētājs katetra pārbaudiet to, lai pārliecinātos, vai nav bojājumu.

3. Ievietošanas procedūras

■ Stīgas sistēma

- Uzmanīgi ievietojiet vadītājs tīģis distālo galu ķirurģiskās ierīces vadītājs tīģis lūmenā.
- Uzmanīgi virziet šo vadītājs tīģi, līdz tās gals ir tieši pie ķirurģiskās ierīces gala.
- Izmantojiet virzītājs katetru un ievietojiet ķirurģiskās ierīces sistēmu (ar vadītājs tīģi) Y veida savienotājā.
- Virziet ķirurģiskās ierīces sistēmu caur virzītājs katetru, līdz vadītājs tīģis sistēmas gals ir tieši pie virzītājs katetra gala.
- Savēlciot Y veida savienotāja hemostatisko vārstu, lai izveidotu ķirurģiskās ierīces izolāciju. Pārliecinieties, vai vadītājs tīģis kustība netiek traucēta.
- Pārbaudiet, vai vadītājs tīģis kustība notiek bez aizķeršanās.

- Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājs tīģi pagriešanas ierīci.
- Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājs tīģi cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājs tīģis ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.
- Novērojiet vadītājs tīģis virzību asinsvados.
- Virziet ķirurģisko ierīci, līdz tiek sasniegti bojājums, vienlaikus nepieļaujot vadītājs tīģis kustību. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājs tīģis distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

■ Straujas nomaigšanas sistēma

- Izmantojiet virzītājs katetru.
- Ievietojiet vadītājs tīģis ievadītāju virzītājs katetra Y veida savienotājā.
- Uzmanīgi ievietojiet vadītājs tīģis gala ievadītāju.
- Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājs tīģi caur virzītājs katetru, līdz vadītājs tīģis gals ir tieši pie virzītājs katetra gala.
- Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājs tīģi pagriešanas ierīci.
- Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājs tīģi, lai tā izietu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājs tīģis ir pavirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.
- Novērojiet vadītājs tīģis virzību asinsvados.
- Izmēniet vadītājs tīģis pagriešanas ierīci un vadītājs tīģis ievadītāju.
- Virziet ķirurģisko ierīci pa vadītājs tīģi, vienlaikus nepieļaujot vadītājs tīģis kustību, un virziet to, līdz tiek sasniegti bojājums. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājs tīģis

Darbības traucējumi un blakusparādības

Izmantojot šo vadītājs tīģi, iespējamie darbības traucējumi un blakusparādības ietver, bet neaprobežojas ar:

1. Darbības traucējumi

Nespēja šķērsot bojājuma vietu	Vadītājs tīģis salūšana vai saliekšanās	Bojājums, piemēram, atdalīšanās
Grūtības izņemt	Pārklājuma atdalīšanās	

2. Blakusparādības

Nāve	Infekcija	Asinsvada disekcija
Asinsvada perforācija	Asināšanas sarežģījumi	Embolija
Trombi	Infarkts	Išēmija
Aritmija	Asinsvadu spazmas	Asinsvadu aizsprostojums
Asinsspiediena pazemināšanās	Alerģiska reakcija	Atlikušās blakusparādības

Lietošana

1. Pārbaude pirms lietošanas

- Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet vadītājs tīģi un iepakojumu un pārliecinieties, vai nav bojājumu.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai vadītājs tīģis ir saderīga ar izmantojamo ķirurģisko ierīci.

2. Sagatavošana

- Izvēlieties attiecīgajai vietai vispiemērotāko vadītājs tīģi un izņemiet no sterilā iepakojuma turētājs katruli, kurā ir vadītājs tīģis.
- Piepildiet turētājs katruli ar heparinizētu, sterili

- fizioloģisko šķidrumu, izmantojot šļirci, lai samērcētu visu ierīci. Ievērojiet, ka, to darot, no turētājs katetra var izlīst heparinizētais, sterlais fizioloģiskais šķidrum.
- Pirms ievietojat vadītājs tīģi, piepildiet ķirurģiskās ierīces lūmenu ar heparīnu saturu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu.
- Atbrīvojiet vadītājs tīģi no gala spaiļes un lēni kustiniet vadītājs tīģi, izstumiet vadītājs tīģis distālo galu caur turētājs katruli (B). (1. attēls)

- distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

novērojot tās kustību ar fluoroskopijas palīdzību.
4. Vadītājstīgas maiņas procedūras

■ Stīgas sistēma

a) Izņemiet vadītājstīgu lēni, vienlaikus

b)Ievietojiet nākamo vadītājstīgu atbilstoši norādījumiem šajā sadaļā “Lietošana”.

Uzglabāšanas metode

Neglabājiet vadītājstīgu un iesaiņojumu saliektā un/vai noslogotā stāvoklī. Šī vadītājstīga un iesaiņojums jāsargā no ūdens. Glabājiet tos vēsā, tumšā un sausā vietā.

Derīguma termiņš

Derīguma termiņš norādīts uz vadītājstīgas iesaiņojuma etiķetes.

Saturs

5 gabali/kaste

Saistību atruna

“ASAHI INTECC CO., LTD. un tā filiāles” (tālāk tekstā — “Uzņēmums”) nekādā gadījumā neatbild par negadījumiem, personāla traumām un blaknēm, kas radušās, nepareizi vai jebkā citādi šiem norādījumiem neatbilstoši lietojot produktu(s). Uzņēmums nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem bojājumiem, kas (i) rodas, produktu(-s) glabājot pēc nosūtīšanas no Uzņēmuma, vai (ii) rodas, medicīnas iestādei, kura izmanto produktu(-s), izvēloties pacientus, ķirurģiskās iejaukšanās paņēmienus vai jebkādas citas medicīniskas darbības.

“ASAHI Gaia Next” ir uzņēmuma “ASAHI INTECC CO.,LTD.” reģistrēta preču zīme Japānā un citās valstīs.

„ASAHI Gaia Next“ PKI kreipiamoji vėla

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami šią kreipiamąją vėlą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės šios naudojimo instrukcijos skyriuose „Naudojimo indikacijos“, „Kontraindikacijos“, „Įspėjimai“, „Atsargumo priemonės“ ir „Kaip naudoti“ pateiktų nurodymų. To nepadarius gali kilti komplikacijų, įskaitant sunkius paciento sužalojimus arba mirtį.

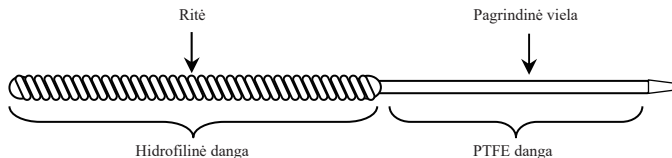
Jei naudotojas arba pacientas sužino apie rimtą incidentą, susijusį su kreipiamąja vėla, praneškite apie tai gamintojui ir kompetentingai institucijai.

Ši naudojimo instrukcija taikoma „ASAHI Gaia Next“. Išsamios informacijos (kreipiamosios vėlos ilgis, rentgenokontrastinės dalies ilgis ir t. t.) ieškokite gamintojo etiketėje.

Aprašas

Ši kreipiamoji vėla yra valdomoji kreipiamoji vėla su formuojamu galiuku. Galima rinktis iš įvairių iš anksto suformuoto galiuko variantų. Kreipiamosios vėlos išorinis skersmuo yra 0,36 mm (0,014 colio). Ši kreipiamoji vėla suderinama su esamais balioniniais dilatacijos kateteriais ir kitais intervenciniais prietaisais, naudojamais atliekant bendrąjį perkutaninę koronarinę intervenciją (PKI). Kreipiamosios vėlos galiuko distalinė dalis yra rentgenokontrastinė.

Siekiant sumažinti trintį, distalinė prietaiso dalis yra padengta hidrofiliniu polimeru, o proksimalinė kreipiamosios vėlos dalis yra padengta politetrafluoretilenu (PTFE). Proksimaliniame prietaiso, kuris yra trumpesnis nei 300 cm, galiuke yra jungtis, skirta ilginamajai vėlai, kuri yra naudojama siekiant pakeisti sudėtinį prietaisą; galima prijungti ASAHI INTECC ilginamąją vėlą, o bendras ilgis prijungus yra 355–400 cm.



Naudojimo indikacijos

Ši kreipiamoji vėla skirta bendrajai perkutaninei koronarinei intervencijai (PKI) atlikti. Ją galima naudoti siekiant įvesti balioninius dilatacijos kateterius ir kitus intervencinius prietaisus bei nustatyti jų padėtį širdies ir kraujagyslių sistemoje.

Ši kreipiamoji vėla neskirta naudoti neurovaskulinėse ir periferinėse kraujagyslėse.

Kontraindikacijos

- Prieš naudodami patikrinkite kreipiamosios vėlos skersmenį suderinamumą su kitu intervenciniu prietaisu.
- Kreipiamosios vėlos negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai arba kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas.

- Šios kreipiamosios vėlos hidrofilinėje dangoje yra PEG400. Nenaudokite kreipiamosios vėlos pacientams, kurie yra alergiški polietilenglikoliui (PEG).
- Nenaudokite kreipiamosios vėlos nėščioms arba galimai nėščioms pacientėms (rentgeno spinduliai gali paveikti vaisių).
- Ši kreipiamoji vėla turi būti naudojama įstaigoje, kurioje nedelsiant galima atlikti neatidėliotiną chirurginę operaciją. Jei neatidėliotinos

chirurginės operacijos atlikti negalima, blogiausiu atveju gali įvykti gyvybei pavojingų įvykių.

- Ši kreipiamoji vėla iš anksto sterilizuota etileno oksido dujomis (EOG) ir yra skirta naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite ir nesterilizuokite pakartotinai. Pakartotinai naudojant ar pakartotinai sterilizuojant šią kreipiamąją vėlą gali pablogėti jos veikimas ar kokybė ir gali padidėti komplikacijų, įskaitant infekciją, riziką.

Įspėjimai

- Šią kreipiamąją vėlą gali naudoti tik gydytojas, išmokytas atlikti PKI procedūras.
- Niekada nenaudokite šios kreipiamosios vėlos su kateteriais, turinčiais metalinių dalių, kurios gali tiesiogiai liestis su šios kreipiamosios vėlos paviršiumi (pvz., atektomijos kateteriais, metaliniais plėtikliais), metalinėmis adatomis arba metaliniais apvalkalų įvedimo įtaisais.
- Naudodami kreipiamąją vėlą tikrinkite ir stebėkite jos galiuko judėjimą fluoroskopyje.
- Nenaudokite kraujagyslės srityse, kurios nėra arba negali būti atvaizduotos.
- Nejunkite šios kreipiamosios vėlos prie nuimamų ilginamųjų vėlų, kurias pagamino ne ASAHI INTECC. Nevaldykite šios kreipiamosios vėlos, kai prijungta nuimama ilginamoji vėla. Priešingu atveju galite sugadinti kreipiamąją vėlą arba gali netyčia atsijungti nuimama ilginamoji vėla.
- Nemodifikuokite šios kreipiamosios vėlos dėl bet kokios priežasties.

Atsargumo priemonės

- Nenaudokite kreipiamosios vėlos pasibaigus etiketėje nurodytam galiojimo terminui. Išmeskite visas kreipiamąsias vėlas, kurių galiojimo terminas praėjęs.
- Kreipiamosios vėlos yra jautrūs instrumentai ir su jomis reikia elgtis atsargiai.
- Jei pakuotė atidaryta arba pažeista, kreipiamosios vėlos nenaudokite. Pakuotę atidarykite tik prieš pat naudojimą. Įdmiui ir naudodami kreipiamąją vėlą, naudokite aseptinius metodus.
- Kreipiamąją vėlą visada laikykite drėgnai, kad nepažeistumėte jos hidrofilinės dangos.
- Nevalykite kreipiamosios vėlos organiniu tirpalu, pvz., alkoholiu.
- Panaudoję prietaisą imkitės prevencinių priemonių, kad užkirstumėte kelią infekcijai. Kreipiamąją vėlą ir pakuotę išmeskite kaip medicines atliekas.
- Nebandykite stumti,ukti, ištraukinėti ir sukoti kreipiamosios vėlos, jeigu jaučiamas pasipriešinimas. Sukant ar stumiant per jėgą kyla gali būti pažeista kreipiamoji vėla ir (arba) gali atitrūkti jos galiukas, arba gali būti tiesiogiai pažeista kraujagyslė. Nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti šią kreipiamąją vėlą.
- Fluoroskopu nustatykite pasipriešinimo priežastį ir imkitės visų reikalingų taisomųjų veiksmų.
- Kreipiamąsias vėlas visada stumkite arba traukite lėtai ir atsargiai.
- Sukdami šią kreipiamąją vėlą kraujagyslėje, nesukite jos pastoviai ta pačia kryptimi. Kai sukatte kreipiamąją vėlą, pakaitomis sukatte prieš laikrodžio rodyklę ir pagal laikrodžio rodyklę. Nesukite daugiau nei du sukimus (720°) ta pačia kryptimi.
- Kreipiamąją vėlą ištraukdami ir vėl įstatydami praplaukite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu arba kitu atitinkamu tirpalu, kad išvengtumėte oro patekimo į intervencinį prietaisą. Atsargiai pakeiskite šią kreipiamąją vėlą, kad išvengtumėte oro patekimo ir (arba) traumos. Vėl kišdami kreipiamąją vėlą įsitikinkite, kad intervencinio prietaiso galiukas kraujagyslės spindyje juda laisvai ir nėra prie kraujagyslės sienelės. To nepadaryę galite sukelti traumą. Padėtį patvirtinkite naudodamiesi intervencinio prietaiso rentgenokontrastiniais žymekliais.
- Tai, kad kreipiamoji vėla gali lengvai judėti intervenciniame prietaise, yra svarbi valdomosios kreipiamosios vėlos sistemos savybė, nes

suteikia naudotojui vertingos taktinės informacijos. Prieš naudodami patikrinkite, ar sistemoje nėra pasipriešinimo. Sureguliuokite arba pakeiskite hemostazinį vožtuvą reguliuojamų vožtuvų, jei jis trukdo kreipiamajai vielai judėti.

- Įvesdami stentą naudokite tik vieną kreipiamąją vielą ir nebandykite kišti vielos pro stento atramą. Priešingu atveju stentas gali būti pažeistas arba kreipiamoji viela gali sulūžti arba perlūžti.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad ši kreipiamoji viela yra tinkamo dydžio ir formos, kad būtų galima atlikti procedūrą, ir yra suderinama su prietaisu, kuris bus naudojamas kartu.
- Žr. prie medicinos priemonės (pvz., balioninių dilatacijos kateterių ar kitų intervencinių prietaisų), kuri bus naudojama kartu su šia kreipiamąja viela, pridėtą naudojimo instrukciją.
- Nuimamą ilginamąją vielą prijungiant prie šios kreipiamosios vielos, kreipiamąją vielą gali reikėti tvirtai įstatyti prie ribinės linijos tarp

- dangos be PTFE ir PTFE dangos proksimaliniame kreipiamosios vielos galiuke. Jei jungtyje aptinkama kokių nors anomalijų, nedelsdami nustokite naudoti kreipiamąją vielą.
- Prieš naudodami ir, jei įmanoma, per procedūrą atidžiai patikrinkite, ar kreipiamoji viela nėra sulenkta, susisukusi ar kitaip pažeista. Nenaudokite kreipiamosios vielos, jei ji pažeista.
 - Formuodami galiuką būkite atsargūs, kad nepažeistumėte ritės.
 - Prieš įvesdami kreipiamąją vielą patikrinkite, kuris galiukas yra distalinis, ir įsitikinkite, kad ją vedate pradėdami nuo distalinio galiuko.
 - Per procedūrą užtikrinkite fiziologinio tirpalo leidimą tarp kreipiamos kateterio ir intervencinio prietaiso ir tarp intervencinio prietaiso ir kreipiamosios vielos. Fiziologinio tirpalo leidimas apsaugo nuo kontrastinės medžiagos susidarymo ir (arba) krešulių susidarymo ant kreipiamosios vielos ir kateterio spindžio.

Sutrikimai ir nepageidaujami reiškiniai

Naudojant šią kreipiamąją vielą gali būti toliau išvardytų sutrikimų ir nepageidaujamų reiškinių, tačiau šis sąrašas nėra išsamus.

1. Sutrikimai

Negebjimas kirsti pažeidimo vietos	Kreipiamosios vielos lūžis arba sulinkimas	Pažeidimas, pavyzdžiui, atsiskyrimas
Sunku pašalinti	Dangos atsiskyrimas	

2. Nepageidaujami reiškiniai

Mirtis	Infekcija	Kraujagyslės disekcija
Kraujagyslės perforacija	Komplicacijos dėl kraujavimo	Embolija
Trombas	Infarktas	Išemija
Aritmija	Vazospazmas	Kraujagyslių okliuzija
Sumažėjęs kraujo spaudimas	Alerginė reakcija	Liekamieji reiškiniai

Kaip naudoti

1. Apžiūra prieš naudojant

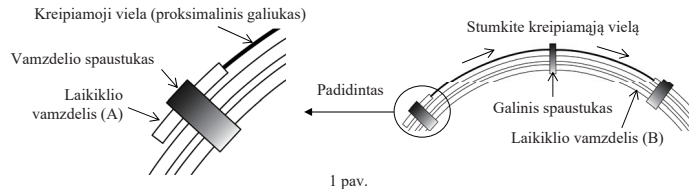
- Prieš naudodami atidžiai apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad kreipiamoji viela ir pakuotė nepažeisti.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar kreipiamoji viela yra suderinama su intervenciniu prietaisu, kurį planuojama naudoti.

2. Paruošimas

- Pasirinkite pažeistai sričiai tinkamiausią kreipiamąją vielą ir iš sterilios pakuotės išimkite laikiklio vamzdelį, kuriame yra kreipiamoji viela.
- Laikiklio vamzdelį švirkštu užpildykite

- heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu, kad sudrekinumėte visą prietaisą. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu heparinizuotas ir sterilizuotas fiziologinis tirpalas neišsilietų iš laikiklio vamzdelio.

c) Prieš įvesdami kreipiamąją vielą intervencinio



1 pav.

- Kai kreipiamosios vielos distalinis galiukas išlenda daugiau nei 4 cm pro kitą laikiklio vamzdelio galą, jei reikia, galiuką galite suformuoti įprastai.
- Švelniai suimkite kreipiamąją vielą, išlindusią pro distalinį laikiklio vamzdelio galą, kuo arčiau laikiklio vamzdelio ir lėtai bei atsargiai ištraukite kreipiamąją vielą.
- Jeigu kreipiamąją vielą ištraukiant iš laikiklio vamzdelio juntamas pasipriešinimas, į laikiklio vamzdelį vėl suleiskite heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo. Kai nebejausite pasipriešinimo, toliau traukite kreipiamąją vielą. Būtinai į laikiklio vamzdelį suleiskite pakankamai heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo, nes stipriai traukiant kreipiamąją vielą su danga galima pažeisti hidrofilinę dangą.
- Ištraukę iš laikiklio vamzdelio kreipiamąją vielą, patikrinkite, ar ji nepažeista.

3. Įstatymo procedūros

- „Over-the-wire“ sistema
 - Atsargiai įstatykite distalinį kreipiamosios vielos galiuką į intervencinio prietaiso kreipiamosios vielos spindį.
 - Stumkite kreipiamąją vielą, kol jos galiukas bus prie intervencinio prietaiso galiuko.
 - Prijunkite kreipiamąjį kateterį ir įstatykite intervencinio prietaiso sistemą (su kreipiamąja viela) į Y formos jungiamąją dalį.
 - Stumkite intervencinio prietaiso sistemą pro kreipiamąjį kateterį, kol kreipiamosios

prietaiso spindį užpildykite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu.

- Atjunkite kreipiamąją vielą nuo galinio spausdiko ir lėtai stumkite kreipiamąją vielą, kreipiamosios vielos distalinį galiuką stumkite pro laikiklio vamzdelį (B). (1 pav.)

vielos sistemos galiukas bus šalia kreipiamos kateterio galiuko.

- Užsukite Y formos jungiamosios dalies hemostazinį vožtuvą, kad intervencinis prietaisas būtų sandarus. Įsitikinkite, kad kreipiamoji viela vis dar gali judėti.
- Patikrinkite, ar kreipiamoji viela sklandžiai juda.
- Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
- Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
- Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- Nejudindami kreipiamosios vielos, stumkite intervencinį prietaisą, kol pasieksite pažeidimo vietą. Įsitikinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

■ Greitojo pakeitimo sistema

- Prijunkite kreipiamąjį kateterį.
- Įstatykite kreipiamosios vielos stūmiklį į kreipiamos kateterio Y formos jungiamąją dalį.
- Atsargiai įstumkite kreipiamosios vielos galiuką į stūmiklį.
- Stumkite kreipiamąją vielą pro kreipiamąjį kateterį stebėdami fluoroskopu, kol kreipiamosios vielos galiukas atsidsus šalia

- kreipiamojo kateterio galiuko.
- e) Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
- f) Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitikinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
- g) Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- h) Nuimkite kreipiamosios vielos sukimo prietaisą ir kreipiamosios vielos stūmiklį.
- i) Stumkite intervencinį prietaisą virš kreipiamosios vielos saugodami, kad

kreipiamoji viela nejudėtų, kol bus pasiektas pažeidimas. Įsitikinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje yra matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

4. Kreipiamosios vielos pakeitimo procedūros

- „Over-the-wire“ sistema
 - a) Lėtai ištraukite kreipiamąją vielą stebėdami jos judėjimą fluoroskopu.
 - b) Remdamiesi skyriuje „Kaip naudoti“ pateiktais nurodymais, įstatykite kitą kreipiamąją vielą.

Sandėliavimo būdas

Kreipiamosios vielos ir pakuotės nelaikykite sulenktų ir (arba) labai suspaustų. Šią kreipiamąją vielą ir pakuotę reikia laikyti atokiau nuo vandens. Laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.

Galiojimo terminas

Galiojimo terminas nurodytas kreipiamosios vielos pakuotės etiketėje.

Turinys

5 vienetai dėžutėje

Atsakomybės atsisakymas

Bendrovė ASAHI INTECC CO., LTD. ir su ja susijusios bendrovės (toliau - „Bendrovė“) nėra atsakingos už nelaimingus atsitikimus, kūno sužalojimus ar kitą neigiamą poveikį, kurį sukėlė bet kokio gaminio (-ių) netinkamas naudojimas ar bet koks kitas naudojimas, kuris neatitinka šių nurodymų. Bendrovė jokiais aplinkybėmis neatsako už žalą, kuri atsiranda dėl i) netinkamo gaminio (-ių) laikymo po įsigijimo iš Bendrovės dienos arba ii) dėl netinkamo sveikatos priežiūros įstaigos, kuri naudoja gaminį (-ius), pacientų, operacinės technikos ar medicininių procedūrų pasirinkimo.

„ASAHI Gaia Next“ yra ASAHI INTECC CO.,LTD. prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Japonijoje ir kitose šalyse.

ASAHI Gaia Next PCI Kılavuz Teli

Kullanım Talimatları

Bu kılavuz teli kullanmadan önce Kullanım Talimatlarının Kullanım Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uyarıları, Kullanım Önemleri ve Kullanma Şekli bölümlerini dikkatle okuyun ve talimatlara uyun. Aksi durumda hastanın ciddi şekilde yaralanması veya ölümü dâhil komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

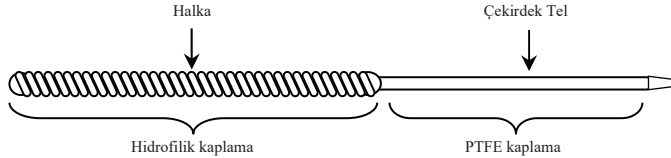
Bir kullanıcı veya hasta kılavuz telle ilgili ciddi bir olaydan haberdar olursa bu durumu üreticiye ve yetkili makama bildirin.

Bu Kullanım Talimatları ASAHI Gaia Next için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için (kılavuz tel uzunluğu, radyopak bölüm uzunluğu, vb.), ürün etiketine bakın.

Açıklamalar

Bu kılavuz tel, şekillendirilebilir bir uca sahip yönlendirilebilir bir kılavuz teldir ve önceden şekillendirilmiş varyantları mevcuttur. Kılavuz telin dış çapı 0,36 mm'dir (0,014 inç). Bu kılavuz tel, mevcut balon dilatasyon kateterleri ve yaygın perkütan koroner girişimde (PCI) kullanılan diğer girişimsel cihazlarla uyumludur. Kılavuz tel ucunun distal kısmı radyopaktır.

Kayganlık için, cihazın distal kısmı hidrofilik bir polimerle kaplıdır ve kılavuz telin proksimal kısmı politetrafloroetilen (PTFE) ile kaplıdır. Cihazın 300 cm'den kısa olan proksimal ucunda, birleşik cihazı değiştirmek için kullanılan bir uzatma teli için bir bağlantı vardır; ASAHI INTECC'in Uzatma Teli bağlanabilirdir ve bağlantıdan sonra toplam uzunluk 355-400 cm'dir.



Kullanım Endikasyonları

Bu kılavuz tel, yaygın perkütan koroner girişimler (PCI) için tasarlanmıştır. Balon dilatasyon kateterlerini ve diğer girişimsel cihazları kardiyovasküler içine sokmak ve yerleştirmek için kullanılabilir.

Bu kılavuz tel nörovaskülatürde ve periferik vaskülatürde kullanım için tasarlanmamıştır.

Kontrendikasyonlar

- Gerçek kullanımdan önce kılavuz tel çapının diğer girişimsel cihazlarla uyumluluğunu onaylayın.
- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gösteren veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Bu kılavuz tel, hidrofilik kaplamasında PEG400 içerir. Polietilen glikole (PEG) karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kılavuz teli kullanmayın.

- Kılavuz teli hamile hastalar veya hamile olma ihtimali olan hastalar için kullanmayın (Röntgen fetüsü etkileyebilir).
- Bu kılavuz tel, acil cerrahi işlemlerin hemen gerçekleştirilebileceği bir tıbbi kurumda kullanılmalıdır. Bir acil cerrahi işlem yapılmazsa en kötü durumda yaşamı tehdit edici olaylar meydana gelebilir.

Uyarılar

- Bu kılavuz tel, yalnızca PCI tedavisi konusunda tam eğitilmiş bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Bu kılavuz teli asla bu kılavuz telin yüzeyine doğrudan temas edilecek metal parçalara sahip kateterler (ör. aterektomi kateterleri, metal dilatörler), metal iğneler veya metal kılıf yerleştiriciler ile birlikte kullanmayın.
- Kılavuz telin kullanımı sırasında ucunun hareketini floroskopi altında kontrol edin ve izleyin. Görselleştirilmemiş veya

- görselleştirilemeyen damar bölgelerinde kullanmayın.
- Bu kılavuz teli, ASAHI INTECC dışındaki üreticilerin ürettiği ayrılabılır uzatma telleriyle bağlamayın. Bu kılavuz teli, ayrılabılır uzatma teli bağliykten hareket ettirmeyin. Aksi halde kılavuz tel hasar görebilir veya ayrılabılır uzatma teli kazara çıkabilir.
- Bu kılavuz tel üzerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapmayın.

Kullanım Önemleri

- Bu kılavuz teli etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi geçmiş telleri atın.
- Kılavuz teller hassas aletlerdir ve dikkatle kullanılmalıdır.
- Ambalajı açılmış veya hasar görmüş kılavuz teli kullanmayın. Kullanımın hemen öncesine kadar ambalajı açmayın. Kılavuz teli taşırken ve kullanırken aseptik teknik kullanın.
- Hidrofilik kaplamanın zarar görmesini önlemek için kılavuz teli daima ıslak halde tutun.
- Bu kılavuz teli alkol gibi organik bir çözeltiyi kullanılarak silmeyin.
- Kullanım sonrası enfeksiyona karşı önleyici tedbirleri alın. Bu kılavuz teli ve ambalajını tıbbi atık olarak bertaraf edin.
- Bu kılavuz teli direnç hissedilebilecek şekilde hiçbir zaman itmeyin, bükmeyin, geri çekmeyin veya bastırmayın. Bu kılavuz telin dirence karşı torklanması veya itilmesi, bu kılavuz telin hasar görmesine ve/veya ucunun ayrılmasına veya bir kaba doğrudan zarar vermesine neden olabilir. Bunun yapılmaması bu kılavuz telin hasar görmesine neden olabilir. Direncin nedenini floroskopi altında belirleyin ve durumu düzeltmek için gereken önlemleri alın.
- Kılavuz telleri daima yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerletin veya çekin.
- Bu kılavuz tele kan damarının içinde tork uygularken torku sürekli aynı yönde uygulamayın. Bu kılavuz teli tork uygularken teli sırayla saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürün. Kılavuz teli aynı yönde ikiden fazla kez (720°) döndürmeyin.
- Kılavuz teli çıkarırken veya yeniden takarken girişimsel cihaza hava girmesini önlemek için kılavuz teli heparinize salın veya uygun başka solüsyonla yıkayın. Hava girmesini ve/veya travma oluşmasını önlemek için bu kılavuz teli dikkatle değiştirin. Kılavuz teli yeniden yerleştirirken girişimsel cihazın ucunun damar lümeninin içinde serbest olduğunu ve damar duvarına yaslanmadığını teyit edin. Bunun yapılmaması travmaya neden olabilir. Konumu doğrulamak için girişimsel cihazın radyopak işaretçiyi kullanın.
- Kılavuz telin girişimsel cihazın içerisinde serbest hareket etmesi, yönlendirilebilir bir kılavuz tel sisteminin önemli bir özelliğidir, çünkü bu, kullanıcıya değerli doküman bilgileri verir. Sistemi kullanmadan önce direnç olup olmadığını test edin. Kılavuz telin hareketini engellediği görülürsya hemostaz valfini ayarlayın veya ayarlanabilir bir valfle değiştirin.
- Birden fazla kılavuz tel kullanarak veya stent desteği aracıyla teli kullanarak stent

yerleştirmeyin. Aksi durumda stent hasar görebilir, kılavuz tel kopabilir veya kırılabilir.

- Kullanmadan önce, bu kılavuz telin boyut ve şekil olarak prosedür için uygun olduğunu ve birlikte kullanılabilecek cihazla uyumlu olduğunu onaylayın.
- Bu kılavuz tel ile birlikte kullanılacak tıbbi cihaza (ör. balon dilatasyon kateterleri veya diğer girişimsel cihazlar) ekli Kullanım Talimatlarına bakın.
- Ayrılabilir uzatma telini bu kılavuz tele bağlarken ayrılabilir uzatma teli PTFE olmayan kaplama ve kılavuz telin proksimal ucundaki PTFE kaplama arasındaki sınır çizgisine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bağlantıda herhangi bir anormallik tespit edilirse kılavuz teli kullanmayı derhal bırakın.

- Kullanmadan önce ve mümkün olduğu her durumda işlem sırasında kılavuz teli bükülmeler, kıvrılmalar ve başka hasarlar açısından dikkatle inceleyin. Kılavuz teli hasarlıysa kullanmayın.
- Ucu şekillendirirken bobine zarar vermeye dikkat edin.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce hangi ucun distal uç olduğunu kontrol edin ve distal uçtan yerleştirdiğinizden emin olun.
- İşlem sırasında kılavuz kateter ile girişimsel cihaz arasında ve girişimsel cihaz ile kılavuz tel arasında sürekli bir şekilde salın yıkama sağlayın. Yıkama, kılavuz tel üzerinde ve kateter lümeninde kontrast madde oluşumunu ve/veya pıhtılaşmayı önler.

Arızalar ve Advers Olaylar

Bu kılavuz tel kullanırken ortaya çıkabilecek arızalar ve advers olaylar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler bulunmaktadır:

1. Arızalar

Bir lezyonu geçememek	Kılavuz telin kırılması veya bükülmesi	Ayrılma gibi hasarlar
Çıkarma işleminde güçlük	Kaplamanın çıkması	

2. Advers olaylar

Ölüm	Enfeksiyon	Damar kesilmesi
Damar delinmesi	Kanama komplikasyonları	Emboli
Trombüs	Enfarktüs	İşkemi
Aritmi	Vazospazm	Damar tıkanıklığı
Kan basıncında azalma	Alerjik reaksiyon	Kalıntı

Kullanma Şekli

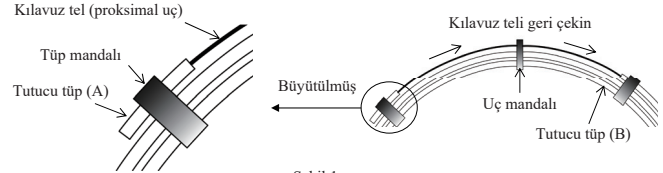
1. Kullanım öncesi denetim

- Kullanmadan önce, kılavuz telin ve ambalajının hasarsız olduğunu dikkatle inceleyin ve onaylayın.
- Kullanmadan önce, kılavuz telin kullanılacak girişimsel cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.

2. Hazırlık

- Etkilenen bölge için en uygun kılavuz teli seçin ve kılavuz teli içeren tutucu tüpü steril ambalajdan çıkarın.

- Tüm cihazı ıslatmak için bir şırınga kullanarak tutucu tüpü heparinize ve sterilize salinle doldurun. Bu sırada tutucu tüpten heparinize ve sterilize salin dökülebileceğini unutmayın.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce, girişimsel cihazın lümenini heparinize ve sterilize salinle doldurun.
- Kılavuz teli arkadaki mandaldan serbest bırakın ve kılavuz teli yavaşça kaydırarak kılavuz telin distal ucunu tutucu tüpten itin (B). (Şekil 1)



Şekil 1

- Kılavuz telin distal ucu, tutucu tüpün diğer ucundan 4 cm uzaklıktan daha uzadıysa, gerekiyorsa standart uygulamaya uygun şekilde ucu şekillendirin.
- Tutucu tüpün distal ucundan gelen kılavuz telini hafifçe kavrayın, tutucu tüpe mümkün olduğunca yakın bir noktada kılavuz teli yavaş ve dikkatli şekilde dışarı çekin.
- Kılavuz teli tutucu tüpten çıkarırken direnç hissederseniz, tutucu tüpe yeniden heparinize ve sterilize salin ekleyin. Direnç hissetmeyene kadar kılavuz teli çıkarmaya devam edin. Kaplamalı kılavuz tel kuvvetlice çıkarılırken hidrofilik kaplama hasar görebileceğinden, tutucu tüpe heparinize ve sterilize salin eklemeyi unutmayın.
- Kılavuz teli tutucu tüpten çekip çıkardıktan sonra, hasar görmediğinden emin olmak için kılavuz teli inceleyin.

3. Yerleştirme işlemleri

- Tel üzeri sistem
 - Kılavuz telin distal ucunu, girişimsel cihazın kılavuz tel lümeninin içine dikkatle yerleştirin.
 - Bu kılavuz teli, ucu girişimsel cihazın ucuna tam proksimal olana kadar dikkatle ilerletin.
 - Kılavuz kateter takın ve girişimsel cihaz sistemini (kılavuz teli birlikte) Y konektörüne yerleştirin.
 - Kılavuz tel sistemi kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar girişimsel cihaz sistemini kılavuz katetere yerleştirin.
 - Y konektörünün hemostaz valfini sıkarak, girişimsel cihazın etrafından bir mühür oluşmasını sağlayın. Kılavuz telin halen hareket edebildiğinden emin olun.
 - Kılavuz telin pürüzsüz bir şekilde hareket ettiğini kontrol edin.
 - Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.

- Bu kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.
- Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.
- Girişimsel cihazı, lezyona ulaşana kadar ilerletin ve bu sırada kılavuz telin hareket etmesini önleyin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

■ Hızlı değiştirme sistemi

- Kılavuz kateteri takın.
- Kılavuz tel yerleştiricisini kılavuz kateterin Y konektörüne yerleştirin.
- Kılavuz telin ucunu yerleştiricinin içine dikkatle yerleştirin.
- Kılavuz teli, kılavuz telin ucu kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar kılavuz katetere floroskopi altında ilerletin.
- Gerekirse tork cihazını kılavuz tele takın.
- Kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.
- Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.
- Kılavuz tel tork cihazını ve kılavuz tel yerleştiricisini çıkarın.
- Kılavuz telin hareket etmesini önleyerek, girişimsel cihazı kılavuz telin üzerinden izleyin ve lezyona ulaşana kadar ilerletin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

4. Kılavuz tel değiştirme işlemleri

■ Tel üzeri sistem

- a) Bu kılavuz telin hareketini floroskopi altında gözlemleyerek bu kılavuz teli

yavaşça çıkarın.

- b) Sonraki kılavuz teli, bu “Kullanma şekli” bölümündeki talimatlara göre yerleştirin.

Saklama biçimi

Kılavuz teli ve paketini bükülmüş ve/veya aşırı yüklü bir durumda muhafaza etmeyin. Bu kılavuz tel ve paket suyun dışında tutulmalıdır. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın.

Son Kullanma Tarihi

Son kullanma tarihi, kılavuz tel ambalajının etiketinde gösterilmiştir.

Paket İçeriği

5 adet/kutu

Yükümlülük Feragati

“ASAHI INTECC CO., LTD. ve bağlı şirketleri” (bundan böyle “şirket” olarak anılacaktır) ürünün/ ürünlerin hatalı kullanımından ve bu talimatlara uymayan her türlü kullanımdan doğan kaza, bedensel yaralanma ve ters etkilerde hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmez. Şirket, şu nedenlere bağlı olarak meydana gelen zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz: (i) Ürün veya ürünlerin şirket tarafından sevkıyatı tamamlandıktan sonraki saklama ve depolama koşullarına bağlı olarak meydana gelen zarar(lar) veya (ii) ürün veya ürünleri kullanan sağlık kuruluşunun hasta, cerrahi teknik ve diğer tıbbi cihazlara ilişkin seçimine bağlı olarak meydana gelen zarar(lar).

“ASAHI Gaia Next” ASAHİ INTECC CO., LTD.'nin Japonya'da ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

ASAHI Gaia Next

Проволочный проводник для ЧКВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием проволочного проводника внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по применению и придерживайтесь содержащихся в ней показаний к применению, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности, а также указаний в разделах процедуры применения. Несоблюдение этих требований может привести к осложнениям, включая серьезные травмы или смерть пациента.

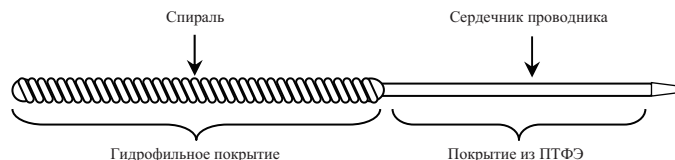
Если пользователю или пациенту стало известно о серьезном происшествии, связанном с данным проволочным проводником, следует сообщить об этом производителю и в уполномоченную организацию.

Данная инструкция по применению предназначена для ASAHI Gaia Next. Дополнительные сведения (длина проволочного проводника, рентгеноконтрастной части и т. д.) указаны на этикетке изделия.

Описание

Данный проволочный проводник представляет собой управляемый проводник с наконечником формируемого типа и имеется в наличии с наконечниками различной предварительно приданной формы. Наружный диаметр проволочного проводника равен 0,36 мм (0,014 дюймов). Этот проволочный проводник совместим с существующими баллонными дилатационными катетерами и другими интервенционными устройствами, используемыми при общем чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ). Дистальная часть наконечника проводника рентгеноконтрастна.

Для улучшения скольжения дистальная часть устройства покрыта гидрофильным полимером, а проксимальная часть проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ). На проксимальном конце устройства длиной менее 300 см имеется соединитель для удлинительного провода, который используется с целью замены комбинированного устройства. Можно подсоединить удлинитель ASAHI INTECC, при этом общая длина после подсоединения составляет 355-400 см.



Показания к применению

Данный проволочный проводник предназначен для общего чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Его можно использовать для введения и правильного расположения баллонных дилатационных катетеров и других интервенционных устройств в сердечно-сосудистой системе.

Данный проволочный проводник не предназначен для использования в нейрососудистой системе и периферической сосудистой сети.

Противопоказания

- Перед использованием проверьте соответствие диаметра проволочного проводника другому интервенционному устройству.
- Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергической реакцией на контрастное вещество или с нарушением функции почек.
- В гидрофильном покрытии данного проволочного проводника содержится ПЭГ400. Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергическими реакциями на полиэтиленгликоль (ПЭГ).
- Запрещается использовать проволочный проводник для беременных или пациенток, которые предположительно могут быть беременны (рентгеновское излучение может повлиять на плод).
- Данный проволочный проводник разрешается использовать только в тех учреждениях, где может быть выполнено неотложное хирургическое вмешательство. Если неотложное хирургическое вмешательство невозможно, то при самом худшем варианте развития событий могут возникнуть явления, представляющие угрозу жизни пациента.
- Проволочный проводник перед отгрузкой стерилизуется этиленоксидом и предназначен только для одноразового использования. Запрещается повторное использование или стерилизация. Повторное использование или стерилизация могут отрицательно влиять на эксплуатационные характеристики и качество проволочного проводника, что сопряжено с риском осложнений, в частности, инфекции.

Предупреждения

- Проволочный проводник должен использоваться только врачом, владеющим техникой выполнения ЧКВ.
- Запрещается использовать данный проволочный проводник в сочетании с катетерами, содержащими металлические детали, которые могут непосредственно соприкасаться с поверхностью проводника (например, катетеры для атерэктомии, металлические расширители), металлическими иглами или металлическими инструментами для введения интродьюсера.
- В процессе использования проволочного проводника проверяйте и контролируйте движение его наконечника посредством рентгенокопии. Запрещается применение в тех областях сосуда, которые не визуализированы или не могут быть визуализированы.
- Запрещается подсоединять к данному проволочному проводнику съемные удлинители проводника, изготовленные не компанией ASAHI INTECC. Запрещается производить манипуляции проволочным проводником с присоединенным съемным удлинителем проводника. В противном случае можно повредить проволочный проводник или случайно отделить съемный удлинитель проводника.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию проволочного проводника независимо от причин.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать проволочный проводник по истечении срока годности, указанного на этикетке. Если срок годности истек, утилизируйте проволочный проводник.
- В силу своей хрупкости проволочные проводники требуют осторожного обращения.
- Запрещается использовать проволочный проводник, если упаковка вскрыта или повреждена. Упаковку разрешается вскрывать только непосредственно перед использованием. При обращении с проволочным проводником и его использовании обязательно применение асептического способа.

- Чтобы не повредить гидрофильное покрытие проводника, постоянно держите его во влажном состоянии.
- Запрещается протирать провололочный проводник органическим раствором, например, спиртом.
- После использования примите профилактические меры во избежание инфицирования. Утилизируйте провололочный проводник и его упаковку в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
- Запрещается прилагать силу при проталкивании, ввинчивании, извлечении или вращении провололочного проводника, если ощущается сопротивление. Вращение или проталкивание провололочного проводника при наличии сопротивления может привести к повреждению и/или отделению наконечника провололочного проводника или непосредственному повреждению сосуда. Невыполнение этого требования может привести к повреждению провололочного проводника. Определите причину сопротивления с помощью рентгеноскопии и выполните соответствующие действия для исправления ситуации.
- Во всех случаях продвигайте или извлекайте провололочные проводники медленно и осторожно.
- Запрещается вращать провололочный проводник внутри кровеносного сосуда постоянно в одном направлении. При вращении провололочного проводника чередуйте повороты по часовой стрелке с поворотами против часовой стрелки. Запрещается делать более двух оборотов (720°) в одном направлении.
- В целях предотвращения попадания воздуха в интервенционное устройство промывайте провололочный проводник гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором или иным подходящим раствором при извлечении и повторном введении. При замене провололочного проводника проявляйте осторожность, чтобы не допустить попадания воздуха и/или нанесения травмы. При повторном введении провололочного проводника убедитесь, что наконечник интервенционного устройства свободно расположен в просвете сосуда и не упирается в его стенку. Невыполнение этого требования

может привести к травме. Для определения положения следите за рентгеноконтрастным маркером интервенционного устройства.

- Свободное движение провололочного проводника внутри интервенционного устройства является важной характеристикой системы управляемого провололочного проводника, дающей пользователю ценную осязательную информацию. Перед применением проверьте систему на наличие сопротивления. Если гемостатический клапан ограничивает движение провололочного проводника, то отрегулируйте его или замените на регулируемый клапан.
- Запрещается выполнять установку стента с помощью более чем одного провололочного проводника или перемещать провололочный проводник через каркас стента. В противном случае можно повредить стент, а также повредить или сломать провололочный проводник.
- Перед применением убедитесь, что размер и форма данного провололочного проводника соответствуют проводимой процедуре, а также устройству, в сочетании с которым он будет использоваться.
- Ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к медицинскому устройству (например, к баллонным дилатационным катетерам или другим интервенционным устройствам), которое должно использоваться в сочетании с данным провололочным проводником.
- При подсоединении съемного удлинителя к провололочному проводнику следует надежно вставить его до граничной линии между покрытием не из ПТФЭ и покрытием из ПТФЭ на проксимальном конце провололочного проводника. Немедленно прекратите использование провололочного проводника при обнаружении каких-либо неисправностей в соединении.
- Перед использованием и по мере возможности во время проведения процедуры внимательно осматривайте провололочный проводник на предмет изгибов, перекручивания или иных повреждений. Запрещается использовать поврежденный провололочный проводник.
- Во время придания формы наконечнику будьте осторожны, чтобы не повредить спираль.

- Перед введением провололочного проводника проверьте, какой конец является дистальным и удостоверьтесь, что устройство вводится именно дистальным концом.
- При выполнении процедуры обеспечивайте постоянную промывку физиологическим раствором участка между проводниковым

катетером и интервенционным устройством, а также между интервенционным устройством и провололочным проводником. Промывка позволяет предотвратить образование и/или коагуляцию контрастного вещества на проводнике и в просвете катетера.

Неправильное функционирование и неблагоприятные явления

К возможным случаям неправильного функционирования и неблагоприятных явлений для данного провололочного проводника относятся, в частности, следующие:

1. Неправильное функционирование

Невозможность пройти участок поражения	Повреждение или изгиб провололочного проводника	Повреждение, как например, отделение
Затруднение при извлечении	Отслоение покрытия	

2. Неблагоприятные явления

Смерть	Инфекция	Рассечение сосуда
Перфорация сосуда	Геморрагические осложнения	Эмболия
Тромб	Образование инфаркта	Ишемия
Аритмия	Спазм сосудов	Окклюзия сосудов
Снижение кровяного давления	Аллергическая реакция	Остаточные явления

Процедура применения

1. Осмотр перед использованием

- Перед использованием внимательно осмотрите и проверьте провололочный проводник и упаковку на предмет повреждений.
- Перед использованием убедитесь, что провололочный проводник совместим с используемым интервенционным устройством.

2. Подготовка

- Выберите провололочный проводник, наиболее подходящий для пораженного участка, и извлеките из стерильной упаковки трубку-держатель, в которой находится провололочный проводник.
- С помощью шприца полностью заполните трубку-держатель гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором для промывки всего устройства. Имейте в

виду, что во время этой процедуры гепаринизированный и стерильный физиологический раствор может выливаться из трубки-держателя.

- Перед введением провололочного проводника заполните просвет интервенционного устройства гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором.
- Извлеките провололочный проводник из зажима, затем медленно и плавно перемещайте провололочный проводник, проталкивая дистальный конец провололочного проводника через трубку-держатель (В) (рис. 1).

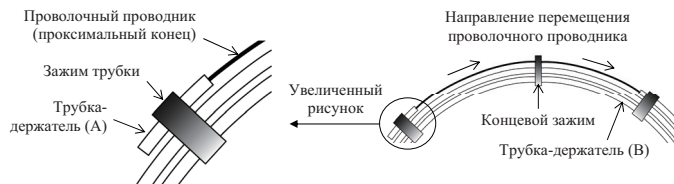


Рис. 1

- е) Когда дистальный конец проволочного проводника выступит более чем на 4 см за другой конец трубки-держателя, при необходимости придайте наконечнику форму в соответствии со стандартным методом.
- ф) Осторожно захватите проволочный проводник, который выступил из дистального конца трубки-держателя как можно ближе к трубе-держателю и вытяните проволочный проводник медленно и осторожно.
- г) Если при извлечении проволочного проводника из трубки-держателя чувствуется сопротивление, снова шприцом введите гепаринизированный и стерильный физиологический раствор в трубку-держатель. Продолжайте извлечение проволочного проводника, только если не будете чувствовать сопротивления при его перемещении. Убедитесь, что впрыскиваете в трубку-держатель достаточное количество гепаринизированного и стерильного физиологического раствора, поскольку при извлечении проволочного проводника с усилием его гидрофильное покрытие может быть повреждено.
- h) После извлечения проволочного проводника из трубки-держателя осмотрите его на предмет повреждений.

3. Процедуры введения

- Система доставки по проводнику
 - а) Осторожно вставьте дистальный конец проволочного проводника в просвет для проволочного проводника в интервенционном устройстве.
 - б) Осторожно продвигайте проволочный проводник, пока его наконечник не

- окажется проксимальным к концу интервенционного устройства.
- с) Присоедините проводниковый катетер и вставьте систему интервенционного устройства (с проволочным проводником) в Y-образный соединитель.
- д) Продвигайте систему интервенционного устройства через проводниковый катетер, пока наконечник системы проволочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- е) Затяните гемостатический клапан Y-образного соединителя, чтобы создать герметичную среду вокруг интервенционного устройства. Убедитесь, что проволочный проводник все еще можно перемещать.
- ф) Убедитесь, что проволочный проводник движется плавно.
- г) По мере необходимости присоедините к проволочному проводнику устройство для вращения.
- h) Под контролем рентгенографии продвигайте проволочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- и) Следите за продвижением проволочного проводника в сосудах.
- j) Продвигайте интервенционное устройство до участка поражения, предотвращая движение проволочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволочного проводника и его положение в сосуде.

■ Система быстрой замены

- а) Присоедините проводниковый катетер.
- б) Вставьте интродьюсер проволочного проводника в Y-образный соединитель проводникового катетера.
- с) Осторожно вставьте наконечник проволочного проводника в интродьюсер.
- д) Под контролем рентгенографии продвигайте проволочный проводник через проводниковый катетер, пока наконечник проволочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- е) По мере необходимости присоедините к проволочному проводнику устройство для вращения.
- ф) Под контролем рентгенографии продвигайте проволочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.

- г) Следите за продвижением проволочного проводника в сосудах.
- h) Извлеките устройство для вращения и интродьюсер проволочного проводника.
- и) Продвигайте интервенционное устройство по проволочному проводнику до участка поражения, предотвращая движение проволочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволочного проводника и его положение в сосуде.

4. Процедура замены проволочного проводника

- Система доставки по проводнику
 - а) Медленно извлеките проволочный проводник, контролируя его перемещение с помощью рентгенографии.
 - б) Согласно указаниям раздела «Процедура применения» вставьте следующий проволочный проводник.

Условия хранения

Запрещается хранить проволочный проводник и его упаковку в изогнутом виде и/или подвергать их избыточной нагрузке. Запрещается хранить данный проволочный проводник и его упаковку вблизи воды. Храните их в прохладном, сухом и темном месте.

Срок годности

Срок годности изделия указан на этикетке на упаковке проволочного проводника.

Содержимое упаковки

5 шт. / коробка

Отказ от ответственности

Компания ASAH INTECC CO., LTD и ее дочерние компании (в дальнейшем вместе именуемые «Компания») никоим образом не несет ответственности за несчастные случаи, травмирование персонала и неблагоприятные явления, произошедшие вследствие неправильного использования изделия (изделий) или любого другого действия с нарушением требований этой инструкции. Компания ни при каких условиях не несет ответственность за какие-либо повреждения, (i) возникшие в результате хранения данного изделия (изделий) после доставки его Компанией или (ii) в связи с выбором медицинским учреждением, использующим данное изделие (изделия), определенных пациентов, методик операций или каких-либо других медицинских действий.

«ASAHI Gaia Next» является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком ASAH INTECC CO.,LTD в Японии и других странах.

ASAHI Gaia Next Водач за PCI

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този водач и спазвайте разделите Показания за употреба, Противопоказания, Предупреждения, Предпазни мерки и Как да използвате в тези Инструкции за употреба. Непазването на тези инструкции може да доведе до усложнения, включително сериозно нараняване на пациента или смърт.

Ако даден потребител или пациент разбере за сериозен инцидент, възникнал във връзка с водача, той следва да докладва този факт на производителя и компетентния орган.

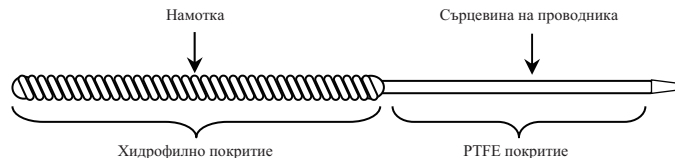
Тези инструкции за употреба се отнасят за ASAHI Gaia Next. За подробности (дължина на водача, дължина на рентгеноконтрастната част и т.н.) направете справка с етикета на продукта.

Описания

Този водач представлява управляем водач с оформящ се връх и се предлага в предварително оформени варианти. Външният диаметър на водача е 0,36 мм (0,014 инча). Този водач е съвместим със съществуващите катетри за балонна дилатация и други интервенционни устройства, използвани при обща перкутанна коронарна интервенция (PCI). Дисталната част на върха на водача е рентгеноконтрастна.

С цел смазване, дисталната част на изделието е покрита с хидрофилен полимер, а проксималната част на водача е покрита с политетрафлуоретилен (PTFE).

В проксималния край на изделието, който е под 300 см, има връзка за удължител, който се използва за заместване на комбинираното изделие; Удължителят на ASAHI INTECC може да бъде свързан, като общата дължина след свързване е 355-400 см.



Инструкции за употреба

Този водач е предназначен за обща перкутанна коронарна интервенция (PCI). Може да се използва за въвеждане и позициониране на балонни дилатационни катетри и други интервенционни устройства в сърдечно-съдовата система.

Този водач не е предназначен за използване в невроваскулатурата и периферната васкулатура.

Противопоказания

- Потвърдете съвместимостта на диаметъра на водача с друго интервенционно устройство преди реална употреба.
- Не използвайте водача при пациенти, които имат алергична реакция към контрастни вещества или които имат нарушена бъбречна функция.

- Този водач съдържа PEG400 в своето хидрофилно покритие. Не използвайте водача при пациенти, които имат алергични реакции към полиетилен гликол (PEG).
- Не използвайте водача при бременни пациентки или пациентки, които може да са бременни (рентгеновите лъчи могат да засегнат плода).
- Този водач трябва да се използва в здравно заведение, където може незабавно да бъде извършена спешна хирургична операция. Ако не е възможна спешна хирургична операция, в

най-лошия случай може да настъпят животозастрашаващи събития.

- Този водач е подложен на предварителна газова стерилизация с етилен оксид (EOG) и е предназначен само за еднократна употреба. Не използвайте повторно или не стерилизирайте повторно. Ако се използва или стерилизира повторно, работата или качеството на този водач могат да бъдат компрометирани и съществува риск от усложнения, включително инфекция.

Предупреждения

- Този водач трябва да се използва само от лекар, който е напълно обучен за лечение чрез PCI.
- Никога не използвайте този водач в комбинация с катетри, които имат метални части, които могат да влязат в директен контакт с повърхността на този водач (напр. катетри за атеректомия, метални дилатори), метални игли или изделия за поставяне на метални обвивки.
- По време на използване на водача проверявайте и наблюдавайте движението на

върха му под флуороскопия. Не използвайте в тези части на съда, които не са или не могат да бъдат визуализирани.

- Не свързвайте този водач с подвижни удължители от производители, различни от ASAHI INTECC. Не манипулирайте този водач, докато подвижният удължител е свързан. В противен случай водачът може да се повреди или подвижният удължител може неволно да се откачи.
- Не модифицирайте този водач по каквато и да е причина.

Предпазни мерки

- Не използвайте водача след изтичане на срока на годност, посочен на етикета. Изхвърлете всеки водач с изтекъл срок на годност.
- Водачите са деликатни инструменти и с тях трябва да се работи внимателно.
- Ако опаковката е отворена или повредена, не използвайте водача. Отворете опаковката точно преди непосредствена употреба. Използвайте асептична техника при боравене и използване на водача.
- Винаги дръжте водача в мокро състояние, за да предотвратите повреда на хидрофилното му покритие.
- Не бършете този водач с органичен разтвор като спирт.
- Вземете превантивни мерки срещу инфекция след употреба. Изхвърлете този водач и опаковката като медицински отпадък.
- Никога не натискайте, не използвайте като свредло, не изтегляйте или не затягвайте водач, който среща съпротивление. Затягането или натискането на този водач срещу съпротивление може да причини

повреда и/или отделияне на върха на водача, или директно увреждане на съда. Неспазването на това предупреждение може да причини повреда на този водач. Определете причината за резистентност под флуороскопия и извършете всички необходими коригиращи действия.

- Винаги придвижвайте напред или изтегляйте водачите бавно и внимателно.
- Когато затягате този водач вътре в кръвоносния съд, не затягвайте непрекъснато в една и съща посока. Когато затягате водача, завъртете го последователно по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. Не правете повече от две завъртания (720°) в една и съща посока.
- Промийте водача с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор или друг подходящ разтвор, докато го изваждате и поставяте отново, за да предотвратите навлизането на въздух в интервенционното устройство. Извършете внимателно смяната на този водач, за да предотвратите навлизане

на въздух и/или нараняване. При повторно въвеждане на водача се уверете, че върхът на интервенционалното устройство е свободен в лумена на съда и не е срещу стената на съда. Ако не го направите, това може да доведе до травма. Използвайте рентгеноконтрастния маркер на интервенционалното устройство, за да потвърдите позицията.

- Свободното движение на водача в рамките на интервенционалното устройство е важна характеристика на системата с управляем водач, тъй като дава на потребителя ценна тактична информация. Тествайте системата за устойчивост преди употреба. Регулирайте или сменете хемостазната клапа с регулируема клапа, ако се установи, че възпрепятства движението на водача.
- Не извършвайте поставяне на стент, като използвате повече от един водач или операция с водач през опора на стент. В противен случай стентът може да се повреди или водачът да се счупи или да се разпадне.
- Преди употреба се уверете, че този водач е подходящ по размер и форма за процедурата и е съвместим с изделието, което ще използвате в комбинация.
- Обърнете се към Инструкцията за употреба, приложена към медицинското изделие (напр.

катетри за балонна дилатация или други интервенционални устройства), което ще се използва в комбинация с този водач.

- Когато свързвате подвижния удължител с този водач, той трябва да бъде здраво поставен в граничната линия между покритието без PTFE и покритието с PTFE в проксималния край на водача. Ако се открие някаква неизправност във връзката, незабавно спрете да използвате водача.
- Проверете внимателно водача за огъвания, прегъвания или други повреди преди употреба и когато е възможно по време на процедурата. Не използвайте водача, ако е повреден.
- Когато оформяте върха, внимавайте да не повредите намотката.
- Преди да въведете водача, проверете кой край е дисталният край и се уверете, че сте го поставили от дисталния край.
- Поддържайте непрекъснато промиване с физиологичен разтвор между водещия катетър и интервенционалното устройство и водача по време на процедурата. Промиването предотвратява образуването на контрастна материя и/или съсирването върху водача и в лумена на катетъра.

Неизправности и нежелани ефекти

Възможните неизправности и нежелани ефекти при използването на този водач включват, но не се ограничават до следното:

1. Неизправности

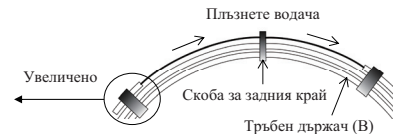
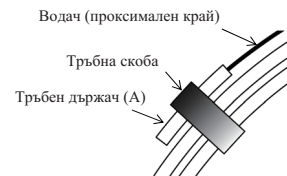
Неуспех при преминаване на лезия	Счупване или огъване на водача	Повреда като отделяне
Трудности при отстраняването	Отлепване от покритието	

2. Нежелани ефекти

Смърт	Инфекция	Дисекция на съда
Перфорация на съда	Усложнения, свързани с кървене	Емболия
Тромб	Инфаркт	Исхемия
Аритмия	Вазоспазъм	Съдова оклузия
Спадане на кръвното налягане	Алергична реакция	Остатъчни

Как да използвате

- Проверка преди употреба
 - Преди употреба проверете внимателно и се уверете, че водачът и опаковката не са повредени.
 - Преди употреба потвърдете, че водачът е съвместим с интервенционалните устройства, които ще използвате.
- Подготовка
 - Изберете най-подходящия водач за засегнатата област и извадете тръбния държач, съдържащ водача, от стерилната опаковка.
 - Напълнете тръбния държач с хепаринизиран и стерилизиран



Фигура 1

- Когато дисталният край на водача е удължен на повече от 4 см извън другия край на тръбния държач, ако е необходимо, оформете върха в съответствие със стандартната практика.
- Внимателно хванете водача, който е излязъл от дисталния край на тръбния държач в точката, която е възможно най-близо до тръбния държач, и издърпайте водача бавно и внимателно.
- Ако почувствате съпротивление при отстраняване на водача от тръбния държач, инжектирайте отново хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач. Продължете да отстранявате водача, след като съпротивлението вече не се усеща. Уверете се, че сте инжектирали достатъчно хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач, тъй като хидрофилното покритие може да се повреди при силно отстраняване на водача с покритие.
- След като издърпате водача от тръбния държач, проверете го, за да се уверите, че не е повреден.

3. Процедури по въвеждане

- Система над проводника
 - Вкарайте дисталния край на водача внимателно в лумена на водача на интервенционалното устройство.
 - Внимателно придвижете напред този водач, докато върхът му е точно проксимално до върха на интервенционалното устройство.
 - Захванете водещия катетър и поставете системата за интервенционалното устройство (с водач) в Y-образния конектор.
 - Придвигнете напред системата на интервенционалното устройство през водещия катетър, докато върхът на системата на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
 - Затегнете хемостазната клапа на Y-

образния конектор, за да създадете уплътнение около интервенционното устройство. Уверете се, че движението на водача все още е допустимо.

- f) Проверете дали водачът се движи гладко.
- g) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- h) Придвигнете напред този водач под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- i) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- j) Придвигнете напред интервенционалното устройство, докато се достигне лезията, като същевременно предотвратявате движението на водача. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

■ Система за бърз обмен

- a) Включете водещия катетър.
- b) Поставете интродюсера на водача в Y-образния конектор на водещия катетър.
- c) Внимателно поставете върха на водача в интродюсера.
- d) Придвигнете напред водача през водещия катетър под флуороскопия, докато върхът

на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.

- e) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- f) Придвигнете напред водача под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- g) Наблюдавайте движението на водача в съдовете.
- h) Отстранете устройството за затягане на водача и интродюсера на водача.
- i) Проследете интервенционалното устройство през водача, като същевременно предотвратявате движението на водача, и придвигнете напред, докато се достигне лезията. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

„ASAHI Gaia Next“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на ASAHI INTECC CO., LTD. в Япония и други страни.

4. Процедури по смяна на водача

■ Система над проводника

- a) Отстранете този водач бавно, докато наблюдавате движението му под флуороскопия.
- b) Поставете следващия водач в съответствие с указанията в този раздел „Как да използвате“.

Начин на съхранение

Не дръжте водача и опаковката в огънато положение и/или в състояние под тежко натоварване. Този водач и опаковката трябва да се пазят от вода. Съхранявайте на хладно, тъмно и сухо място.

Срок на годност

Срокът на годност е посочен на етикета на опаковката на водача.

Съдържание

5 броя / кутия

Отказ от отговорност

По никакъв начин „ASAHI INTECC CO., LTD. и неговите дъщерни дружества“ (наричани по-нататък „Компанията“) не носят отговорност за злоупотреби, лични наранявания, нежелани ефекти, дължащи се на неправилна употреба на продукта(ите) или всяка друга употреба, несъвместима с тези инструкции. В никакъв случай Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети или (i) произтичащи от съхранението на продукта(ите) след изпращането от Компанията, или (ii) поради подбор на пациенти, хирургични техники или всякакви други медицински дейности от лечебното заведение, което използва продукта(ите).

ASAHI Gaia Next PCI vodilica

Upute za uporabu

Prije uporabe ove vodilice pažljivo pročitajte i pridržavajte se odjeljaka Indikacije za uporabu, Kontraindikacije, Upozorenja, Mjere opreza i Kako se koristi u ovim Uputama za uporabu. Ako ih ne budete pridržavali, može doći do komplikacija, uključujući ozbiljne ozljede pacijenta ili smrtnog ishoda.

Ako korisnik ili pacijent dođe do saznanja o ozbiljnoj nezgodi koja se javila vezano s ovom vodilicom, prijavite tu činjenicu proizvođaču i nadležnom tijelu.

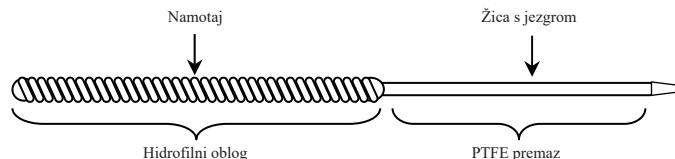
Ovo Upute za uporabu primjenjuju se na ASAHI Gaia Next. Za pojednosti (duljina vodilice, duljina radionepropusnog dijela, itd.), pročitajte etiketu proizvoda.

Opis

Ova vodilica je vrsta kojom se može se upravljati, s vrhom koji se može oblikovati i dostupna je u unaprijed oblikovanim varijantama. Vanjski promjer žice je 0,36 mm (0,014 inča). Ova žica za navođenje kompatibilna je s postojećim balon dilatacijskim kateterima i drugim intervencijskim uređajima koji se koriste u uobičajenoj perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI). Distalni dio vrha vodilice je radionepropusan.

Radi klizavosti, distalni dio uređaja obložen je hidrofilnim polimerom, a proksimalni dio vodilice obložen je politetrafluoretilenom (PTFE).

Na proksimalnom kraju uređaja, koji je manji od 300 cm, nalazi se priključak za produžnu žicu, koja služi za zamjenu kombiniranog uređaja; moguće je spojiti produžnu žicu tvrtke ASAHI INTECC, a ukupna duljina nakon spajanja je 355–400 cm.



Indikacije za uporabu

Ova je vodilica namijenjena za opću perkutanu koronarnu intervenciju (PCI). Može se koristiti za uvođenje i pozicioniranje balon dilatacijskim kateterima i drugim intervencijskim uređajima u kardiovaskularnom sustavu.

Ova vodilica nije namijenjena za uporabu u neurovaskularnom i perifernom vaskularnom sustavu.

Kontraindikacije

- Potvrdite kompatibilnost promjera vodilice s drugim intervencijskim uređajem prije konkretne uporabe.
- Nemojte koristiti vodilicu na pacijentima koji imaju alergijsku reakciju na kontrastne medije ili koji imaju poremećenu funkciju bubrega.

- Ova vodilica sadrži PEG400 u svojoj hidrofilnoj oblozi. Nemojte koristiti vodilicu na pacijentima koji imaju alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Nemojte koristiti vodilicu na trudnicama ili pacijenticama koje bi mogle biti trudne (rendgenske zrake mogu utjecati na fetus).
- Ova se vodilica mora se koristiti u ustanovi gdje se hitna kirurška operacija može obaviti odmah. Ako hitna kirurška operacija nije dostupna, u

najgorem slučaju može doći do događaja opasnih po život.

- Ova vodilica prethodno je sterilizirana plinom etilen oksid (EOG) i namijenjena je samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno koristiti ili ponovno sterilizirati. Ako se ponovno koristi ili ponovno sterilizira, učinkovitost ili kvaliteta ove vodilice može biti narušena i postoji rizik od komplikacija, uključujući infekciju.

Upozorenja

- Ovu vodilicu smije koristiti samo liječnik koji je prošao kompletnu obuku za PCI tretman.
- Nikada ne koristite ovu vodilicu u kombinaciji s kateterima s metalnim dijelovima koji mogu doći u izravan kontakt s površinom ove vodilice (npr. kateteri za aterektomiju, metalni dilatatori), metalnim iglama ili metalnim uvodnim ovojnicama.
- Za vrijeme korištenja vodilice, provjeravajte i pratite kretanje njenog vrha pod fluoroskopijom.

- Nemojte koristiti u područjima žila koje nisu ili se ne mogu vizualizirati.
- Nemojte spajati vodilicu s odvojivim produžnim žicama, a koje je proizveo neki drugi proizvođač a ne ASAHI INTECC. Nemojte rukovati vodilicom dok je spojena odvojiva produžna žica. U suprotnom, vodilica se može oštetiti ili bi se odvojiva produžna žica mogla nenamjerno odvojiti.
- Ni iz kakvog razloga ne smijete obavljati preinake ove vodilice.

Mjere opreza

- Nemojte koristiti vodilicu nakon isteka roka označenog na etiketi. Odbacite svaku vodilicu kojoj je istekao rok trajanja.
- Vodilice su osjetljivi instrumenti i njima se mora rukovati pažljivo.
- Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, nemojte koristiti vodilicu. Pakiranje otvorite isključivo neposredno prije uporabe. Pri rukovanju i korištenju vodilice koristite aseptičnu tehniku.
- Vodilica uvijek mora biti vlažna kako bi se spriječilo oštećenje njenog hidrofilnog obloga.
- Ne brišite vodilicu organskim rastvorima kao što je alkohol.
- Nakon uporabe poduzmite preventivne mjere protiv infekcije. Zbrinite vodilicu i pakiranje kao medicinski otpad.
- Nikada nemojte gurati, bušiti, povlačiti ili zatezati vodilicu koja nailazi na otpor. Zatezanje ili guranje vodilice protiv otpora može uzrokovati oštećenje i/ili odvajanje vrha vodilice ili izravnu štetu na žili. Ako se ne pridržavate ovih savjeta, može doći do oštećenja vodilice.
- Pod fluoroskopijom utvrdite uzrok otpora i poduzmite potrebne mjere za uklanjanje.
- Vodilice uvijek uvodite ili povlačite polako i pažljivo.

- Pri zakretanju vodilice unutar krvne žile, nemojte zakretati stalno u istom smjeru. Pri zakretanju vodilice, okrećite je naizmjenično u smjeru kazaljke i suprotno od smjera kazaljke na satu. Nemojte okretati više od dva okreta (720°) u istom pravcu.
- Vodilicu isperite hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom ili drugom prikladnom otopinom dok je uklanjate i ponovno uvodite, kako biste spriječili ulazak zraka u intervencijski uređaj. Pažljivo obavite zamjenu vodilice kako biste spriječili ulazak zraka i/ili ozljedu. Prilikom ponovnog uvođenja vodilice, uvjerite se da je vrh intervencijskog uređaja slobodan unutar lumena krvne žile i da nije prislonjen na stijenku žile. Ako ne postupite tako, moglo bi doći do ozljede. Za potvrdu položaja, koristite radionepropusni marker intervencijskog uređaja.
- Slobodno kretanje vodilice unutar intervencijskog uređaja važna je značajka upravljivog sustava žice za navođenje jer korisniku daje vrijedne taktile informacije. Prije korištenja ispitajte nailazi li sustav na bilo kakav otpor. Podestite ili zamijenite ventil za hemostazu podesivim ventilom ako se ustanovi da onemogućuje kretanje vodilice.

- Nemojte postavljati stent korištenjem više od jedne vodilice ili operaciji žice kroz mrežicu stenta. U suprotnom, stent se može oštetiti ili se vodilica može slomiti ili se raspasti.
- Prije uporabe, potvrdite da je vodilica odgovarajuće veličine i oblika za taj postupak i da je kompatibilna s uređajem s kojim će se koristiti.
- Pročitajte Upute za uporabu priložene uz medicinski uređaj (npr. balon dilatirajući kateteri ili drugi intervencijski uređaji) koji će se koristiti u kombinaciji s ovom vodilicom.
- Prilikom spajanja odvojive produžne žice s ovom vodilicom, treba je sigurno umetnuti u graničnu liniju između premaza koji nije PTFE i PTFE premaza na proksimalnom kraju vodilice. Ako se u spoju otkrije abnormalnost, odmah prestanite koristiti vodilicu.
- Prije korištenja i kad god je to moguće tijekom postupka, pažljivo pregledajte ima li vodilica savijena, usukana ili ima neko drugo oštećenje. Nemojte koristiti vodilicu ako je oštećena.
- Prilikom oblikovanja vrha, pazite da ne oštetite namotaj.
- Prije uvođenja vodilice, provjerite koji kraj je distalni kraj i osigurajte da ćete uvesti sa distalnog kraja.
- Održavajte kontinuirano ispiranje fiziološkom otopinom između katetera za navođenje i intervencijskog uređaja te između intervencijskog uređaja i vodilice tijekom postupka. Ispiranje sprječava stvaranje kontrastnog sredstva i/ili zgrušavanje na vodilici i u lumen katetera.

Nepravilno funkcioniranje i štetni učinci

Moguće neispravno funkcioniranje i štetni učinci zbog korištenja vodilice uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

1. Neispravno funkcioniranje

Nije prođeno kroz leziju	Prijelom ili savijanje vodilice	Oštećenje poput odvajanja
Poteškoće pri uklanjanju	Spadanje obloga	

2. Štetni učinci

Smrt	Infekcija	Disekcija žile
Perforacija žile	Komplikacije krvarenja	Embolija
Tromb	Infarkcija	Ishemija
Aritmija	Vazospazam	Vaskularna okluzija
Snižavanje krvnog tlaka	Alergijska reakcija	Ostatne tvari

Kako se koristi

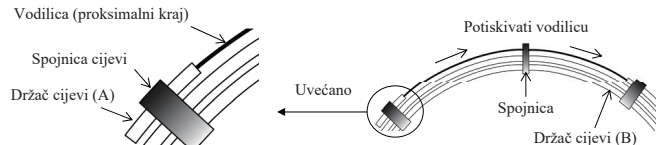
1. Pregled prije uporabe

- Prije uporabe, pažljivo pregledajte i potvrdite da su vodilica i pakiranje neoštećeni.
- Prije uporabe, potvrdite da je vodilica kompatibilna s intervencijskim uređajima koji će se koristiti.

2. Priprema

- Izaberite najprikladniju vodilicu za zahvaćeno područje i uklonite držač cijevi u kojem je vodilica iz sterilnog pakiranja.
- Napunite držač cijevi hepariniziranom i

- steriliziranom fiziološkom otopinom pomoću štrcaljke kako biste natopili cijeli uređaj. Napominjemo da se heparinizirana i sterilizirana fiziološka otopina za to vrijeme može izliti iz držača cijevi.
- Napunite lumen intervencijskog uređaja hepariniziranom i steriliziranom fiziološkom otopinom prije umetanja vodilice.
- Otpustite vodilicu iz spojnice i lagano potiskujte vodilicu, gurmite distalni kraj vodilice kroz držač cijevi (B). (Slika 1)



Slika 1

- Kada se distalni kraj vodilice produži više od 4 cm izvan drugog kraja držača cijevi, po potrebi oblikujte vrh u skladu sa standardnom praksom.
- Nježno uhvatite vodilicu koja je izašla iz distalnog kraja držača cijevi, na mjestu što je moguće bliže držaču cijevi i polako i pažljivo izvlačite vodilicu.
- Ako osjetite otpor pri vađenju vodilice iz držača cijevi, ponovo ubrizgajte hepariniziranu i steriliziranu fiziološku otopinu u držač cijevi. Nastavite s vađenjem vodilice kada prestanete osjećati otpor. Obavezno ubrizgajte dovoljno heparinizirane i sterilizirane fiziološke otopine u držač cijevi jer se hidrofilni oblog može oštetiti prilikom nasilnog vađenja obloženice.
- Nakon povlačenja vodilice iz držača cijevi, pregledajte ju kako biste se uvjerali da nije oštećena.

3. Postupci za uvođenje

- Sustav preko žice
 - Pažljivo umetnite distalni kraj vodilice u lumen vodilice intervencijskog uređaja.
 - Pažljivo uvođite vodilicu sve dok vrh ne bude proksimalan u odnosu na vrh intervencijskog uređaja.
 - Zahvatite vodeći kateter i umetnite sustav intervencijskog uređaja (s vodilicom) u priključak Y.
 - Uvođite sustav intervencijskog uređaja kroz vodeći kateter sve dok vrh sustava vodilice ne bude proksimalan u odnosu na vrh vodećeg katetera.
 - Zategnite ventil za hemostazu priključka Y kako biste stvorili brtvu oko intervencijskog uređaja. Osigurajte da je pomicanje vodilice i dalje dopušteno.
 - Provjerite kako biste osigurali glatko

pomicanje vodilice.

- Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- Uvođite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- Uvođite intervencijski uređaj dok ne dođe do lezije, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

■ Sustav brze zamjene

- Zahvatite vodeći kateter.
- Umetnite uvodnicu vodilice u priključak Y vodećeg katetera.
- Pažljivo umetnite vrh vodilice u uvodnicu.
- Uvođite vodilicu kroz vodeći kateter pod fluoroskopijom dok vrh vodilice ne bude proksimalan vrhu vodećeg katetera.
- Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- Uvođite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- Uklonite uređaj za zakretni moment vodilice i uvodnicu vodilice.
- Pratite intervencijski uređaj preko vodilice, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice i uvođite dok ne dođe do lezije. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

4. Postupci zamjene vodilice

■ Sustav preko žice

a) Lagano vadite vodicu dok nadzirete
pomicanje ove vodilice pod fluoroskopijom.

b) Umetnite sljedeću vodicu prema uputama
iz dijela „Kako se koristi”.

Način skladištenja

Ne smijete čuvati vodicu i pakiranje u savijenom i/ili pod teškim teretom. Vodicica i pakiranje moraju se čuvati dalje od vode. Čuvati na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Rok trajanja

Rok trajanja označen je na etiketi pakiranja vodilice.

Sadržaj

5 komada / kutija

Odricanje od odgovornosti

Ni u kojem slučaju „ASAHI INTECC CO., LTD. i njegove pridružene tvrtke” (u daljnjem tekstu „Tvrtka”) biti odgovorni za nezgode, osobne ozljede, štetne učinke uslijed bilo kakve nepravilne uporabe proizvoda ili bilo koje druge uporabe koja nije u skladu s ovim uputama. Ni u kojem slučaju Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (i) koja proizlazi iz skladištenja proizvoda nakon otpreme iz Tvrtke ili (ii) zbog odabira pacijenata, kirurških tehnika ili bilo koje druge medicinske aktivnosti od strane medicinske ustanove koja koristi proizvod(e).

„ASAHI Gaia Next” je zaštitni znak ili registrirani zaštitnik znak ASAHI INTECC CO.,LTD. u Japanu i drugim zemljama.

ASAHI Gaia Next

Fir de ghidaj pentru intervenția coronariană percutanată (PCI)

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest fir de ghidaj și respectați secțiunile Indicații pentru utilizare, Contraindicații, Avertismente, Precauții și Modul de utilizare din aceste Instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la complicații, inclusiv la lezarea gravă a pacientului sau la deces.

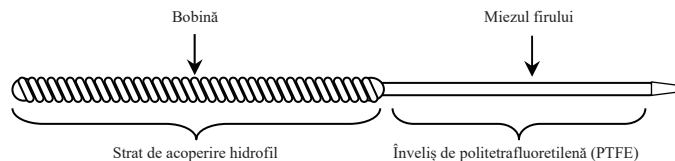
În cazul în care un utilizator sau un pacient ia la cunoștință de un incident grav care a avut legătură cu firul de ghidaj, raportați acest lucru producătorului și autorității competente.

Aceste Instrucțiuni de utilizare se aplică la ASAHI Gaia Next. Pentru detalii (lungimea firului de ghidaj, lungimea secțiunii radioopace etc.), a se consulta eticheta produsului.

Descrieri

Acest fir de ghidaj este un fir de ghidaj manevrabil, cu un vârf modelabil și este disponibil în versiuni preformate. Diametrul exterior al firului de ghidaj este de 0,36 mm (0,014 inci). Acest fir de ghidaj este compatibil cu cateterele existente de dilatare cu balon și cu alte dispozitive intervenționale utilizate în intervențiile coronariene percutanate (PCI) obișnuite. Partea distală a vârfului firului de ghidaj este radioopacă.

Pentru lubrifiere, partea distală a dispozitivului este acoperită cu un strat de polimer hidrofili, iar partea proximală a firului de ghidaj este acoperită cu politetrafluoretilenă (PTFE). La capătul proximal al dispozitivului, care este mai mic de 300 cm, există o legătură pentru un fir de extindere, care este utilizat pentru a înlocui dispozitivul combinat; poate fi conectat firul de extindere al ASAHI INTECC, iar lungimea totală după conectare este de 355-400 cm.



Indicații pentru utilizare

Acest fir de ghidaj este destinat intervenției coronariene percutanate (PCI) generale. Acesta poate fi utilizat pentru a introduce și poziționa catetere de dilatare cu balon și alte dispozitive de intervenție în interiorul sistemului cardiovascular.

Acest fir de ghidaj nu este destinat utilizării în sistemul neuro-vascular și în sistemul vascular periferic.

Contraindicații

- Confirmați compatibilitatea diametrului firului de ghidaj cu alt dispozitiv de intervenție înainte de utilizarea efectivă.
- Nu folosiți firul de ghidaj la pacienții care au o reacție alergică la substanța de contrast sau care prezintă tulburări renale.
- Acest fir de ghidaj conține PEG400 în stratul său de acoperire hidrofili. Nu utilizați firul de ghidaj la pacienții care au reacții alergice la polietilenglicol (PEG).
- Nu utilizați firul de ghidaj la pacientele gravide sau la pacientele care ar putea fi gravide (razele X pot afecta fătul).
- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat într-o instituție în care se poate efectua imediat intervenții chirurgicale de urgență. În cazul în care o intervenție chirurgicală de urgență nu este posibilă, în cel mai rău caz, pot apărea evenimente care pun viața în pericol.
- Acest fir de ghidaj este pre-sterilizat cu gaz de oxid de etilenă (EOG) și este destinat unei singure utilizări. A nu se reutiliza sau resteriliza. Dacă este reutilizat sau resterilizat, performanța sau calitatea acestui fir de ghidaj poate fi compromisă și există riscul apariției unor complicații, inclusiv a unei infecții.

Avertismente

- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat numai de către un medic care este pe deplin instruit în tratamentul pacienților supuși intervenției coronariene percutanate (PCI).
- Nu utilizați niciodată acest fir de ghidaj în combinație cu catetere care au părți metalice care pot intra în contact direct cu suprafața acestui fir de ghidaj (de exemplu, catetere de aterectomie, dilatoare metalice), ace metalice sau inserții cu învelișuri placute cu metal.
- În timpul utilizării firului de ghidaj, verificați și monitorizați mișcarea vârfului acestuia sub fluoroscopie. A nu se utiliza în zone ale vasului care nu sunt sau nu pot fi vizualizate.
- A nu se conecta acest fir de ghidaj cu fire de extensie detașabile produse de alți producători decât ASAHI INTECC. A nu se manevra acest fir de ghidaj în timp ce firul de extensie detașabil este conectat. În caz contrar, firul de ghidaj se poate deteriora sau firul de extensie detașabil se poate desprinde involuntar.
- A nu se modifica acest fir de ghidaj pentru niciun motiv.

Precauții

- A nu se folosi firul de ghidaj după data de expirare indicată pe etichetă. Aruncați orice fir de ghidaj care depășește data de expirare.
- Firele de ghidaj sunt instrumente delicate și trebuie manevrate cu grijă.
- Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, nu folosiți firul de ghidaj. A nu se deschide ambalajul decât cu puțin timp înainte de utilizare. Folosiți o tehnică aseptică la manevrarea și utilizarea firului de ghidaj.
- Păstrați întotdeauna firul de ghidaj în stare umedă pentru a preveni deteriorarea stratului său de acoperire hidrofili.
- Nu ștergeți acest fir de ghidaj folosind o soluție organică, cum ar fi alcoolul.
- Luați măsuri de prevenire a infecțiilor după utilizare. Aruncați acest fir de ghidaj și ambalajul ca deșeu medical.
- Nu împingeți, nu trageți, nu retrageți și nu răsuciți niciodată acest fir de ghidaj care întâmpină rezistență. Răsucirea sau împingerea acestui fir de ghidaj care întâmpină rezistență poate provoca deteriorarea și/sau separarea vârfului acestui fir de ghidaj sau deteriorarea directă a unui vas. În caz contrar, acest fir de ghidaj poate fi deteriorat. Determinați cauza rezistenței sub fluoroscopie și luați orice măsură de remediere necesară.
- Intotdeauna introduceți sau retrageți firele de ghidaj încet și cu atenție.
- Atunci când răsuciți acest fir de ghidaj în interiorul vasului de sânge, nu răsuciți în mod continuu în aceeași direcție. Atunci când răsuciți firul de ghidaj, rotiți-l alternativ în sensul acelor de ceasornic și în sens invers. Nu efectuați mai mult de două rotații (720°) în aceeași direcție.
- Spălați firul de ghidaj cu soluție salină heparinizată și sterilizată sau cu o altă soluție potrivită în timp ce îl scoateți și îl reintroduceți pentru a preveni pătrunderea aerului în

dispozitivul de intervenție. Efectuați schimbarea acestui fir de ghidaj cu atenție pentru a preveni pătrunderea aerului și/sau traumatisme. Când reintroduceți firul de ghidaj, confirmați că vârful dispozitivului de intervenție nu este blocat în lumenul vasului și nu se sprijină pe perețele vasului. În caz contrar, se pot produce traumatisme. Utilizați marker-ul radioopac al dispozitivului de intervenție pentru a confirma poziția.

- Mișcarea liberă a firului de ghidaj în cadrul dispozitivului de intervenție este o caracteristică importantă a unui sistem de fire de ghidaj dirijabile, deoarece oferă utilizatorului informații tactile valoroase. Testați sistemul pentru a detecta orice rezistență înainte de utilizare. Reglați sau înlocuiți valva hemostatică cu o valvă reglabilă dacă se constată că aceasta împiedică mișcarea firului de ghidaj.
- Nu efectuați plasarea stentului folosind mai mult de un fir de ghidaj sau operația cu fire prin suportul stentului. În caz contrar, stentul poate fi deteriorat sau firul de ghidaj se poate rupe sau desprinde.
- Înainte de utilizare, confirmați că acest fir de ghidaj este adecvat ca dimensiune și formă pentru procedură și este compatibil cu dispozitivul care urmează să fie utilizat în combinație.

- Consultați instrucțiunile de utilizare atașate dispozitivului medical (de exemplu, catetere de dilatare cu balon sau alte dispozitive de intervenție) care urmează să fie utilizate în combinație cu acest fir de ghidaj.
- Atunci când conectați firul de extensie detașabil cu acest fir de ghidaj, acesta trebuie să fie introdus în siguranță până la linia de demarcație dintre stratul de acoperire fără PTFE și stratul de acoperire cu PTFE de la capătul proximal al firului de ghidaj. În cazul în care se constată orice anomalie la conectare, întrerupeți imediat utilizarea firului de ghidaj.
- Inspectați cu atenție firul de ghidaj pentru a vedea dacă există îndoiri, noduri sau alte deteriorări înainte de utilizare și ori de câte ori este posibil în timpul procedurii. Nu utilizați firul de ghidaj dacă este deteriorat.
- Atunci când modelați vârful, aveți grijă să nu deteriorați bobina.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj, verificați care este capătul distal și asigurați-vă că îl introduceți de la capătul distal.
- Asigurați o clătire continuă cu soluție salină între cateterul de ghidaj și dispozitivul de intervenție și între dispozitivul de intervenție și firul de ghidaj în timpul procedurii. Clătirea previne formarea substanței de contrast și/sau formarea de cheaguri pe firul de ghidaj și în lumenul cateterului.

Defecțiuni și efecte adverse

Posibilele defecțiuni și efecte adverse cauzate de utilizarea acestui fir de ghidaj includ, dar nu se limitează la următoarele:

1. Defecțiuni

Imposibilitatea de a străbate o leziune	Ruperea sau îndoirea firului de ghidaj	Deteriorări, cum ar fi separarea
Dificultăți la îndepărtare	Desprinderea stratului de acoperire	

2. Efecte adverse

Deces	Infecții	Disecția vaselor
Perforarea vaselor	Complicații hemoragice	Embolie
Dezvoltarea trombolor	Infarct	Ischemie
Aritmie	Spasm vascular	Ocluzii vasculare
Scăderea tensiunii arteriale	Reacții alergice	Resturi

Mod de utilizare

1. Inspectia înainte de utilizare

- Înainte de utilizare, inspectați cu atenție și confirmați că firul de ghidaj și ambalajul nu sunt deteriorate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că firul de ghidaj este compatibil cu dispozitivele de intervenție care urmează să fie utilizate.

2. Pregătirea

- Selecția cel mai potrivit fir de ghidaj pentru zona afectată și îndepărtarea tubului suport care conține firul de ghidaj din ambalajul steril.
- Umpleți tubul de suport cu soluție salină

Fir de ghidaj (capătul proximal)

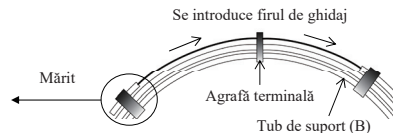
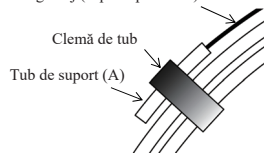


Figura 1

- Atunci când capătul distal al firului de ghidaj se extinde cu mai mult de 4 cm dincolo de celălalt capăt al tubului de suport, dacă este necesar, modelați vârful în conformitate cu practica standard.
- Prindeți ușor firul de ghidaj care a ieșit din capătul distal al tubului de suport, în punctul cât mai apropiat de tubul de suport și extrageți firul de ghidaj încet și cu grijă.
- Dacă la scoaterea firului de ghidaj din tubul de suport se întâmpină rezistență, se injectează din nou soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport. Continuați să îndepărtați firul de ghidaj după ce nu mai întâmpinați rezistență. Asigurați-vă că injectați suficientă soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport, deoarece stratul de acoperire hidrofil poate fi deteriorat atunci când îndepărtați cu forță firul de ghidaj căpușit.
- După ce ați extras firul de ghidaj din tubul de suport, inspectați-l pentru a vă asigura că nu este deteriorat.

3. Proceduri de inserție

- Sistem cu cateter peste firul de ghidaj

- heparinizată și sterilizată cu ajutorul unei seringi pentru a îmbiba întregul dispozitiv. Rețineți că soluția salină heparinizată și sterilizată se poate vărsa din tubul de suport în acest moment.
- Umpleți lumenul dispozitivului de intervenție cu soluție salină heparinizată și sterilizată înainte de a introduce firul de ghidaj.
- Eliberați firul de ghidaj din agrafă terminală și introduceți-l încet, împingeți capătul distal al firului de ghidaj prin tubul de suport (B). (Figura 1)

- Introduceți cu grijă capătul distal al firului de ghidaj în lumenul firului de ghidaj al dispozitivului de intervenție.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj, asigurați-vă că vârful său este chiar în apropierea vârfului dispozitivului de intervenție.
- Conectați cateterul de ghidaj și introduceți sistemul dispozitivului de intervenție (cu firul de ghidaj) în conectorul în Y.
- Înainte de a introduce dispozitivul de intervenție prin cateterul de ghidaj până când vârful sistemului cu fir de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
- Strângeți valva hemostatică a conectorului în Y pentru a crea o etanșare în jurul dispozitivului de intervenție. Asigurați-vă că mișcarea firului de ghidaj este încă posibilă.
- Verificați dacă firul de ghidaj se mișcă fără probleme.
- Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.
- Înainte de a insera firul de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu

ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.

- i) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
- j) Înaintați dispozitivul de intervenție până când se ajunge la leziune, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

■ Sistem de schimbare rapidă

- a) Conectați cateterul de ghidaj.
- b) Inserați liderul firului de ghidaj în conectorul în Y al cateterului de ghidaj.
- c) Introduceți cu grijă vârful firului de ghidaj în lider.
- d) Înaintați firul de ghidaj prin cateterul de ghidaj sub fluoroscopie până când vârful firului de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
- e) Atașați dispozitivul de torsiune la firul de ghidaj, dacă este necesar.

f) Înaintați firul de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.

- g) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
- h) Îndepărtați dispozitivul de torsiune a firului de ghidaj și liderul firului de ghidaj.
- i) Urmăriți dispozitivul de intervenție peste firul de ghidaj, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj, și avansați până când se ajunge la leziune. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

4. Proceduri de schimbare a firului de ghidaj

■ Sistem cu cateter peste firul de ghidaj

- a) Îndepărtați încet acest fir de ghidaj în timp ce monitorizați mișcarea acestuia sub fluoroscopie.
- b) Inserați următorul fir de ghidaj în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune "Instrucțiuni de utilizare".

Metoda de depozitare

Nu păstrați firul de ghidaj și ambalajul în stare îndoită și/sau în condiții de sarcini foarte mari. Acest fir de ghidaj și ambalajul trebuie păstrate departe de apă. Depozitați-le într-un loc răcoros, întunecat și uscat.

Data de expirare

Data de expirare este indicată pe eticheta ambalajului firului de ghidaj.

Conținut

5 bucăți / cutie

Clauza privind exonerarea de răspundere

În niciun caz "ASAHI INTECC CO., LTD. și companiile sale afiliate" (denumite în continuare "Compania") nu vor fi răspunzătoare pentru accidente, vătămări corporale, reacții adverse datorate utilizării necorespunzătoare a produsului (produselor) sau oricărei alte utilizări neconforme cu aceste instrucțiuni. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune (i) care rezultă din depozitarea produsului (produselor) după expedierea de către Companie sau (ii) datorate selecției pacienților, tehnicilor chirurgicale sau oricăror alte activități medicale desfășurate de către instituția medicală care utilizează produsul (produsele).

"ASAHI Gaia Next" este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a ASAHI INTECC CO.,LTD. în Japonia și în alte țări.

ASAHI Gaia Next Vodilna žica PCI

Navodila za uporabo

Pred uporabo te vodilne žice natančno preberite ta navodila in upoštevajte razdelke Indikacije za uporabo, Kontraindikacije, Opozorila, Previdnostni ukrepi in Kako se uporablja v teh navodilih za uporabo. Če tega ne storite, lahko pride do zapletov, vključno z resnimi poškodbami bolnika ali smrtjo.

Če uporabnik ali bolnik izve za resen incident, ki se je zgodil v zvezi z vodilno žico, o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ.

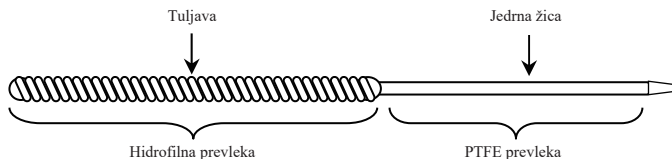
Ta navodila za uporabo veljajo za ASAHI Gaia Next. Za podrobnosti (dolžina vodilne žice, dolžina radioopačnega odseka itd.) glejte etiketo izdelka.

Opisi

Ta vodilna žica je vodljiva vodilna žica z oblikovano konico in je na voljo v predhodno oblikovanih različicah. Zunanji premer vodilne žice je 0,36 mm (0,014 palca). Ta vodilna žica je združljiva z obstoječimi balonskimi dilatacijskimi katetri in drugimi intervencijskimi pripomočki, ki se uporabljajo pri običajnem perkutanem koronarnem posegu (PCI). Distalni del konice vodilne žice je radioopačen.

Zaradi mazljivosti je distalni del naprave prevlečen s hidrofilnim polimerom, proksimalni del vodilne žice pa s politetrafluoretilenom (PTFE).

Na proksimalnem koncu pripomočka, ki je manjši od 300 cm, je priključek za podaljševalno žico, ki se uporablja za zamenjavo kombiniranega pripomočka. Podaljševalno žico ASAHI INTECC lahko priključite in skupna dolžina po priključitvi pa je 355-400 cm.



Indikacije za uporabo

Ta vodilna žica je namenjena splošnemu perkutanemu koronarnemu posegu (PCI). Lahko se uporablja za uvajanje in namestitev balonskih dilatacijskih katetrov in drugih intervencijskih pripomočkov v kardiiovaskularni sistem.

Ta vodilna žica ni namenjena uporabi v nevrovaskularnem sistemu in v perifernem vaskularnem sistemu.

Kontraindikacije

- Pred dejansko uporabo potrdite združljivost premera vodilne žice z drugimi intervencijskimi pripomočki.
- Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali imajo oslabljeno delovanje ledvic.

- Ta vodilna žica vsebuje PEG400 v svoji hidrofilni prevleki. Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Vodilne žice ne uporabljajte pri nosečih bolnicah ali bolnicah, ki bi lahko bile noseče (rentgensko slikanje lahko vpliva na plod).
- To vodilno žico je treba uporabiti v ustanovi, kjer je mogoče takoj izvesti nujni kirurški poseg. Če nujni kirurški poseg ni na voljo, lahko v

najslabšem primeru pride do smrtnih nevarnih dogodkov.

- Ta vodilna žica je predhodno sterilizirana s plinom etilen oksidom (EOG) in je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno ali ponovno sterilizirajte. Pri ponovni uporabi ali ponovni sterilizaciji je lahko učinkovitost ali kakovost te vodilne žice ogrožena in obstaja tveganje zapletov, vključno z okužbo.

Opozorila

- To vodilno žico sme uporabljati le zdravnik, ki je v celoti usposobljen za zdravljenje PCI.
- Nikoli ne uporabljajte te vodilne žice v kombinaciji s katetri, ki imajo kovinske dele, ki bi lahko pršli neposredno v stik s površino te vodilne žice (npr. katetri za aterektomijo, kovinski dilatatorji), kovinskimi iglami ali uvaljalniki iz kovinskega ovoja.
- Med uporabo vodilne žice preverite in spremljajte gibanje njene konice pod fluoroskopijo. Ne uporabljajte na območjih žile, ki niso vidna ali jih ni mogoče videti.
- Te vodilne žice ne povežite s snemljivimi podaljševalnimi žicami, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki niso ASAHI INTECC. Ne manipulirajte s to vodilno žico, medtem ko je snemljiva podaljševalna žica priključena. V nasprotnem primeru se lahko vodilna žica poškoduje ali pa se snemljiva podaljševalna žica nenamerno sname.
- Ne spreminjajte te vodilne žice iz kakršnega koli razloga.

Previdnostni ukrepi

- Vodilne žice ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na etiketi. Zavrzite vse vodilne žice, katerim je potekel rok uporabe.
- Vodilne žice so občutljivi instrumenti, zato je treba z njimi ravnati previdno.
- Vodilne žice ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Embalažo odprite šele tik pred uporabo. Pri rokovanju in uporabi vodilne žice uporabljajte aseptično tehniko.
- Vodilna žica naj bo vedno mokra, da preprečite poškodbe njene hidrofilne prevleke.
- Ne brišete vodilne žice z organsko raztopino, kot je alkohol.
- Po uporabi izvajajte preventivne ukrepe proti okužbam. To vodilno žico in embalažo zavrzite kot medicinske odpadke.
- Te vodilne žice, ki naleti na upor, nikoli ne potiskajte, vlečite, izvlecite ali zasukajte. Vrtenje ali potiskanje te vodilne žice proti upor lahko povzroči poškodbe in/ali ločitev konice te vodilne žice ali neposredno poškodbo žile. Če tega ne storite, lahko poškodujete to vodilno žico. Ugotovite vzrok upora pod fluoroskopijo in izvedite vse potrebne popravne ukrepe.
- Vodilne žice vedno premikajte ali izvlecite počasi in previdno.
- Ko zasukate to vodilno žico znotraj krvne žile, je ne vrtite neprekinjeno v isto smer. Ko zasukate vodilno žico, jo izmenično vrtite v smeri urinnega kazalca in v nasprotni smeri urinnega kazalca. Ne zavrtite za več kot dva obrata (720°) v isto smer.
- Med odstranjevanjem in ponovnim uvajanjem vodilno žico sperite s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino ali drugo primerno raztopino, da preprečite vstop zraka v intervencijski pripomoček. Pazljivo zamenjajte to vodilno žico, da preprečite vstop zraka in/ali poškodbe. Pri ponovnem uvajanju vodilne žice se prepričajte, da je konica intervencijskega pripomočka prosta v lumnu žile in ni ob steni žile. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb. Uporabite radioopačni označevalec na intervencijskem pripomočku, da potrdite položaj.
- Prosto gibanje vodilne žice znotraj intervencijskega pripomočka je pomembna značilnost vodljivega sistema vodilne žice, saj daje uporabniku dragocene občutljive informacije. Pred uporabo preizkusite sistem glede kakršnega koli upora. Prilagodite ali

zamenjajte ventil za hemostazo z nastavljljivim ventilom, če ugotovite, da zavira gibanje vodilne žice.

- Ne izvajajte nameščanja stenta z uporabo več kot ene vodilne žice ali postopka z žico skozi opornik stenta. V nasprotnem primeru se lahko stent poškoduje ali pa se vodilna žica zlomi ali razpade.
- Pred uporabo se prepričajte, da je ta vodilna žica po velikosti in obliki primerna za postopek in je združljiva s pripomočkom, s katerim jo boste uporabljali.
- Glejte navodila za uporabo, ki so priložena medicinskemu pripomočku (npr. balonskim dilatacijskim katetrom ali drugim intervencijskim pripomočkom), ki ga želite uporabiti v kombinaciji s to vodilno žico.
- Pri povezovanju snemljive podaljševalne žice s to vodilno žico mora biti ta varno vstavljena na mejno črto med prevleko brez PTFE in prevleko

iz PTFE na proksimalnem koncu vodilne žice. Če opazite kakršno koli nepravilnost v povezavi, takoj prenehajte uporabljati vodilno žico.

- Pred uporabo in med postopkom, kadar koli je to mogoče, skrbno pregledajte vodilno žico glede prepognjenosti, pregibov ali drugih poškodb. Ne uporabljajte vodilne žice, če je poškodovana.
- Pri oblikovanju konice pazite, da ne poškodujete tuljave.
- Pred uvajanjem vodilne žice, preverite, kateri konec je distalni konec, in poskrbite, da jo uvedete z distalnega konca.
- Med postopkom vzdržujte neprekinjeno izpiranje s fiziološko raztopino med vodilnim katetrom in intervencijskim pripomočkom ter med intervencijskim pripomočkom in vodilno žico. Izpiranje prepreči nastanek kontrastnega sredstva in/ali strjevanje na vodilni žici in v lumnu katetra.

Motnje delovanja in neželeni učinki

Možne motnje delovanja in škodljivi učinki zaradi uporabe te vodilne žice vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:

1. Motnje delovanja

Nezmožnost prehoda lezije	Zlom ali upogibanje vodilne žice	Poškodba kot je ločevanje
Težave pri odstranjevanju	Odstopanje prevleke	

2. Neželeni učinki

Smrt	Okužba	Disekcija žil
Perforacija žil	Zapleti krvavenja	Embolija
Strdek	Infarkt	Ishemija
Aritmija	Vazospazem	Vaskularna okluzija
Znižanje krvnega tlaka	Alergijska reakcija	Preostalo

Kako se uporablja

1. Pregled pred uporabo

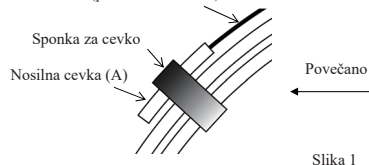
- Pred uporabo natančno pregledajte in se prepričajte, da sta vodilna žica in embalaža nepoškodovani.
- Pred uporabo preverite, če je vodilna žica združljiva z intervencijskimi pripomočki, ki jih boste uporabili.

2. Priprava

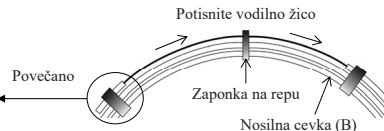
- Izberite najprimernejšo vodilno žico za prizadeto območje in odstranite nosilno cevko, ki vsebuje vodilno žico iz sterilnega ovoja.
- Z brzo napolnite nosilno cevko s heparinirano in sterilizirano fiziološko raztopino, da namočite celotni pripomoček. Upoštevajte, da se lahko heparinizirana in sterilizirana fiziološka raztopina v tem času razlije iz nosilne cevke.

- Preden vstavite vodilno žico, napolnite lumen intervencijskega pripomočka s heparinirano in sterilizirano fiziološko raztopino.
- Sprostite vodilno žico iz zaponke na repu in

Vodilna žica (proksimalni konec)



počasi potisnite vodilno žico, potisnite distalni konec vodilne žice skozi nosilno cevko (B). (Slika 1)



Slika 1

- Ko je distalni konec vodilne žice podaljšán več kot 4 cm čez drugi konec nosilne cevke, po potrebi oblikujte konico v skladu s standardno prakso.
- Vodilno žico, ki je izšla iz distalnega konca nosilne cevke, nežno primite na mestu, ki je čim bližje nosilni cevki, in počasi in previdno izvlecite vodilno žico.
- Če pri odstranjevanju vodilne žice iz nosilne cevke začutite upor, ponovno vbrizgajte heparinirano in sterilizirano fiziološko raztopino v nosilno cevko. Nadaljujte z odstranjevanjem vodilne žice, ko ni več čutiti upora. Prepričajte se, da ste v nosilno cevko vbrizgali dovolj heparinirane in sterilizirane fiziološke raztopine, ker se lahko hidrofilna prevleka poškoduje, ko na silo odstranite prevlečeno vodilno žico.
- Ko vodilno žico izvlečete iz nosilne cevke, jo pregledajte, da se prepričate, da ni poškodovana.

3. Postopki za uvajanje

- Sistem preko žice
 - Distalni konec vodilne žice previdno uvajajte v lumen vodilne žice intervencijskega pripomočka.
 - Previdno pomaknite to vodilno žico, dokler ni njena konica tik proksimalno od konice intervencijskega pripomočka.
 - Vstavite vodilni kateter in uvedite sistem intervencijskega pripomočka (z vodilno žico) v priključek Y.
 - Pomaknite sistem intervencijskega pripomočka skozi vodilni kateter, dokler konica sistema vodilne žice ni tik proksimalno od konice vodilnega katetra.

- Zategnite ventil za hemostazo priključka Y, da ustvarite tesnjenje okoli intervencijskega pripomočka. Prepričajte se, da je premikanje vodilne žice še dovoljeno.
- Preverite, če se vodilna žica premika gladko.
- Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- Pomaknite to vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- Pomaknite intervencijski pripomoček naprej, dokler ne dosežete lezije, pri tem pa preprečite premikanje vodilne žice. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

■ Sistem hitre menjave

- Vstavite vodilni kateter.
- Uvajalnik vodilne žice vstavite v priključek Y vodilnega katetra.
- Konico vodilne žice previdno vstavite v uvajalnik.
- Pomaknite vodilno žico skozi vodilni kateter pod fluoroskopijo, dokler ni konica vodilne žice tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- Pomaknite vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno

lezijo.

g) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.

h) Odstranite navorno napravo vodilne žice in uvajalnik vodilne žice.

i) Sledite intervencijskemu pripomočku preko vodilne žice, medtem ko preprečujete premikanje vodilne žice, in pomikajte, dokler ne dosežete lezije. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z

intervencijskim pripomočkom.

4. Postopki za zamenjavo vodilne žice

■ Sistem preko žice

a) Počasi odstranite to vodilno žico, medtem ko spremljate gibanje te vodilne žice pod fluoroskopijo.

b) Uvedite naslednjo vodilno žico v skladu z navodili v tem razdelku »Kako se uporablja«.

Način shranjevanja

Vodilne žice in embalaže ne hranite v upognjenem in/ali močno obremenjenem stanju. Ta vodilna žica in embalaža ne smeta biti v vodi. Hraniti v hladnem, temnem in suhem prostoru.

Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je naveden na etiketi embalaže vodilne žice.

Vsebina

5 kosov/škatla

Zavrnitev odgovornosti

Podjetje »ASAHI INTECC CO., LTD. in njegova pridružena podjetja« (v nadaljevanju »podjetje«) ne odgovarjajo za nesreče, telesne poškodbe, škodljive učinke zaradi kakršne koli nepravilne uporabe izdelka(-ov) ali katere koli druge uporabe, ki ni v skladu s temi navodili. Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za kakršno koli škodo bodisi (i) zaradi shranjevanja izdelka(-ov) po odpremi iz podjetja bodisi (ii) zaradi izbire bolnikov, kirurških tehnik ali katere koli druge zdravstvene dejavnosti s strani zdravstvene ustanove, ki uporablja izdelek(-e).

»ASAHI Gaia Next« je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja ASAHI INTECC CO.,LTD. na Japonskem in v drugih državah.

ASAHI Gaia Next Wajer Gwida PCI

Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra dawn l-istruzzjonijiet b'attenzjoni qabel ma tuża dan il-wajer gwida u osserva t-taqsimiet Indikazzjonijiet għall-Użu, Kontraindikazzjonijiet, Twissijiet, Prekawzzjonijiet, u Kif Tuża l-Prodott f'dawn l-istruzzjonijiet għall-użu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta f'kumplikazzjonijiet, inkluż korrimment serju għall-pazjent jew mewt.

Jekk utent jew pazjent isir jaf dwar incident serju li sehh b'rabta mal-wajer gwida, dan għandu jirrapporta l-fatt lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.

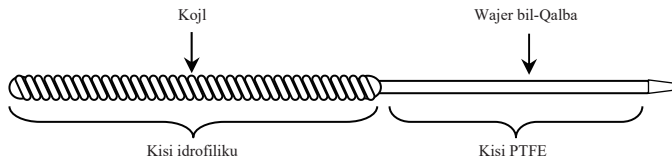
Dawn l-Istruzzjonijiet għall-użu japplikaw għal ASAHI Gaia Next. Għal dettalji (tul tal-wajer gwida, tul tas-sezzjoni radjopaka, eċċ.), irreferi għal-tikketta tal-prodott.

Deskrizzjonijiet

Dan il-wajer gwida huwa wajer gwida orjentabbli b'ponta li tista' tinghata forma, u huwa disponibbli f'varjanti preformati. Id-dijametru ta' barra tal-wajer gwida huwa ta' 0.36 mm (0.014 pulzier). Dan il-wajer gwida huwa kompatibbli ma' kateters tad-dilatazzjoni bil-bużżieqa eżistenti u ma' apparati ta' intervent ohrajn li jintużaw f'interventi koronarji perkutanji (PCI) komuni. Il-porzjon distali tal-ponta tal-wajer gwida huwa radjopak.

Għal-lubriċità, il-porzjon distali tal-apparat huwa miksi b'polimer idrofili u l-porzjon prossimali tal-wajer gwida huwa miksi bil-politetrafluoroetilen (PTFE).

Fit-tarf prossimali tal-apparat, li huwa iqsar minn 300 cm, hemm konnessjoni għal wajer ta' estensjoni, li jintuża biex jissostitwixxi l-apparat ikkombinat; il-Wajer ta' Estensjoni ta' ASAHI INTECC jista' jiġi konness, u t-tul totali wara l-konnessjoni huwa ta' 355-400 cm.



Indikazzjonijiet għall-użu

Dan il-wajer gwida huwa maħsub għal interventi koronarji perkutanji (PCI) ġenerali. Jista' jintuża biex jintroduċi u jippożizzjona kateters tad-dilatazzjoni bil-bużżieqa u apparati ta' intervent ohrajn fil-kardjovaskulatura.

Dan il-wajer gwida ma huwiex maħsub għall-użu fin-newrovaskulatura u fil-vaskulatura periferika.

Kontraindikazzjonijiet

- Ikkonferma l-kompatibbiltà tad-dijametru tal-wajer gwida ma' apparati ta' intervent ohrajn qabel l-użu proprju.
- Tużax il-wajer gwida f'pazienti b'reazzjoni allergika għal aġenti ta' kontrast radjografiku jew li għandhom insuffiċjenza renali.

- Dan il-wajer gwida fih PEG400 fil-kisi idrofili u tiegħu. Tużax il-wajer gwida f'pazienti b'reazzjoni allergika għall-polietilenglikol (PEG).
- Tużax il-wajer gwida għal pazienti tqal jew pazienti li jistgħu jkun tqal (ir-raġġ X jistgħu jaffettwaw lill-fetu).
- Dan il-wajer gwida għandu jintuża f'istituzzjoni fejn tista' titwettagħ operazzjoni kirurġika ta' emerġenza minnufih. Jekk operazzjoni kirurġika ta' emerġenza ma tkunx disponibbli, fl-aġar

xenarju possibbli, jistgħu jsejtnu avvenimenti li jheddu l-hajja.

- Dan il-wajer gwida huwa sterilizzat minn qabel bil-gass tal-ossidu etilen (EOG) u huwa maħsub biex jintuża darba biss. Tergax tuża jew tisterilizza mill-ġdid. Jekk jerga' jintuża jew jiġi sterilizzat mill-ġdid, il-prestazzjoni jew il-kwalità ta' dan il-wajer gwida jistgħu jiġu kompromessi u hemm riskju ta' kumplikazzjonijiet, inkluż l-infezzjoni.

Twissijiet

- Dan il-wajer gwida għandu jintuża biss minn tabib li huwa kompletament imharreġ fit-trattament PCI.
- Qatt tuża dan il-wajer gwida flimkien ma' kateters b'partijiet tal-metall li jistgħu jiġu f'kontatt dirett mal-wiċċ ta' dan il-wajer gwida (eż. kateters tal-ateretomija, dilators tal-metall), labar tal-metall jew apparat tal-metall għall-inserzjoni tal-għantijiet.
- Waqt l-użu tal-wajer gwida, i-verifika u ssorvelja l-moviment tal-ponta tiegħu permezz tal-fluoroskopija. Tużax f'żoni ta' važi li ma humiex jew ma jistgħux jiġu viżwalizzati.
- Tikkonnettjaq dan il-wajer gwida ma' wajers ta' estensjoni li jinqalghu prodotti minn manifatturi għajr ASAHI INTECC. Timmanipulaq dan il-wajer gwida waqt li jkun konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala'. Jekk le, il-wajer gwida jista' jsirli l-hsara, jew il-wajer ta' estensjoni li jinqala' jista' jinqala' involontarjament.
- Timmodifikaq dan il-wajer gwida għall-ebda raġuni.

Prekawzzjonijiet

- Tużax il-wajer gwida wara d-data ta' skadenza indikata fuq it-tikketta. Armi kwalunkwe wajer gwida li jaqbeż din id-data ta' skadenza.
- Il-wajers gwida huma strumenti delikati u għandhom jiġu mmanigġjati b'attenzjoni.
- Jekk il-pakkett ikun miftuħ jew dannegġat, tużax il-wajer gwida. Iflah il-pakkett biss eżatt qabel l-użu. Uża teknika asettika għall-immaniġġjar u l-użu tal-wajer gwida.
- Dejjem żomm il-wajer gwida fi stat imxarrab biex tipprevjeni l-hsara għall-kisi idrofili u tiegħu.
- Timsaħx dan il-wajer gwida b'soluzzjoni organika bħall-alkohol.
- Hu miżuri preventivi kontra l-infezzjoni wara l-użu. Armi dan il-wajer gwida u l-pakkett mal-iskart mediku.
- Qatt timbotta, tittrapanja, tiġbed jew iddawwar dan il-wajer gwida jekk issib rezistenza. It-tidwir jew l-imbottar ta' dan il-wajer gwida meta juri rezistenza jista' jikkawża hsara u/jew iseparazzjoni tal-ponta ta' dan il-wajer gwida jew hsara diretta lil važu. Jekk dan ma jsirx, tista' ssir hsara lil dan il-wajer gwida. Iddetermina l-kawża tar-reżistenza bl-użu tal-fluoroskopija u hu kwalunkwe azzjoni rimedjali meħtieġa.
- Dejjem mexxi l-wajers gwida l'quddiem jew lura bil-mod u b'attenzjoni.
- Meta ddawwar dan il-wajer gwida ġewwa l-važu, iddawwar kontinwament fl-istess direzzjoni. Meta ddawwar il-wajer gwida, alterna bejn tidwir skont l-arloġġ u kontra l-arloġġ. Iddawwar aktar minn żewġ rotazzjonijiet (720°) fl-istess direzzjoni.
- Naddaf il-wajer gwida b'soluzzjoni salina jew soluzzjoni xierqa oħra eparinizzata u sterilizzata waqt li tnehhix u terġa' ddahhlu sabiex tipprevjeni milli tidhol l-arja fl-apparat ta' intervent. Skambja dan il-wajer gwida b'attenzjoni biex tipprevjeni dħul tal-arja u/jew trauma. Meta tintroduċi l-wajer gwida mill-ġdid, ikkonferma li l-ponta tal-apparat ta' intervent huwa hieles ġewwa l-lumen tal-važu u li mhux qed imiss mal-ġenb tal-važu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta fi trauma. Uża l-markatur radjopak tal-apparat ta' intervent biex tikkonferma l-pożizzjoni.
- Il-moviment hieles tal-wajer gwida fl-apparat ta' intervent huwa karatteristika importanti ta' sistema ta' wajer gwida orjentabbli għaliex jagħti lill-utent informazzjoni tattili ta' valur. Ittestja s-sistema għal kwalunkwe rezistenza qabel l-użu.

Aġġusta jew issostitwixxi l-valvola emostatika b'valvola aġġustabbli jekk tinsab li tostakola l-moviment tal-wajer gwida.

- Tqeghid stent bl-użu ta' aktar minn wajer gwida wiehied jew operazzjoni ta' wajer waħda bl-użu ta' stent strut. Jekk le, tista' ssir hsara lill-istent jew il-wajer gwida jista' jtkisser jew jifarrak.
- Qabel l-użu, ikkonferma li dan il-wajer gwida huwa ta' daqs u forma xierqa għall-proċedura u li huwa kompatibbli mal-apparat li għandu jintuża flimkien miegħu.
- Irrefri għall-Istruzzjonijiet għall-Użu meħmuż mal-apparat mediku (eż. kateters tad-dilatazzjoni b'bużżeġa jew apparati ta' intervent oħrajn) li għandhom jintużaw flimkien ma' dan il-wajer gwida.
- Meta jiġi konness il-wajer ta' estensjoni li jinjala' ma' dan il-wajer gwida, għandu jiddaħhal b'mod sikur fil-linja konfinali bejn il-kisi mhux tal-

PTFE u l-kisi tal-PTFE fit-tarf prossimali tal-wajer gwida. Jekk tinstab xi anormalità fil-konnessjoni, waqqaf l-użu tal-wajer gwida minnufih.

- Spezzjona l-wajer gwida b'attenzjoni għal liwi, għoqiedi jew hsara oħra qabel l-użu u meta possibbli waqt il-proċedura. Tużax il-wajer gwida jekk ikun danneġġat.
- Meta tiffirma l-ponta, oqgħod attent li ma tagħmilx hsara lill-kojl.
- Qabel ma ddaħhal il-wajer gwida, iwwerifika liema tarf huwa t-tarf distali u kun ċert li ddaħhal mit-tarf distali.
- Zomm fluss tas-salina bejn il-kateter ta' gwida u l-apparat ta' intervent, u bejn l-apparat ta' intervent u l-wajer gwida waqt il-proċedura. Il-fluss jippreveni l-formazzjoni ta' aġent ta' kontrast radjografiku u/jew il-koagulażzjoni fuq il-wajer gwida u fil-lumen tal-kateter.

Hsarat u effetti avversi

Hsara u effetti avversi possibbli mill-użu ta' dan il-wajer gwida jinkludu, iżda ma humiex limitat għal dan li ġej:

1. Hsarat

Nuqqas ta' tislub ta' leżjoni	Ksur jew liwi tal-wajer gwida	Hsara bħal separazzjoni
Diffikultà fit-tnehhija	Tnehhija tal-kisi	

2. Effetti avversi

Mewt	Inftezzjoni	Dissezzjoni tal-vażu
Perforazzjoni tal-vażu	Kumplikazzjonijiet ta' emorraġġja	Embolizmu
Trombozi	Infart	Iskemija
Arritmija	Važospazmu	Okklużjoni vaskulari
Pressjoni baxxa	Reazzjoni allergika	Residwu

Kif Tużax l-prodott

1. Spezzjoni qabel l-użu

- Qabel l-użu, spezzjona b'attenzjoni u kkonferma li ma hemmx hsara fil-wajer gwida u fil-pakkett.
- Qabel l-użu, ikkonferma li l-wajer gwida huwa kompatibbli mal-apparati ta' intervent li għandhom jintużaw.

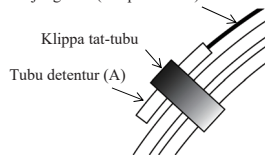
2. Preparazzjoni

- Aghżel l-aktar wajer gwida xieraq għaż-żona

- affettwata u neħhi t-tubu detentur li fih il-wajer gwida mill-pakkett sterili.
- Imla t-tubu detentur b'salina eparinizzata u sterilizzata bl-użu ta' siringa biex ixarrab l-apparat shih. Innota li s-salina eparinizzata u sterilizzata tista' t'fur mit-tubu detentur f'dan il-mument.
 - Imla l-lumen tal-apparat ta' intervent bis-salina eparinizzata u sterilizzata qabel ma ddaħhal il-wajer gwida.

d) Neħhi l-wajer gwida mill-klippa tat-tmim u żerżaq il-wajer gwida bil-mod, imbotta t-tarf

Wajer gwida (tarf prossimali)



distali tal-wajer gwida minn ġot-tubu detentur (B). (Figura 1)

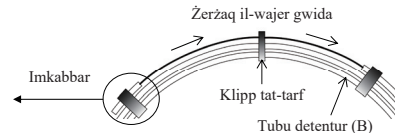


Figura 1

- Meta t-tarf distali tal-wajer gwida jiġi estiz aktar minn 4 cm lil hinn mit-tarf l-iehor tat-tubu detentur, jekk meħtieġ, ifforma l-ponta skont il-prassi standard.
- Aqbad il-wajer gwida li jkun hareġ mit-tarf distali tat-tubu detentur bil-mod, fl-eqreb punt possibbli għat-tubu detentur u iġbed il-wajer gwida 'l barra bil-mod u b'attenzjoni.
- Jekk tinhass rezistenza meta tneħhi l-wajer gwida mit-tubu detentur, erġa' injetta s-salina eparinizzata u sterilizzata fit-tubu detentur. Kompli neħhi l-wajer gwida wara li ma tibqax tinhass ir-reżistenza. Kun ċert li tinjetta biżżejjed salina eparinizzata u sterilizzata għat-tubu detentur għaliex tista' ssir hsara għall-kisi idrofili meta tneħhi l-wajer gwida miksi bis-sahha.
- Wara li tiġbed il-wajer gwida barra mit-tubu detentur, spezzjonah sabiex tkun ċert li ma hemmx hsara fih.

3. Proċeduri għall-inserzjoni

■ Sistema minn fuq il-wajer

- Dahhal it-tarf distali tal-wajer gwida b'attenzjoni fil-lumen tal-wajer gwida tal-apparat ta' intervent.
- Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem b'attenzjoni sakemm it-tarf tiegħu jkun biss prossimali għat-tarf tal-apparat ta' intervent.
- Qabbad il-kateter gwida u dahhal is-sistema tal-apparat ta' intervent (bil-wajer gwida) fil-konnettur Y.
- Mexxi s-sistema tal-apparat ta' intervent 'l quddiem minn ġol-kateter ta' gwida sakemm il-ponta tas-sistema tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- Issikka l-valvola emostatika tal-konnettur Y

- biex tohloq sigill madwar l-apparat ta' intervent. Kun ċert li l-movement tal-wajer gwida jkun għadu possibbli.
- Iwwerifika li l-wajer gwida jiċċaqraq mingħajr xkiel.
- Wahhal l-apparat tat-torque mal-wajer gwida jekk meħtieġ.
- Mexxi dan il-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluoroskopija biex jgħaddi minn ġol-leżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-añġjografija li l-wajer gwida jkun għadda mil-leżjoni ristretta fil-mira.
- Osserva l-movement tal-wajer gwida fil-važi.
- Mexxi l-apparat ta' intervent 'l quddiem sakemm tinklehaq il-leżjoni fil-waqt li tipprevjeni l-wajer gwida milli jiċċaqraq. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-važi jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

■ Sistema ta' skambju radiku

- Qabbad il-kateter gwida.
- Dahhal l-introduktur tal-wajer gwida fil-konnettur Y tal-kateter gwida.
- Dahhal il-ponta tal-wajer gwida b'attenzjoni fil-introduktur.
- Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem minn ġol-kateter ta' gwida bl-użu tal-fluoroskopija sakemm il-ponta tal-wajer gwida tkun biss prossimali għall-ponta tal-kateter gwida.
- Wahhal l-apparat tat-torque mal-wajer gwida jekk meħtieġ.
- Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluoroskopija biex jgħaddi minn ġol-leżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-añġjografija li l-wajer gwida jkun għadda mil-leżjoni

- ristretta fil-mira.
- g) Osserva l-moviment tal-wajer gwida fil-važi.
- h) Nehhi l-apparat tat-torque tal-wajer gwida u l-introduuttur tal-wajer gwida.
- i) Segwi l-apparat ta' intervent minn fuq il-wajer gwida sakemm tipprevjeni l-wajer gwida milli jimxi, u mexxi 'l quddiem sakemm tintlehaq il-leżjoni. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwida u l-pożizzjoni tagħha fil-važu jkunu viżibbli waqt il-

manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

4. Proċeduri għall-iskambju tal-wajer gwida
- Sistema minn fuq il-wajer
 - a) Nehhi dan il-wajer gwida bil-mod filwaqt li timmonitora l-moviment ta' dan il-wajer gwida bl-użu tal-fluworoskopija.
 - b) Dahhal il-wajer gwida li jmiss skont id-direzzjonijiet fit-taqsima "Kif Tuża l-Prodott".

Metodu ta' ħzin

Iżzommx il-wajer gwida u l-pakkett f'kundizzjoni milwija u/jew taht toqol kbir. Dan il-wajer gwida u l-pakkett għandhom jinżammu 'l bogħod mill-ilma. Ahżen f'post frisk, mudlam u niexef.

Data ta' skadenza

Id-data ta' skadenza hija indikata fuq it-tikketta tal-pakkett tal-wajer gwida.

Kontenut

5 biċċiet / kaxxa

Ċaħda ta' responsabbiltà

"ASAHI INTECC CO., LTD. u l-kumpaniji affiljati tagħha" (minn hawn 'il quddiem il-"Kumpanija") ma għandha bl-ebda mod tinżamm responsabbli għal inċidenti, danni personali, effetti avversi minhabba użu mhux tajjeb tal-prodott/i jew kwalunkwe użu ieħor li huwa inkonsistenti ma' dawn l-istruzzjonijiet. Il-Kumpanija fl-ebda ċirkostanza ma għandha tkun responsabbli għal xi danni li (i) jirriżultaw mill-ħżin tal-prodott/i wara l-konsenja tal-Kumpanija jew (ii) minhabba l-ghażla tal-pazjenti, it-tekniki tal-kirurgija, jew kwalunkwe attività medika mill-istituzzjonijiet medika li tuża l-prodott/i.

"ASAHI Gaia Next" hija trademark jew trademark irregistrata ta' ASAHI INTECC CO.,LTD. fil-Ġappun u f'pajjiżi oħra.



ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 JAPAN



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands

Basic UDI-DI:4547327DGW001NX
<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Country of origin for this product is indicated on the product label.



<https://medical.asahi-intecc.com/en>

©2023 ASAHI INTECC CO., LTD.
2024-02-19 (2nd edition)